



รายงานการประชุมการพัฒนาาระบบบัญชีแบบยั่งยืน ครั้งที่ 1/2561

วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30-12.00 น.

ณ สำนักงานราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย

ผู้มาประชุม

1 นพ.อนุชิต ปุณฺณทลฺลํ	ประธานราชวิทยาลัย
2 นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์	รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
3 นพ.อุดม ภู่วโรดม	สาธารณสุขนิเทศ กระทรวงสาธารณสุข
4 นพ.จักรกริช ใจศิริ	ผู้ช่วยเลขาธิการสสช.
5 นพ.ศุภชัย โชติบุตร	ผู้ทรงคุณวุฒิ
6 พญ.วัฒน์ ยืนจิตร	ผู้ทรงคุณวุฒิ
7 นพ.พรชัย สิมะโรจน์	ผู้ทรงคุณวุฒิ
8 นพ.จักรพงษ์ นมะมาตร	หัวหน้าภาควิชาจักษุวิทยา ศิริราชพยาบาล
9 นพ.วิชัย ประสาทฤทธา	หัวหน้าภาควิชาจักษุวิทยา รพ.รามธิบดี
10 นพ.ปริชญ์ ไรจนพงศ์พันธุ์	หัวหน้าภาควิชาจักษุวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11 พญ.สายจินต์ อีสี่ประดิษฐ์	รองประธานคณะกรรมการเขตสุขภาพ สาขาทา
12 นพ.อนุกุล ไทยถนอม	ผู้อำนวยการรพ.ปทุมธานี
13 นพ.ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์	ประธานวิชาการ
14 นพ.วรภัทร วงษ์สวัสดิ์	รพ.เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)
15 นพ.ยุทธพงษ์ อิมสุวรรณ	เลขาธิการราชวิทยาลัย
16 นพ.วีระวัฒน์ คิตติ	เลขานุการ อฝส. รจท.
17 คุณกุลนันท์ อัฐนา	นายกสมาคมพยาบาลเวชฯ
18 คุณฐานกาญจน์ สุขวิสิฐ	อุปนายกสมาคมพยาบาลเวชฯ
19 คุณอุบลรัตน์ นันทวิสิทธิ์	คณะกรรมการที่ปรึกษา สมาคมพยาบาลเวชฯ
20 คุณเอื้องพร พิทักษ์สังข์	ประธานชมรมพยาบาลและบุคลากรด้านจักษุไทย
ผู้เข้าร่วมประชุม	
1 นพ.ทยากร คุปกาญจนา	ม.ธรรมศาสตร์
2 นพ.พิชชา อัญมิล	ม.ธรรมศาสตร์
3 คุณพวงลักษณ์ กลิ่นกุหลาบ	กลุ่มยุทธศาสตร์ รพ.เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1: เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

ประธานที่ประชุม นำเสนอที่มาและแผนงานการพัฒนาระบบบัญชีแบบยั่งยืน ตามแนวนโยบายที่ความร่วมมือระหว่าง
ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย กับกระทรวงสาธารณสุข ให้ที่ประชุมรับทราบ (ตามเอกสารแนบ)

ระเบียบวาระที่ 2 : เรื่องเพื่อพิจารณา

ความเห็นที่ประชุม

- สรุปความเห็นจากทุกฝ่าย

- นพ.จักรกริช ใจศิริ (ผู้ช่วยเลขาธิการสภสข.)

สภสข.ได้แยกงบประมาณทางด้านจักษุไว้หลายรายการ โดยจัดทำแยกกัน ตั้งเป้าหมายตามรายการต่าง ๆ
ไว้ชัดเจน เช่น 1. การผ่าตัดต้อกระจก ใน 1 ปีจะทำให้ประมาณ 1 แสนกว่ารายซึ่งเป็นตัวเลขในปี 2560
โดยประมาณ สำหรับในปี 61 ยังต่ำกว่าเป้าหมายใน 3 เดือนแรกของปี หลังจากนั้นคณะกรรมการจะประชุม
เพื่อพิจารณาตั้งเป้าหมายกันใหม่โดยจะมีการปรึกษากับทาง Service Plan เพื่อเป้าหมายเดียวกันคือ
ร่วมกันลด blinding cataract ของคนไทย โดยการมองในภาพของการบริหารจัดการทั้งหมด โดยใช้ข้อมูล
ในอดีตตามเขตสุขภาพตามภาคต่าง ๆ มาประกอบรวมด้วย มิได้พิจารณาเรื่องงบประมาณแต่เพียงอย่าง
เดียว โดยทางสภสข.จะรับหน้าที่ไปชี้แจงกับองค์กรที่เกี่ยวข้องต่อไป

2. แว่นตาเด็ก ปี 59-60 ตั้งเป้าไว้แจก 20,000 อัน ยังไม่ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ กำลังปรับปรุงแนว
ทางการบริหารจัดการ

3. เรื่องการรักษาเบาหวานขึ้นจอตาเนื่องจากปริมาณการเบิกจ่ายไม่มาก จึงนำกลับเข้าระบบ DRG
กระทรวงสาธารณสุขและสภสข.สามารถ ตั้งเป้าหมายร่วมกัน และถ้าต้องการนำเรื่องใดเข้าระบบ สามารถ
หาข้อมูลร่วมกันนำเสนอคณะกรรมการเพื่อ defend งบประมาณ ตัวอย่างเช่น ต้อหิน

- นพ.อนุชิต บุญทูลงค์ (ประธานราชวิทยาลัยฯ)

1. ขอให้ร่วมกันคิดว่าจะทำเพื่อประชาชนอย่างไร โดยทุกฝ่ายได้ประโยชน์สูงสุด โดยพิจารณาภาระงาน
ของเจ้าหน้าที่ในแต่ละภาคส่วนให้มีความเหมาะสม

2. จากข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง ราชวิทยาลัยกับกระทรวงสาธารณสุข ปัจจุบันคณะกรรมการเขต
สุขภาพกำหนดให้มี excellence center และ training center แต่ในบางโรงพยาบาลยังไม่แน่ใจใน
ศักยภาพในการเป็น training center

3. การพิจารณาการรับแพทย์ประจำบ้านให้ตรงตามความต้องการของ service plan โดยราชวิทยาลัยมี
ความเห็นสมควรกำหนดคุณสมบัติในการรับแพทย์ประจำบ้านร่วมกัน เพื่อให้กระทรวงสาธารณสุขใช้
เกณฑ์ดังกล่าวในการพิจารณาคัดเลือกผู้รับทุนเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกัน

4. ควรเพิ่มบุคลากรทางการแพทย์และสายสนับสนุนให้มากขึ้น เพื่อครอบคลุมดูแลการบริการ สุขภาพให้
ทั่วถึง

5. ควรมีการวางแผนการจัดสรรเครื่องมือแพทย์กระจายเพื่อให้สอดคล้องและครอบคลุมทุกพร. ตามแผนที่จะมี
การรับจักษุแพทย์ในพร.ต่าง ๆ

6. จากข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง ราชวิทยาลัยกับกระทรวงสาธารณสุขที่จะเพิ่มการรับต้นสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข ในปีที่ผ่านมาได้ขอความร่วมมือจากสถาบันฝึกอบรมรับแพทย์ประจำบ้านที่มีต้น
สังกัดเพิ่มมากขึ้น ซึ่งสถาบันได้รับต้นสังกัดมากขึ้นแต่เป็นต้นสังกัดนอกกระทรวงสาธารณสุข

- อ.สายจิตต์ อธิประเสริฐ (รองประธานคณะกรรมการเขตสุขภาพ สาขาทา)

1. โครงการแว่นตาเด็ก ติดปัญหาอยู่ที่การบริหารงบประมาณที่มอบหมายให้รพ.เด็กเป็นที่ย่อยในการประกอบแว่นเพื่อทำการแจกจ่าย ส่งผลให้เกิดปัญหาในการแจกแว่นตาถึงผู้รับบริการตามโครงการ
2. การสำรวจ eye survey กำลังร่วมประชุมกับ สอสร.
3. การคิดสรรผู้ได้รับทุน ขอเสนอให้ราชวิทยาลัยฯ มีแนวทางการพิจารณาผู้ป่วยที่จะเข้าศึกษาต่อเป็นแพทย์ประจำบ้านในพื้นที่ก่อน โดยให้กำหนดรูปแบบเกณฑ์ในการรับแพทย์ประจำบ้านให้ตรงกันทั้งประเทศ
4. ความคงอยู่ในระบบของจักษุแพทย์ในโรงพยาบาลต่างๆ ราชวิทยาลัยฯควรมีส่วนร่วมในการทำวิจัยในเรื่องนี้ว่าการลาออกเกิดจากสาเหตุใด และควรทำอะไร ให้แพทย์สามารถทำงานและคงอยู่ในระบบสามารถคงอยู่ในจังหวัดที่ตัวเองขอทุนมาศึกษาต่อได้
5. ขอความร่วมมือแจ้งข้อมูลสถานะกำลังคนของพยาบาลทางจักษุวิทยาในแต่ละเขตสุขภาพที่ต้องการศึกษา หรือเพิ่มพูนความรู้ทางจักษุวิทยา เพื่อจัดสรรบุคลากรดังกล่าวเข้าอบรมให้เพียงพอกับความต้องการ โดยทางกระทรวงจะมีงบประมาณด้านการศึกษาเพิ่มเติมในส่วนนี้

- อ.วัฒน์ ยืนจิตร (กรรมการราชวิทยาลัยจักษุ กรรมการชมรมจักษุสาธารณสุข)

1. การทำ eye survey ในปี 2019 จะไม่ทัน ควรจะดำเนินการก่อนปี 2019 เพื่อให้ทัน mission 2020
2. เหตุที่จักษุแพทย์อยู่ต่างจังหวัดไม่ได้เนื่องจากปัจจัยอื่นนอกเหนือการควบคุม เช่น การแต่งงาน, การดูแลครอบครัว, ไม่มีเครื่องมือทางจักษุวิทยารองรับที่เพียงพอ และการอยู่เวรในฐานะแพทย์ทั่วไป ซึ่งขาดความชำนาญในด้านนั้น
3. การ screening Diabetic retinopathy โดยบุคลากรด้านการพยาบาล น่าจะสามารถทำได้ โดยอาจจะเพิ่มการตรวจด้วยเครื่องมือพิเศษโดยพยาบาล ซึ่งจะช่วยให้ลดระยะเวลาการรอคอยจักษุแพทย์

- นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ (รองปลัดกระทรวงฯ)

1. ในเรื่องของแพทย์ที่ออกนอกระบบกระทรวงสาธารณสุข สามารถสอบถามข้อมูลจากทางเขตได้ โดยใช้ข้อมูล exit review และขอให้ดูภาพรวมของประเทศเป็นหลักเพราะปกติ การเข้า-ออกของแพทย์ ก็เป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้
2. ขบวิจัยในการทำ survey จะปรึกษากับทาง สอสร. ให้พิจารณาปีก่อนปี 2019
3. service plan ต้องเป็นจุดตั้งต้นในทุกเรื่อง และการประชุม service plan น่าจะเป็นเวทีหลัก
4. กระทรวงจะไปผลักดันการกำหนดทุนของแพทย์ประจำบ้านใน service plan ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
5. กระทรวงวางแผนการช่วยแพทย์ให้ทำงานได้มีความสุขขึ้น Happy work place และกำลังพิจารณาการเปิดคลินิกพิเศษนอกเวลา เพิ่มการคงอยู่ของแพทย์

- นพ.อุดม ภู่วโรดม (สาธารณสุขนิเทศ กระทรวงสาธารณสุข)

1. จำนวนการกระจายตัว ในแต่ละรพ.ควรมีจักษุแพทย์อย่างน้อย 2-3 คน จึงจะเพียงพอ ที่มีแพทย์น้อยมีแนวโน้มที่แพทย์จะลาออก
2. การจัดสรรทุนการศึกษาต่อตามเขตสุขภาพน่าจะดีกว่ากำหนดเป็นโรงพยาบาล

- นพ.พรชัย สิมะโรจน์

มีความเห็นตรงกันในเรื่องการส่งต่อการรักษาจากรพ.ต่างจังหวัด ไปยังโรงเรียนแพทย์ ค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง แนะนำให้มีการประสานงานร่วมกับ UHOSNET

- นพ.อนุกุล ไทยถนอม (ผู้อำนวยการรพ.ปทุมธานี)

1. ยอยากให้แก้ปัญหาการส่งต่อผู้ป่วย จากรพ.จังหวัด ข้ามเขตไปยังโรงเรียนแพทย์ มีค่าใช้จ่ายสูงมาก และบางรายอาจไม่จำเป็นต้องส่งต่อ แต่ โรงเรียนแพทย์แนะนำให้ส่งต่อ
2. กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดประชุม มอบหมาย 2 ราชวิทยาลัยฯ นำร่องคือ ราชวิทยาลัยจักษุ และ จิตเวช โดยให้ ราชวิทยาลัยฯร่วมกับ service plan พิจารณาการจัดสรรโควตาการรับแพทย์ประจำบ้าน

3. ใน service plan การจัดสรรทุนแพทย์ประจำบ้านแบ่งเป็น 2 ส่วน อยากให้ราชวิทยาลัย มาร่วมจัดสรรทุน ตั้งแต่เริ่มแรก

4. อยากให้สถาบันฝึกอบรมจัดการเรียนและการสอนในเรื่องที่เป็นโรคตาที่เป็นปัญหาของสาธารณสุขให้มากขึ้น ลดการเรียนและการสอบในโรคที่ไม่พบบ่อยให้น้อยลง

5. ขอให้บางสถาบันฝึกอบรม ไม่ดึงแพทย์ที่มีต้นสังกัดที่เก่งเอาไว้ที่สถาบัน และคำนึงถึงการเพิ่มการฝึกอบรม sub board อาจทำให้แพทย์บางท่านทำงานทั่วไปลดลง

- นพ.ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์ (ประธานวิชาการ รพท.)

1. วัตถุประสงค์คือต้องการให้ทุกภาคส่วนมาทำงานร่วมกันให้มากขึ้นกว่าเดิม

2. ต้องการให้โรงเรียนแพทย์ มาทำงานร่วมกับ service plan ให้มากยิ่งขึ้น เพื่อให้แพทย์มีความต้องการทำงานในต่างจังหวัด มากยิ่งขึ้น

3. การมีระบบคู่ความร่วมมือระหว่างสถาบันฝึกอบรมและเขตสุขภาพในการทำงานร่วมกันในหลายๆด้าน

4. เริ่มจากคณะทำงานร่วมของ service plan และ ราชวิทยาลัยฯ, โรงเรียนแพทย์, สปสช. ในการ mapping ประเทศไทย

5. การจัดสรรทุน ต้องมีคณะทำงานร่วมพิจารณาในการรับแพทย์ประจำบ้าน เพื่อให้ตรงกับ ความต้องการของ service plan ซึ่งข้อสรุปความจำเป็นของเขตสุขภาพและผู้สมัครแต่ละท่านจะได้เป็นข้อมูลให้สถาบันฝึกอบรม

6. เตรียมความพร้อมระบบสนับสนุน เช่น ทีมพยาบาล, เครื่องมือแพทย์ เพื่อรองรับจักษุแพทย์ที่ จบแล้วกลับไปใช้ทุนในรพ.ที่ให้ทุน

7. การส่งต่อการรักษาจากจังหวัดเข้าโรงเรียนแพทย์ ค่าใช้จ่ายจะค่อนข้างสูง แต่ทางสปสช. ได้มีระบบลดปัญหาเบื้องต้นไว้แล้ว

- คุณกุลนันท์ อัฐนาถ (พยาบาลเวชปฏิบัติทางตา)

1. พยาบาลเวช มีบทบาทในเรื่องการคัดกรอง แต่ยังขาดแคลนจำนวนมาก และเครื่องมือสำหรับ พยาบาลก็ยังขาดแคลน ทำให้จำนวนผู้ป่วยที่ต้องมีส่งต่อยังมีจำนวนมาก

2. ขอให้มีการจัดสรรทุนของพยาบาลเวชในเรื่องการฝึกอบรมเพิ่มมากขึ้น

3. ให้การฝึกอบรมของพยาบาลเวชให้มากยิ่งขึ้น และทั่วถึง

4. ปัญหาของจำนวนการฝึกอบรมพยาบาลเวชฯ มีจำนวนจำกัด

- คุณเอื้องพร พิทักษ์สังข์ (ประธานชมรมพยาบาลฯ)

1. มีบางสถาบันเปิดหลักสูตรพัฒนาศักยภาพ 10 วัน

2. มีบางสถาบันเปิดหลักสูตรฝึกเครื่องมือทางจักษุ 10 วัน

3. ทางชมรมกำลังดำเนินงานการทำงานวิจัยทางด้านพยาบาลทางจักษุ

- นพ.วรภัทร วงษ์สวัสดิ์ (รพ.เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง))

1. แต่งตั้งกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ โดยรพ.เมตตาฯ เป็นเลขานุการ ได้รับงบประมาณมาดำเนินงาน

2. โครงการ การบริหารจัดการ การผลิตและพัฒนาบุคลากรสาขาจักษุวิทยา ตาม MOU โดย จะต้องดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนด ปี 2561-2563

- นพ.อนุกุล ไทยถนอม (ผู้อำนวยการรพ.ปทุมธานี)

การขอทุนอบรมจะเป็นงบประมาณรวมของเขต ซึ่งจะมีผลต่อการขออบรมพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา

- นพ.อนุจิต บุญญทังค์ (ประธานราชวิทยาลัยฯ)

- ราชวิทยาลัยจะเชิญประชุม เพื่อ mapping ประเทศไทย เชิญ ราชวิทยาลัยฯ, service plan, หัวหน้าภาควิชา 11 สถาบัน ในการพิจารณาสนับสนุน Excellence center และ Training center ในแต่ละเขตสุขภาพ โดยกำหนดการประชุมวันที่ 28 มีนาคม 2561

- ข้อเสนอแนะ

- นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ (รองปลัดกระทรวงฯ)

1. พยายามพัฒนา service plan ต้องการให้เขตเข้มแข็งมากขึ้นโดยการให้สถาบันฝึกอบรมร่วมสนับสนุนในด้านต่างๆ
2. ถ้าต้องการให้เขตเข้มแข็ง อยากให้หัวหน้าสถาบันฝึกอบรมช่วยพิจารณาร่วมกับ service plan ในการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน
3. ราชวิทยาลัยได้ criteria ในภาพรวม ในการคัดเลือกผู้เรียน โดยใช้เกณฑ์กลางในการคัดเลือก ทุกสถาบันร่วมกับเกณฑ์เฉพาะของแต่ละสถาบัน
4. ให้ราชวิทยาลัยช่วยสร้างโมเดลการรักษาให้ดียิ่งขึ้น เช่น โรคต้อหิน, ROP
5. กระทรวงเตรียมพร้อมในการทำโมเดลนำร่องในทุกรูปแบบ เป้าหมายคือต้องการโมเดลในการรักษาที่เหมาะสมกับประเทศ

- อ.ปริญญา โจนพงศ์พันธ์ (หัวหน้าภาควิชาจักษุ รพ.จุฬาลงกรณ์)

เห็นด้วยให้เขตสุขภาพนำ ข้อเสนอให้มีการ benchmark กันระหว่างเขต โรคอาจไม่แตกต่างกัน แต่ลักษณะพื้นที่ บริบท logistic ต่างกัน จะได้แบ่งปันความรู้

- อ.วิชัย ประสาทอุทธร (หัวหน้าภาควิชาจักษุ รพ.รามธิบดี)

1. ปัญหาของการรับแพทย์ประจำบ้าน พื้นฐานของการมาสมัครไม่เหมือนกัน มาตรฐานของ ผู้สมัครไม่เท่ากัน ขอเสนอว่าถ้าผู้สมัครมาจากต่างจังหวัดอยากให้สมัครที่สถาบันฝึกอบรมที่อยู่ ต่างจังหวัด
2. การทำ private practice จะช่วยเพิ่มรายได้

- อ.ศุภชัย โชติบุตร (ผู้แทนหน่วยผ่าตัดต้อกระจก มูลนิธิ พอ.สว. และที่ปรึกษา ราชวิทยาลัย)

1. ทำอย่างไรให้จักษุแพทย์ผลิตให้มากขึ้น และอยู่ได้นานขึ้นในจังหวัดนั้น ๆ สิ่งสำคัญคือความเป็นอยู่ของจักษุแพทย์ในจังหวัดนั้นต้องดี
2. ความสะดวกในการเดินทางของคนไข้ จะทำให้ลดการเกิด blinding cataract ได้
3. วิธีการรักษาคนไข้ต้อหินในต่างจังหวัด ต้องมีวิธีที่หลากหลายและเหมาะสม เนื่องจากเป็นโรคที่ต้องรักษาต่อเนื่อง
4. การฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ต้องเน้นให้สามารถไปรักษาในจังหวัดที่ได้รับทุนมาได้อย่างมั่นใจ และรักษาโรคที่พบได้บ่อย

ปิดประชุมเวลา 12.00 น.



(พ.อ. นพ.ยุทธพงษ์ อิมสุวรรณ)

ผู้จัดรายการประชุม



(รศ.นพ.อนุชิต ปุณญทลิ่งค์)

ผู้ตรวจรายการประชุม



รายงานการประชุมการพัฒนาาระบบจักษุแบบยั่งยืน ครั้งที่ 2/2561

วันพุธ ที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 09.30-12.00 น.

ณ ห้องประชุมแสงสิงแก้ว อาคาร 1 กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ผู้มาประชุม

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. นพ.อนุชิต ปุณฺณทลฺลํ | ประธานราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย |
| 2. นพ.ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์ | ประธานวิชาการราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย |
| 3. นพ.ภฤต หาญอุตสาหะ | ประธานคณะกรรมการ อฟส. ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย |
| 4. นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ | รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข |
| 5. นพ.ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์ | ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพ สาขาตา |
| 6. พญ.สายจินต์ อีสี่ประดิษฐ์ | ประธานร่วมคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพ สาขาตา |
| 7. นางสาวเบญจมาศ เพชรรักษ์ | สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ |
| 8. นพ.สุรพงศ์ ออประยูร | ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพ สาขาตา เขตสุขภาพที่ 1 |
| 9. นพ.วิทยา ปานะโปย | รองประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพ สาขาตา เขตสุขภาพที่ 2 |
| 10. นพ.ราเมศ สุขุมลไพบูลย์ | ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพ สาขาตา เขตสุขภาพที่ 3 |
| 11. นพ.อนิรุทธิ์ สุวัตรจริยากุล | รองประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพ สาขาตา เขตสุขภาพที่ 4 |
| 12. นพ.ศุภชัย ศุภพฤกษ์สกุล | ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพ สาขาตา เขตสุขภาพที่ 5 |
| 13. นพ.ไพศาล สหพัฒนา | ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพ สาขาตา เขตสุขภาพที่ 6 |
| 14. นพ.นพดล แข็งแรง | ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพ สาขาตา เขตสุขภาพที่ 7 |
| 15. นพ.สุวัฒน์ คูสกุล | ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพ สาขาตา เขตสุขภาพที่ 8 |
| 16. นพ.ประวีณ ตันตพระภา | ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพ สาขาตา เขตสุขภาพที่ 9 |
| 17. พญ.ปานวาด อูธิโย | ผู้แทนคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพ สาขาตา เขตสุขภาพที่ 10 |
| 18. พญ.ปณยดา ชินกุลกิจนิวัฒน์ | ผู้แทนคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพ สาขาตา เขตสุขภาพที่ 11 |
| 19. นพ.ไชยสิทธิ์ เทพชาตรี | ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพ สาขาตา เขตสุขภาพที่ 12 |
| 20. นพ.จักรพงษ์ นะมาตร | หัวหน้าภาควิชาจักษุวิทยา โรงพยาบาลศิริราช |
| 21. นพ.ณัฐวุฒิ รอดอนันต์ | ภาควิชาจักษุวิทยา โรงพยาบาลศิริราช |
| 22. นพ.ปริญญ์ โรจนพงศ์พันธุ์ | หัวหน้าภาควิชาจักษุวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
| 23. พญ.อรวลี จตุทอง | หอกองจักษุกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า |
| 24. นพ.โอฬาร สุวรรณอภิชน | ภาควิชาจักษุวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น |
| 25. นพ.แมนสิงห์ รัตนสุคนธ์ | หัวหน้าภาควิชาจักษุวิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ |

/26. พญ.มัญจิม...

- | | |
|-----------------------------|--|
| 26. พญ.มัณชิมา มะกรวัฒนะ | ภาควิชาจักษุวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |
| 27. นพ.อาทิตย์ แก้วนพรัตน์ | ภาควิชาจักษุวิทยา โรงพยาบาลวชิรพยาบาล |
| 28. นพ.ชวศักดิ์ กนกกันทพงษ์ | ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท |
| 29. นพ.วรภัทร วงษ์สวัสดิ์ | คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาตา |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. นพ.ทยากร คุปกาญจน | ภาควิชาจักษุวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |
| 2. พญ.สุภาพรณ ฉัตรทินกร | จักษุแพทย์ เขตสุขภาพที่ 6 โรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี |
| 3. นางสาวนิรัชรา ด้านสวัสดิ์ | สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท |
| 4. นางสาวณิชน ชุมสิงห์ | กลุ่มงานยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) |
| 5. นางสาวพวงลักษณ์ กลิ่นกุหลาบ | กลุ่มงานยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) |

เริ่มประชุม เวลา 09.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน รจท. : แจ้งความเป็นมาของการประชุมพัฒนาระบบจักษุอย่างยั่งยืน จากการลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยกับกระทรวงสาธารณสุข

1. จุดมุ่งหมายสำคัญ 4 ประการ คือ

- 1) ทุกเขตสุขภาพของประเทศไทยมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน แพทย์พยาบาลทำงานอย่างมีความสุข ผู้ป่วยได้รับการดูแลรักษาอย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องส่งต่อรักษาไกลบ้าน
- 2) ทุกภาคส่วนร่วมคิด เห็นเป้าหมาย ใช้ศักยภาพและทรัพยากรเพื่อให้เกิดการพัฒนาบรรลุเป้าหมายอย่างคุ้มค่า เหมาะสม
- 3) ระบบที่ดีมีธรรมาภิบาล สามารถดำเนินการพัฒนาต่อไปได้เองอย่างต่อเนื่อง
- 4) เป็นรูปแบบที่นำไปสู่การพัฒนาระบบสุขภาพอื่นๆ ของประเทศไทยต่อไป

2. ขั้นตอนการดำเนินการ 4 ขั้นตอน

- 1) การร่วมวางแผนพัฒนาระบบจักษุอย่างยั่งยืนจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง (กระทรวงสาธารณสุข, ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ, คณะกรรมการเขตสุขภาพ, สปสช., ผู้ทรงคุณวุฒิ, ตัวแทนหัวหน้าสถาบันฝึกอบรมแพทย์พยาบาลตา, สมาคมและชมรมพยาบาลจักษุ)
- 2) การวางแผนเป้าหมายร่วมกันโดยทำ Mapping ประเทศไทยด้านจักษุ ในมิติ Excellence center และ Training center ของทุกเขตสุขภาพ (รองปลัดฯ, คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาตา, ประธานราชวิทยาลัยฯ และ ประธาน อฝส., หัวหน้าทุกสถาบันฝึกอบรม, ผอ.สปสช.)
- 3) การพิจารณาจัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสม, จัดสรรทุนศึกษาต่อและจัดสรรคนลงตำแหน่งทุน (รองปลัดฯ, คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาตา, ประธาน อฝส., หัวหน้าทุกสถาบันฝึกอบรม, ผอ.สปสช.)
- 4) การติดตามพัฒนางานในทุกเขตสุขภาพและสถาบันฝึกอบรมคู่ความร่วมมือฯ อย่างต่อเนื่อง

/ความคิดเห็น...

ความคิดเห็นที่ประชุม : เรื่องธรรมาภิบาล เนื่องจากการ Training จักุแพทย์ของโรงพยาบาลได้รวมถึง กระทรวงกลาโหม และกรุงเทพมหานคร จึงขอให้เชิญหน่วยงานดังกล่าวเข้าร่วมจัดทำ Mapping ด้วย

ประธาน รจท. : ระเบียบแพทยสภากำหนดการรับฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ขอให้สถาบันพิจารณารับผู้ที่มีทุนต้นสังกัดก่อน และหลักการตามบันทึกกลนามความร่วมมือฯ เพื่อแก้ไขปัญหาความจำเป็นเร่งด่วนของประเทศ ดังนั้นจึงขอพิจารณาให้กระทรวงสาธารณสุขก่อน สำหรับกระทรวงกลาโหมอยู่ระหว่างการเตรียมพร้อมและพัฒนาเป็นสถาบันสมทบ

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ความคิดเห็นที่ประชุม : ประธานกรรมการและประธานทุกเขตสุขภาพ แก้ไขเป็น ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาตา และประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพ สาขาตาทุกเขตสุขภาพ

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมการพัฒนาระบบจักษุแบบยั่งยืน ครั้งที่ 1/2561

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน รจท. : นำเสนอให้ที่ประชุมทราบ

1. ข้อมูลเบื้องต้นระบบจักษุของประเทศไทย และข้อมูลศักยภาพการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านจักษุวิทยาและอนุสาขที่เปิดฝึกอบรม รวมถึงข้อมูลการอบรมพยาบาลเวชปฏิบัติทางตาของแต่ละสถาบัน ในปัจจุบัน

- จำนวนจักษุแพทย์ต่อประชากรยังต่ำกว่ามาตรฐานเมื่อเทียบกับต่างประเทศ และกึ่งหนึ่งอยู่ในกรุงเทพฯ

- มีจักษุแพทย์ทั่วไป 781 คน และมีจักษุแพทย์อนุสาขา ได้แก่ จอตาและวุ้นตา 209 คน, ต้อหิน 147 คน, กระจอตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตา 126 คน, ศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง 57 คน, จักษุวิทยาเด็กและตาเข 46 คน, ประสาทจักษุ 26 คน และจักษุวิทยาภูมิคุ้มกันและการอักเสบ 19 คน

- ศักยภาพในการอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาจักษุวิทยาแต่ละแห่งสูงสุดได้ไม่เกิน 10 คน และจากข้อมูลรายชื่อสถาบันผลิตแพทย์ประจำบ้านปี 2561 ได้รับคัดเลือกจาก การสมัคร 67 คน ต้นสังกัด 54 คน กระทรวงสาธารณสุข 42 คน อิสระ 13 คน และนอกกระทรวงฯ 12 คน

- อนุสาขาที่เปิดฝึกอบรมในแต่ละสถาบัน รวม 65 ตำแหน่ง ได้แก่ จอตาและวุ้นตา 21 คน ต้อหิน 15 คน กระจอตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตา 12 คน ศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง 7 คน จักษุวิทยาเด็กและตาเข 5 คน ประสาทจักษุวิทยา 3 คน และจักษุวิทยาภูมิคุ้มกันและการอักเสบ 2 คน

- สถาบันอบรมหลักสูตรการพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา ได้แก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ปีละ 2 รุ่นๆละ 50 คน) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ปีละ 1 รุ่นๆละ 30 คนขึ้นไป) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ปีละ 1 รุ่นๆละ 24 คน) โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีร่วมกับโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) (ปีละ 1 รุ่นๆละ 20 คนขึ้นไป) และโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) ร่วมกับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี จักรีรัช ราชบุรี (ปีละ 1 รุ่นๆละ 20 คนขึ้นไป)

- สภาพปัญหาทางตาในประเทศไทยจากการสำรวจสถานะตาบอดของสมาคมจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย

/ในปี พ.ศ. ...

ในปี พ.ศ.2549-2550 พบว่า ประชากรไทยมีความชุกของตาบอดเท่ากับ 0.59 และมีสาเหตุสำคัญของภาวะตาบอด ดังนี้ โรคต้อกระจก (50%), โรคจอประสาทตา (9%), โรคต้อหิน (8%), โรคกระจกตา (5%) และสายตาสั้นผิดปกติ (4%)

2. เสนอกรอบความคิดและข้อมูลประกอบการทำ mapping ประเทศไทย ด้านจักษุในทุกเขตสุขภาพ

3. เสนอให้สถาบันฝึกอบรมเป็นคู่ความร่วมมือประจำเขตสุขภาพกับแต่ละเขตสุขภาพ ในด้านการสนับสนุนวิชาการ, การรับปรึกษาหรือรับส่งต่อผู้ป่วยในกรณีจำเป็น, การพิจารณารับฝึกอบรมบุคลากร, เป็นแกนในการทำวิจัยหรือการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ เป็นต้น

4. ประธานแต่ละเขตสุขภาพนำเสนอแผนการเป็น Excellence center และ Training center (ระดับ 1 สถาบันวิชาเลือก, ระดับ 2 สถาบันร่วมฝึก, ระดับ 3 สถาบันหลัก) ในเขตสุขภาพรายเขต ในกรอบระยะเวลา 4 ปี (2561-2564)

5. รองปลัดฯ และประธานคณะกรรมการเขตสุขภาพ ร่วมพิจารณาความเหมาะสม การจัดเตรียมจักษุแพทย์ จักษุแพทย์เฉพาะทาง พยาบาลเวชตา เจ้าหน้าที่เทคนิคและเครื่องมือที่จำเป็น

6. สถาบันฝึกอบรมพิจารณาเกณฑ์กลางในการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอดร่วมกับ เกณฑ์เฉพาะของแต่ละสถาบัน

7. ผอ.สพพช. นำเสนอรูปแบบคณะกรรมการร่วมของประธานเขตสุขภาพ ประธาน อ.ส. และหัวหน้าสถาบันฝึกอบรม เพื่อพิจารณาจัดสรรทุนศึกษาต่อด้านจักษุและพิจารณาจัดสรรคนรับทุนแต่ละทุนตามแนวนันท์ที่ความร่วมมือระหว่างราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย กับกระทรวงสาธารณสุข

8. ท่านรองปลัดฯ ให้นโยบายและความต้องการของกระทรวงต่อการพัฒนาระบบจักษุอย่างยั่งยืน, สปสช. นำเสนอ แนวโน้มโครงการด้านจักษุในระยะเวลา 4 ปี (2561-2564)

9. ที่ประชุมรับฟังข้อคิดเห็นในการสนับสนุนจากราชวิทยาลัย การสนับสนุนอุปกรณ์ที่ขาดแคลน การเผยแพร่ผลงานวิชาการและทุนสนับสนุนทางด้านวิชาการต่างๆ ของราชวิทยาลัยฯ

10. ที่ประชุมจัดทำระบบการติดตามสื่อสาร เพื่อให้ระบบงานเดินหน้าและมีการพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง (Plan-Do-Check-Act)

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธาน รจท. : นำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

1. การทำ Mapping ประเทศไทย ด้านจักษุในทุกเขตสุขภาพ

ความคิดเห็นที่ประชุม :

- การเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายความร่วมมือภายในเขตสุขภาพระหว่างโรงเรียนแพทย์กับเขตสุขภาพ อาทิ เช่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กับเขตสุขภาพที่ 11, 12 ในด้านการส่งต่อและการบริการ หากมีคู่ความร่วมมือกับเขตเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม อยากให้มีการพิจารณาร่วมกันในเรื่องของการส่งบุคลากรฝึกอบรมระหว่างเขตกับ

/สถาบันฝึกอบรม...

สถาบันฝึกอบรมและยินดีเป็นพี่เลี้ยงให้คำปรึกษาด้านการวิจัย และความต้องการของเขตสุขภาพที่ 12 ต้องการให้มีความร่วมมือ 1.ด้านการบริการ การบริหารระบบการส่งต่อ และจัดทำGuidelineการส่งต่อร่วมกัน 2.ด้านวิชาการและการวิจัยเพื่อความก้าวหน้า 3.ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล เครื่องมือ/ครุภัณฑ์ทางการแพทย์, มหาวิทยาลัยขอนแก่นกับเขตสุขภาพที่ 7 มีความร่วมมือด้านวิชาการและบริการด้วยดีเหมือนพี่น้อง

- เครือข่ายระหว่างเขตสุขภาพที่มีการทำ MOU โรงเรียนแพทย์กับเขตสุขภาพ เช่น เขตสุขภาพที่ 7 กับโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) ในด้านวิชาการ, เขตสุขภาพที่ 9 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา กับโรงพยาบาลรามารักษ์ ในการฝึกแพทย์ Extern เป็นต้น

- การ MOU ขอให้พิจารณาร่วมกันในทางปฏิบัติ ปัญหากรณีส่งต่อฉุกเฉินจากโรงพยาบาลในเขตสุขภาพไปยังโรงเรียนแพทย์ เนื่องจากโรงเรียนแพทย์มีการเรียกเก็บในอัตรามหาวิทยาลัยที่ค่อนข้างสูง เช่น น้ำตาเทียม, ยาฉีดบางชนิด, ส่งตรวจ Lab มีความจำเป็นต้องใช้ ประเด็นนี้จะขอหารือร่วมกันในโอกาสต่อไป

- กระทรวงสาธารณสุขมีการทำพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 ระหว่าง คณะแพทยศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงกลาโหม สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้การดำเนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข สอดคล้องตามยุทธศาสตร์การจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ 4 ด้าน ดังนี้ 1.พัฒนาความร่วมมือทางด้านการบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขและระบบส่งต่อ 2.พัฒนาความร่วมมือทางด้านผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข โดยการพัฒนาความร่วมมือด้านการศึกษา ทั้งก่อนปริญญา และหลังปริญญา 3.พัฒนาความร่วมมือทางด้านวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุข 4.กำหนดให้มีคณะกรรมการกำกับ ติดตาม และประเมินผล เพื่อวิเคราะห์ปัญหา ทบทวน และเสนอแนะแนวทางปรับปรุงการดำเนินการระหว่างหน่วยงานเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง การ Mapping ร่วมกันระหว่างโรงเรียนแพทย์กับเขตสุขภาพที่ผ่านมา ยังไม่มีผลผลิตที่ชัดเจน เนื่องจากโรงเรียนแพทย์บางแห่งไม่มีการฝึกอบรมด้านจักษุ แต่ยังเป็นพี่เลี้ยงให้กับเขตใน Service Plan สาขาอื่นอยู่ และการประชุมในครั้งนี้ขอให้มีการ Mapping แบบสมัครใจ เพื่อให้เกิดผลงานที่เป็นรูปธรรม

- ขอให้มีความชัดเจนในการจับคู่และทดลองทำทั้งแบบ General และแบบ Specific เพื่อให้เกิด Best Practice Model ตัวอย่างเช่น ROP ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นกับเขตสุขภาพที่ 7 และเพื่อให้มีการวางแผนยุทธศาสตร์ (คน/เงิน/ของ) ที่ชัดเจน เพื่อรองรับการจัดสรรงบประมาณในแผนฯขึ้นของเขตสุขภาพ และในอนาคตอาจจะมีการปรับเปลี่ยนจับคู่ใหม่ได้

- ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย และราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ได้มีการลงนามความร่วมมือ (MOU) เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560 ในประเด็นด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากร โดยการเพิ่มการผลิตแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาจักษุวิทยาและจักษุแพทย์เฉพาะทาง Service Plan มีแนวทาง ดังนี้ 1.วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานและความขาดแคลนของทรัพยากรบุคคลทางจักษุวิทยา 2.วิเคราะห์และวางแผนสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการผลิตจักษุแพทย์ 3.ยุทธศาสตร์การกำหนดตำแหน่งจักษุแพทย์ในพื้นที่เขตบริการสุขภาพ 4.ยุทธศาสตร์ การกำหนดตำแหน่งวิชาชีพสนับสนุนการบริการจักษุในพื้นที่เขตบริการสาธารณสุข

- หลังทำ MOU จับคู่แล้ว ขอให้โรงเรียนแพทย์ให้ความสำคัญกับเขตสุขภาพที่รับผิดชอบจับคู่โดยตรงก่อน

/และขอให้...

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

4. เกณฑ์กลางการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน

ความคิดเห็นที่ประชุม : การคัดเลือกแพทย์รับทุนในเขตสุขภาพ พบปัญหาผู้ถูกคัดเลือกไม่เหมาะสม ตั้งแต่เริ่มแรก ไม่พร้อมที่จะอยู่ในเขตสุขภาพ ทำให้มีการโอนย้ายและลาออก

ประธาน Service Plan สาขาตา :

1. การทดสอบผู้สัมภาษณ์โดยนักจิตวิทยามีหลักฐานเชิงประจักษ์สามารถใช้เป็นหลักฐานแสดงกรณีไม่รับได้
2. การวางแผนส่งไปเรียนไว้ก่อน 3 ปี เพื่อทดแทนจักษุแพทย์ที่จะเกษียณ และลดปัญหาการขาดบุคลากร

ผอ.สบพช. : คณะกรรมการจัดสรรพิจารณาตัดอายุที่ 53 ปี โควต้าที่ได้มาต้องพิจารณาด้านอื่นๆ ร่วมด้วยภายใต้กรอบอัตรากำลัง ทุนส่วนใหญ่ 90% อยู่ที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ประธาน รจท. :

1. สรุปหลักการพิจารณาร่วมกัน ดังนี้
 - 1) การมีต้นสังกัด - มีต้นสังกัดหรืออิสระ
 - 2) หน่วยงานต้นสังกัด - กระทรวงสาธารณสุขหรือไม่ใช่กระทรวงสาธารณสุข
 - 3) ต้นสังกัดกระทรวงสาธารณสุข - มาจากเขตสุขภาพหรือจากจังหวัด
 - 4) ผลการปฏิบัติงาน - โดยผู้บังคับบัญชารวมทั้งผู้ร่วมงาน
 - 5) ใบ recommendation
 - 6) คะแนนผลการเรียน - GPA และ ophthalmology
 - 7) ผลงานที่แสดงถึง - การช่วยเหลือสังคม
 - 8) ผลงานที่แสดงถึงความสนใจ - ด้านจักษุ อาทิ การร่วมกิจกรรม การวิจัยด้านจักษุ
 - 9) การสัมภาษณ์ - เจตคติ ไหวพริบ
 - 10) ทักษะด้าน - การแก้ปัญหา ทักษะ microsurgery 3D ability
 - 11) การมีภูมิสำเนาในพื้นที่ที่ได้ทุนมา และการปฏิบัติงานชดเชยทุนหลังจบแพทย์ในพื้นที่ที่รับทุนมา

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

5. คณะทำงานพิจารณาจัดสรรทุนและจัดสรรคนลงตำแหน่งทุน

ประธาน รจท. : สรุปว่า คณะกรรมการพิจารณาการจัดสรรทุนและจัดสรรคนลงตำแหน่งทุน ประกอบด้วย กระทรวงสาธารณสุข สถาบันฝึกอบรม 11 แห่ง เขตสุขภาพ 12 เขต และ สบพช. ช่วยกันพิจารณาวางแผนร่วมกัน

ผอ.สบพช. : คณะกรรมการจัดสรรทุนแพทย์ประจำบ้าน คณะกรรมการจัดสรรประกอบด้วย CHRO ของแต่ละเขตสุขภาพ และใช้กรอบ Service Plan ทุกสาขา มาร่วมกันกำหนด รวมถึงพิจารณาถึงศักยภาพการผลิต แล้วนำมาหา Gap ทั้งนี้สาขาจักษุวิทยามีความแตกต่างจากสาขาอื่น เนื่องจากมี 7 อนุสาขา (2 ปี) แต่ไม่ถูกผูกกับแพทย์สภา หรือ ก.พ. และเป็นสาขาที่ได้รับความนิยม ดังนั้น เป็นโอกาสดีที่คณะกรรมการชุดใหญ่

/มอบอำนาจ...

มอบอำนาจให้ Service Plan พิจารณาคณะและเครื่องมือลงเขตสุขภาพ เพื่อความเป็นธรรมาภิบาลและเกิดประโยชน์กับคนไข้และประชาชน กระทรวงฯจัดสรรให้ 90% ของศักยภาพการผลิต โดยมีกรอบเวลาขอให้ส่งให้ทันภายในวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ก่อนรวมกับสาขาอื่นเพื่อนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 และมอบอำนาจจัดสรรตำแหน่งต่อไปที่เขตสุขภาพจัดสรรต่อลงจังหวัด/โรงพยาบาลที่ขาดจักษุแพทย์ต่อไป

ประธาน Service Plan สาขาทา : มอบ พญ.สายจิตต์ อีสี่ประดิษฐ์ เตรียมนัดประชุม และประธานแต่ละเขตรวบรวมข้อมูลจักษุแพทย์ เพื่อหา Gap ตามตารางตัวอย่างการวิเคราะห์อัตรากำลังของประธาน Service Plan สาขาทา เขตสุขภาพที่ 12

ความคิดเห็นที่ประชุม :

1. CHRO ทุกเขตสุขภาพมีการจัดทำกรอบการวิเคราะห์อัตรากำลังในสถานพยาบาลแต่ละระดับอยู่แล้ว
2. การประชุมครั้งต่อไป เสนอให้มีการแยกประชุมกลุ่มย่อย ระหว่างคู่ความร่วมมือโรงเรียนแพทย์กับเขตสุขภาพ เนื่องจากแต่ละเขตสุขภาพมีข้อมูลเชิงลึก

ผอ.สบพข. : จากการนำเสนอกรอบการวิเคราะห์อัตรากำลังเป็นเพียงการนำเสนอเพียง 1 มิติ แต่ยังไม่ได้นำเสนอในหลายมิติ ได้แก่ ด้านอนุสาขา เครื่องมือทางการแพทย์ Sizesระบบrefer รอส่งเรียน เป็นต้น

ประธาน รจท. : ขอให้เน้นที่ Resident ก่อน ส่งภายในเดือนเมษายน 2561

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

6. แนวโน้มโครงการด้านจักษุ สปสช. ในระยะเวลา 4 ปี (2561-2564)

ผู้แทน สปสช. : โครงการ สปสช. ที่เกี่ยวกับจักษุ มี 3 โครงการ ได้แก่

1. โครงการแว่นตาเด็ก 700 บาท/ราย (20,000 อัน ปี 2559 เบิกได้ 3,000 อัน)
2. โครงการผ่าตัดต้อกระจก ปี 2561 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหารือร่วมกันของกระทรวงจากหลายภาคส่วน จะมีการประชุมในโอกาสต่อไป ปี 2562 มีการปรับอัตราการชดเชยการผ่าตัดในรายที่มีสายตาสั้นและในรายที่มีภาวะแทรกซ้อน ซึ่งได้ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการแล้ว และในปีงบประมาณ 2564 มีการปรับจากระบบ GR ไปเป็นระบบปกติ

3. โครงการปลูกถ่ายเปลี่ยนกระจกตา

และยกเลิกโครงการเลเซอร์ DR < 6,000 ราย/ปี

ประธาน รจท. : ขอให้ สปสช. พิจารณากรณี refer ข้ามสังกัดจากกระทรวงสาธารณสุขไปยังโรงเรียนแพทย์ เนื่องจากโรงเรียนแพทย์มีการเรียกเก็บในอัตรามหาวิทยาลัยที่ค่อนข้างสูง จะสรุปรายงานการประชุมส่ง UHosNet

รองปลัดกระทรวง สธ. : สืบเนื่องจากการรายงานผลการดำเนินโครงการผ่าตัด corneal transplant เฉลิมเกียรติฯ ในที่ประชุม CIPPO สาขากการปลูกถ่ายอวัยวะ ภาพรวมมีผลการผ่าตัดค่อนข้างน้อย ขาด cornea man และเรื่องของการชดเชย จึงต้องมีการรณรงค์กระตุ้นเป็นระยะๆ

ความคิดเห็นที่ประชุม :

- ปัญหา corneal transplant คือเรื่องการหา Donner ที่ได้มา พบว่า 10-15% ดิดเชื้อและใช้การไม่ได้...

ไม่ได้ และระบบการรายงานที่ไม่ละเอียดและไม่ครอบคลุม เช่น เขตสุขภาพที่ 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีการผ่าตัด แต่ไม่ถูกรายงาน เนื่องจากไม่ใช่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

- จุฬาลงกรณ์นำเข้าดวงตาจากต่างประเทศได้งบประมาณจากศูนย์ดวงตา สภากาชาดไทยผ่าตัดจำนวน 84 ดวงตา แต่ไม่ถูกรายงาน

- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มองว่าการทำ corneal transplant มีความเสี่ยงในการคัดเลือก case

- เสนอให้ทุกเขตสุขภาพสำรวจความต้องการด้านการ train corneal

- สภากาชาดไทยขอความร่วมมือกับชมรมกระจกตา มีการทำงาน corneal transplant เชิงรุกใน OR

- ค่าตอบแทนการผ่าตัด ในโรงพยาบาลที่มีการผ่าตัดคนไข้ของตัวเองหรือนำคนไข้กลับบ้านไปผ่าตัด ผ่าตัด จะได้รับค่าตอบแทนจาก สปสช. case ละ 15,000 บาท และสภากาชาดจะเรียกเก็บจาก สปสช. 15,000 บาท หน่วยงานไม่ได้รับค่าตอบแทน มีความคืบหน้าของค่าตอบแทน instrument ไว้หรือไม่

รองปลัดกระทรวง สธ. : รับเรื่องเข้าวาระการประชุม สปสช. แต่ขอ paper เกี่ยวกับการสนับสนุนที่ควรจะเป็นและเหมาะสม ในโครงการเฉพาะควรจะเป็นเท่าไร

ประธาน Service Plan สาขาทา : รายงานผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2560 สามารถผ่าตัด เปลี่ยนกระจกตาได้ 1,100 กว่าราย จากทุกสังกัด Key success factor คือ 1.เรื่อง Donner การอบรมทีมเจรจา และจัดเก็บดวงตา สภากาชาดไทยจัดอบรมให้ 2.Service Plan มีการเสนอจัดตั้ง Excellent center (corneal transplant) เป็นศูนย์จัดเก็บและกระจาย corneal และเพื่อลดการสูญเสียระหว่างการจัดเก็บ และ 3.Tele-medicine มีความร่วมมือกับ กสทช. ในการซื้อเครื่องมือกระจายลงไปโรงพยาบาลส่วนภูมิภาค

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

7. ทุนสนับสนุนจากราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ และข้อเสนอความต้องการ การสนับสนุนของ ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ต่อสมาชิก และแพทย์ประจำบ้าน

ประธาน รจท. :

- 1) โครงการ สนับสนุนการผลิตตำรา สำหรับจักษุแพทย์ไทย
- 2) ทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยสำหรับแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด
- 3) ทุนสนับสนุนการเข้าร่วมประชุม AAO แพทย์ต่างจังหวัด และแพทย์ประจำบ้าน
- 4) ทุนสนับสนุนการเข้าร่วมประชุม APAO
- 5) ยกเว้นค่าลงทะเบียนการประชุมวิชาการ ให้แก่จักษุแพทย์ที่ปฏิบัติงานใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (นราธิวาส, ยะลา, ปัตตานี)

6) รางวัลจักษุแพทย์ดีเด่น สนับสนุนการคัดเลือกเป็นแพทย์ดีเด่นแพทยสมาคม

7) การประกวดผลงานวิจัยจักษุแพทย์ และแพทย์ประจำบ้าน

ข้อเสนอและความต้องการ

- 1) จัดทำอุปกรณ์ที่จำเป็น เช่น chart VA

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

/8. ระบบติดตาม...

8. ระบบติดตามสื่อสาร

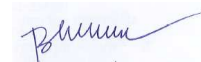
ประธาน รจท. :

- 1) การร่วมวางแผนพัฒนาระบบจักษุอย่างยั่งยืนจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
 - 2) การวางแผนเป้าหมายร่วมกันโดยทำ Mapping ประเทศไทยด้านจักษุ ในมิติ Excellence center และ Training center ของทุกเขตสุขภาพ อยู่ระหว่างการติดตามขอข้อมูล
 - 3) การพิจารณาจัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสม, จัดสรรทุนศึกษาต่อและจัดสรรคนลงตำแหน่งทุน อยากให้มีเวทีปรึกษาหารือร่วมกัน เพื่อให้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน และส่ง สบพช.ทุกปี
 - 4) การติดตามพัฒนางานในทุกเขตสุขภาพและสถาบันฝึกอบรมคู่ความร่วมมือฯ อย่างต่อเนื่อง
 - ลำดับต่อไป จะมีการจัดประชุมหารือร่วมกับพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา และเทคนิคเขียล
- มติที่ประชุม : เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

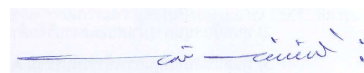
- ไม่มี

ปิดประชุม เวลา 12.00 น.



(นางสาวพวงลักษณ์ กลิ่นกุหลาบ)

ผู้จัดรายการประชุม



(นพ.วรภัทร วงษ์สวัสดิ์)

ผู้ตรวจรายการประชุม



(รศ.นพ.อนุชิต ปุณณทลัณค์)

ผู้ตรวจรายการประชุม



รายงานการประชุมการพัฒนาาระบบบัญชีแบบยั่งยืน ครั้งที่ 3/2561

วันพุธ ที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 09.30-13.00 น.

ณ ห้องประชุมแสงสิงแก้ว อาคาร 1 กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ผู้มาประชุม

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. นพ.อนุชิต ปุญญทลิ่งค์ | ประธานราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย |
| 2. นพ.ยุทธพงษ์ อิ่มสุวรรณ | เลขาธิการราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย |
| 3. นพ.ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์ | ประธานวิชาการราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย |
| 4. นพ.ภฤศ หาญอุตสาหะ | ประธานคณะกรรมการ อฝส. ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย |
| 5. พญ.ภาวณา อังคสิทธิ์ | ผู้แทนรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข |
| 6. นพ.ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์ | ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพ สาขาทา |
| 7. พญ.สายจินต์ อีสี่ประดิษฐ์ | ประธานร่วมคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพ สาขาทา |
| 8. นพ.ไชยสิทธิ์ เทพชาตรี | คณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพ สาขาทา |
| 9. นพ.อนุกุล ไทยถนอม | คณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพ สาขาทา |
| 10. นพ.อนิรุทธิ์ สุวัตรจริยากุล | คณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพ สาขาทา |
| 11. นางปิยนุช โป่งฟ้า | สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ |
| 12. นพ.วิทยา ปานะโปย | รองประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพ สาขาทา เขตสุขภาพที่ 2 |
| 13. นพ.รามศ สุขุมลไพบูลย์ | ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพ สาขาทา เขตสุขภาพที่ 3 |
| 14. นพ.ประภาส ลีสุทธิพรชัย | ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพ สาขาทา เขตสุขภาพที่ 4 |
| 15. นพ.ศุภชัย ศุภพฤกษ์สกุล | ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพ สาขาทา เขตสุขภาพที่ 5 |
| 16. นพ.นพดล แฉ่งแรง | ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพ สาขาทา เขตสุขภาพที่ 7 |
| 17. นพ.ประวีณ ตันตพระภา | ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพ สาขาทา เขตสุขภาพที่ 9 |
| 18. นพ.โสภณ นิลกำแหง | ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพ สาขาทา เขตสุขภาพที่ 10 |
| 19. พญ.ปณณดา ชินกุลกิจนิวัฒน์ | ผู้แทนประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพ สาขาทา เขตสุขภาพที่ 11 |
| 20. นพ.พรประสิทธิ์ จันทระ | ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพ สาขาทา เขตสุขภาพที่ 12 |
| 21. นพ.ณัฐวุฒิ รอดอนันต์ | ภาควิชาจักษุวิทยา โรงพยาบาลศิริราช |
| 22. นพ.ปริญญ์ ไรจนพงศ์พันธุ์ | หัวหน้าภาควิชาจักษุวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
| 23. นพ.ชัยรัตน์ เสาวพฤทธิ | หัวหน้าภาควิชาจักษุวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี |
| 24. พญ.อรวิณี จตุทอง | หอกองจักษุกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า |
| 25. นพ.โอฬาร สุวรรณอภิชน | หัวหน้าภาควิชาจักษุวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น |

/26. นพ.แมนสิงห์...

- | | |
|-----------------------------|--|
| 26. นพ.แมนสิงห์ รัตนสุคนธ์ | หัวหน้าภาควิชาจักษุวิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ |
| 27. นพ.วรภัทร วงษ์สวัสดิ์ | หัวหน้าภาควิชาจักษุวิทยา โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) |
| 28. พญ.มัญชิมา มะกรวัฒนะ | หัวหน้าภาควิชาจักษุวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |
| 29. พญ.ธารสุข เกษมทรัพย์ | ภาควิชาจักษุวิทยา โรงพยาบาลวชิรพยาบาล |
| 30. นพ.ชวศักดิ์ กนกกันตพงษ์ | ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. นพ.พิชชา ธัญพิมล | ภาควิชาจักษุวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |
| 2. นางสาวนิรัชรา ด้านสวัสดิ์ | สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท |
| 3. นางนิตยร์ดี วีระปรีชานนท์ | กลุ่มงานยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) |
| 4. นางสาวณิชนัน ชุมสิงห์ | กลุ่มงานยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) |
| 5. นางสาวพวงลักษณ์ กลิ่นกุหลาบ | กลุ่มงานยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) |

เริ่มประชุม เวลา 09.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน Service Plan สาขาตา : ตามที่ สบพข. ได้ให้ Service Plan สาขาจักษุ นำร่องการจัดสรร โควตาทุนฝึกอบรมจักษุแพทย์และที่เรียน ซึ่งมีใช้เป็นารพิจารณาตาม Gap minimum requirement เท่านั้น แต่รวมถึงเหตุผลความจำเป็นอื่นเพิ่มเติม โดยคณะกรรมการ Service Plan สาขาจักษุ ได้รับเรื่องไปดำเนินการ แล้วและในการประชุมครั้งนี้ได้นำข้อมูลเข้ามาพิจารณาลงรายละเอียดเป็นรายจังหวัดทั้ง 12 เขตสุขภาพ เพื่อสรุป หามติร่วมกันและส่งมอบข้อมูลให้ สบพข. ใช้เป็นแนวทางในการจัดสรรโควตาต่อไป

ประธาน รพท. : แจ้งระเบียบวาระการประชุมให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

1. เรียนแจ้งความคืบหน้าและสรุปข้อมูลที่ได้จากการประชุมครั้งที่ 2/2561
2. รับรองรายงานการประชุม
3. ประธานกลุ่มนำเสนอที่ประชุมสรุปความต้องการทุนจักษุแพทย์
4. แบ่งกลุ่มย่อย ประชุมประธานเขตสุขภาพและสถาบันฝึกอบรมคู่ความร่วมมือ
5. ที่ประชุมร่วมกันสรุปจำนวนแพทย์ที่จะส่งฝึกอบรม ส่งมอบต่อให้ ผอ.สบพข.
6. เรื่องอื่น ๆ

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ความคิดเห็นที่ประชุม : ไม่มี

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมการพัฒนาระบบจักษุแบบยั่งยืน ครั้งที่ 2/2561

/ระเบียบวาระ...

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว

ประธาน รทท. :

1.การจับคู่ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนแพทย์กับเขตสุขภาพ

- ทบทวนคู่ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนแพทย์กับเขตสุขภาพ จากการประชุมครั้งที่ 2/2561 วันที่ 28 มีนาคม 2561 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าได้จับคู่ความร่วมมือกับเขตสุขภาพที่ 12 แต่เนื่องจากมี Training น้อย จึงแจ้งขอลอนจากเขตฯ 12 ทั้งนี้ได้แจ้งให้ประธานเขตสุขภาพที่ 12 ทราบแล้ว

เขตสุขภาพที่ 12 : ขอจับคู่ใหม่กับ รพ.เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) และรพ.รามารักษ์

มติที่ประชุม : เห็นชอบและอนุมัติ

2.การส่งต่อผู้ป่วยข้ามสังกัดจากกระทรวงสาธารณสุขไปยังโรงเรียนแพทย์

- กรณี refer ข้ามสังกัดจากกระทรวงสาธารณสุขไปยังโรงเรียนแพทย์ เนื่องจากโรงเรียนแพทย์มีการเรียกเก็บในอัตรามหาวิทยาลัยที่ค่อนข้างสูง ทางราชวิทยาลัยจักษุจะนำประเด็นนี้เข้าประชุมหาวิธีวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 โดย สปสช. ร่วมกับ 4 ฝ่าย ได้แก่ ราชวิทยาลัยจักษุฯ กลุ่มสถาบันแพทย์(UHosNet) กระทรวงสาธารณสุข และ Service Plan สาขาศึกษา เพื่อหาข้อสรุปการแบ่งอัตราค่าใช้จ่าย และเพื่อให้โรงพยาบาลต้นสังกัดที่ส่งต่อผู้ป่วยไม่รับภาระค่าใช้จ่ายมากเกินไป

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

3.สรุปการจัดตั้ง Center 12 เขตสุขภาพ

ความคิดเห็นที่ประชุม :

- ได้มีการหารือเพื่อกำหนดปัจจัยการจัดตั้ง Retina center ในที่ประชุมคณะกรรมการ Service Plan กระทรวงฯ ไว้ดังนี้ 1.มี Retina specialist 2 คนขึ้นไป 2.เมื่อกำหนดที่ตั้ง Retina Center เขตฯต้องจัดสรรทรัพยากรไปให้ทั้งแพทย์ พยาบาล เครื่องมือ กล้องผ่าตัดและห้องผ่าตัด ซึ่งเป็นการลงทุนค่อนข้างสูง 3.มีการแบ่งพื้นที่ส่งต่อให้ชัดเจน ดังนั้นเสนอว่าต้องมีการจัดระบบให้ชัดเจน เช่น การกำหนดทุน Retina เพื่อให้มีการคงอยู่ในระยะยาว

- เมื่อมีการลงทุนจัดตั้ง Retina center แล้ว ต่อมาไม่มี Retina specialist เสนอให้มีการบริหารจัดการ ยืมเครื่องมือหรือสามารถย้ายครุภัณฑ์ไปให้รพ.อื่นในเขตฯเดียวกันที่มี Retina specialist ได้ ตัวอย่างเช่น เขตสุขภาพที่ 12 ใช้งบประมาณเขตฯในการจัดซื้อเครื่องมือครุภัณฑ์ และมีการย้ายครุภัณฑ์ภายในเขตฯเดียวกันได้ ยกเว้นกรณีจัดซื้อครุภัณฑ์โดยใช้งบเงินบำรุงของโรงพยาบาล ต้องขึ้นอยู่กับนโยบายผู้อำนวยการและข้อตกลงร่วมกันว่าสามารถย้ายครุภัณฑ์ไปจุดอื่นที่มีความพร้อมได้หรือไม่

ประธาน รทท. : จากการประชุมครั้งที่แล้วมอบให้ประธาน Service Plan ทั้ง 12 เขตสุขภาพชี้จุด Training center และทีมเลขาฯ ได้ประสานขอข้อมูลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว **(เอกสาร 1)**

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธาน รทท. : นำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

1.ทุนเขตสุขภาพ

ความคิดเห็นที่ประชุม :

- ขอทราบความคิดเห็นของทุนเขตสุขภาพ ตามที่บางเขตสุขภาพได้วิเคราะห์กรอบอัตรากำลังแล้วพบว่าขาดจักษุแพทย์ แต่ทราบว่ามีทุนเขตฯ ซึ่งไม่ได้แจ้งว่าหลังจบการศึกษาแล้วจักษุแพทย์ที่รับทุนเขตฯจะกลับไปสังกัดโรงพยาบาลใด จึงต้องการทราบว่าในการวิเคราะห์กรอบอัตรากำลังครั้งนี้เขตสุขภาพได้รวมทุนเขตฯไว้หรือไม่

- บางเขตฯได้นับรวมไว้ในจำนวนจักษุแพทย์ที่ศึกษาต่อทั้งหมดของเขตฯแล้ว รวมถึงผู้ที่ไม่ได้รับทุนของโรงพยาบาลแต่ได้รับทุนเขตฯด้วย แต่บางเขตแจ้งว่ามีทุนเขตฯ แต่ไม่ได้นับรวมไว้ในจำนวนจักษุแพทย์ที่ศึกษาต่อ เพราะยังไม่ทราบว่าหลังจบการศึกษาแล้วจะไปสังกัดที่ใด

- ทุนเขตฯมี 2 แบบ คือ แบบที่ทราบว่าหลังจบการศึกษาแล้วทราบต้นสังกัด และแบบที่ไม่ทราบว่าหลังจบการศึกษาแล้วจะไปสังกัดที่ใด ขอให้เขตฯระบุให้ชัดเจนว่าทุนเขตทั้งหมดมีกี่ทุนและจักษุแพทย์ที่รับทุนเขตเมื่อจบการศึกษาแล้วจะกลับมาสังกัดที่โรงพยาบาลใดบ้าง หรือเขตฯได้จัดสรรทุนไว้ให้โรงพยาบาลใดแล้วบ้าง เพื่อลดความซ้ำซ้อนของการจัดสรรทุนและเพื่อจัดสรรทุนไปให้โรงพยาบาลอื่นในเขตที่ขาดจักษุแพทย์ต่อไป

ประธาน Service Plan สาขาตา : ประธานเขตสุขภาพควรระบุทุนเขตฯให้ชัดเจนว่าจะจัดสรรให้โรงพยาบาลใดบ้าง

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

2.สรุปความต้องการทุนจักษุแพทย์ 12 เขตสุขภาพ

ความคิดเห็นที่ประชุม :

- กรอบอัตรากำลังตามแผนพัฒนาระบบบริการ (Service Plan) เพื่อจัดสรรโรคตาแพทย์ประจำบ้านปี 2562 กระทรวงสาธารณสุข กำหนดระดับโรงพยาบาลที่ควรมีจักษุแพทย์คือระดับ M1 ขึ้นไป แต่มีบางโรงพยาบาลที่มีระดับน้อยกว่า M1 เช่น ระดับ F2, F1, M2 ที่มีจักษุแพทย์หรือกำลังส่งไปเรียน เขตสุขภาพควรมีการวางแผนใหม่ต่อไป และที่ประชุมเสนอให้พิจารณาจัดสรรทุนให้โรงพยาบาลตั้งแต่ระดับ M1 ขึ้นไปก่อน (**เอกสาร 2**)

- บางเขตสุขภาพมีความต้องการทุนจักษุแพทย์เกินกรอบ ที่ประชุมเสนอว่าควรเป็นการวางแผนปีต่อไป

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

ประธาน Service Plan สาขาตา เขตสุขภาพที่ 12 :

- รพ.ตรัง ขาดจักษุแพทย์ แต่ไม่มีความต้องการจักษุแพทย์เพิ่ม

- รพ.สุโขทัย-ลก ไม่มีจักษุแพทย์ปฏิบัติงาน รวมถึงเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ทำให้มีแพทย์ขอย้ายออกหลายคน แต่ได้มีการวางแผนบริหารอัตรากำลังทดแทนไว้ล่วงหน้า 3 ปี โดยส่งจักษุแพทย์ไปศึกษาต่อและเสนอขอทุนเพิ่ม จึงต้องการ 1 ทุน

- รพ.หาดใหญ่ มีจักษุแพทย์หลายคนและเกินกรอบอัตรากำลังเพราะเป็นทั้ง Training center, Retina center และ Cornea center

- สรุปเขตสุขภาพที่ 12 มีความต้องการ 5 ทุน เรียงลำดับความต้องการจักษุแพทย์ ดังนี้ 1.รพ.พัทลุง 2.รพ.สงขลา 3.รพ.สุโขทัย-ลก 4.รพ.ยะลา 5.รพ.ปัตตานี

มติที่ประชุม : เห็นชอบและอนุมัติ

/ผู้แทนประธาน...

ผู้แทนประธาน Service Plan สาขาทา เขตสุขภาพที่ 11 :

- รพ.กระบี่ มีจักษุแพทย์ต้องการโอนย้ายกลับบ้านจังหวัดตรัง 1 คน และมี resident ที่กำลังเรียนได้แจ้งไว้ว่าเมื่อใช้ทุนครบ 3 ปี ต้องการขอย้ายกลับกรุงเทพฯ 1 คน ทำให้ รพ.กระบี่ เหลือจักษุแพทย์ปฏิบัติงานจริง 2 คน ซึ่งตามกรอบ SP ได้ถึง 5 คน แต่ขอเพียง 1 ทุน และหากได้รับทุนปี 2562 จะส่งศึกษาต่อ Retina ในอนาคตเนื่องจากรพ. มีเครื่องมือผ่าตัด PPV อยู่แล้ว

- รพ.ชุมพรเขตอุดมศักดิ์ มีจักษุแพทย์ 2 คน กรอบ SP ได้ถึง 5 คน แต่ต้องการเพียง 1 ทุน

- รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช มีจักษุแพทย์อายุมากกว่า 53 ปีขึ้นไป 4 คน ต้องการทุน 4 คน แต่ขอเพียง 1 ทุน

- รพ.สุราษฎร์ธานี ขาด 3 คน แต่ยังไม่พร้อมด้านสถานที่และเครื่องมือ, ตึก Excellence กำลังสร้างและพร้อมใช้งานในอีก 5 ปี อีก 2 ปี จึงจะขอทุน resident 3 ทุน

- มี รพศ. ทั้งหมด 3 แห่ง คือ 1.รพ.สุราษฎร์ธานี ดูแลคนไข้ 4 จังหวัดคือ จังหวัดชุมพร, ระนอง, สุราษฎร์ธานี และกระบี่ 2.รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช มีพื้นที่ขนาดใหญ่ ดูแลคนไข้จังหวัดนครศรีธรรมราช และ 3.รพ.ภูเก็ต ดูแลคนไข้จังหวัดภูเก็ตและพังงา

- มี Training center 2 แห่ง คือ รพ.สุราษฎร์ธานี (รับ Training จักษุแพทย์จาก มอ. 2-3 คน/ปี และ มธ. 6-7 คน/ปี) และ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช (รับ resident ของ มอ.ได้ 2 คน/ปี) เนื่องจากมีแพทย์จะเกษียณหลายคน

- มี 3 จังหวัดที่มีแพทย์ Retina specialist ได้แก่ รพ.สุราษฎร์ธานี มี Retina specialist 2 คน(ย้ายมาจากรพ.กระบี่ 1 คน) ยังไม่พร้อมเปิด consult จึงส่งต่อไป consult ที่รพ.นครศรีธรรมราชซึ่งมี Retina specialist 1 คน โดยทั้ง 2 จังหวัดรับ refer คนไข้จากจังหวัดภาคใต้ตอนบน และภาพรวมยังส่ง refer ไปมอ. จำนวนมาก และรพ.ภูเก็ตมี Retina specialist 2 คน แต่ยังไม่พร้อมด้านเครื่องมือและห้องผ่าตัดและไม่พร้อมรับ refer จากที่อื่น เนื่องจากมีคนไข้ของจังหวัดที่รับผิดชอบจำนวนมาก จึงยังไม่รับเป็น Retina center และเขตฯ มีแผนเพิ่มจำนวนจักษุแพทย์และส่งไปเรียนแพทย์เฉพาะทาง Retina เพื่อผลักดันให้ทุกจังหวัดมี Retina specialist

- Cornea center มี 2 แห่ง คือ รพ.สุราษฎร์ธานี และรพ.ทุ่งสง ประชุมร่วมกันวางแผนทำ PKP ปี 2560 10-15 คน เป็นไปตามแผน และปี 2562 กำลังทำโครงการขอซื้อเครื่องมือ DMEK, DSEK แต่ยังขาดงบประมาณซื้อเครื่องมือ endothelial cell count

- สรุปเขตสุขภาพที่ 11 มีความต้องการ 3 ทุน เรียงลำดับความต้องการจักษุแพทย์ ดังนี้ 1.รพ.ชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 2.รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช 3.รพ.กระบี่

มติที่ประชุม : เห็นชอบและอนุมัติ

ประธาน Service Plan สาขาทา เขตสุขภาพที่ 10 :

- เขตฯ 10 ไม่มีโรงเรียนแพทย์รองรับ มีประชากรประมาณ 4.5 ล้านคน มีรพ.ขนาดใหญ่ 2 แห่ง คือ รพ.สมเด็จพระยุพราชเดชอุดม และรพ.สรรพสิทธิประสงค์ มี Retina specialist 1 คน แต่ไม่ได้ผ่าตัดเนื่องจากมีปัญหาด้านสุขภาพจึง refer ส่งไปรพ.ขอนแก่นทั้งหมด

- สรุปตามกรอบ SP ขาดจักษุแพทย์ 9 คน แต่ต้องการเพียง 4 ทุน ได้แก่ รพ.วารินชำราบ รพ.ศรีสะเกษ รพ.อำนาจเจริญ รพ.ยโสธร และมีทุนเขตฯ หลังจบการศึกษากลับไปสังกัดที่รพ.สมเด็จพระยุพราชเดชอุดม 1 คน

- เดิมมีการจัดตั้ง Retina center 2 แห่ง ต่อมาเขตฯ สนับสนุนจักษุแพทย์ให้ไปเรียนเพิ่มเติมด้าน Retina

/ปัจจุบัน...

ปัจจุบันจึงมี Retina center 3 แห่ง คือ รพ.สมเด็จพระยุพราชเดชอุดมที่สามารถผ่าตัดได้ทีเดียว ต่อมาวางแผนเพิ่ม Retina center อีก 2 แห่ง คือ ที่รพ.ศรีสะเกษ ซึ่งมี Retina specialist แล้ว อยู่ระหว่างขอเครื่องมือ และขยายเพิ่มที่รพ.มุกดาหาร เพื่อรองรับผู้ป่วยจากรพ.ยโสธร และรพ.อำนาจเจริญ

- สรุปเขตสุขภาพที่ 10 มีความต้องการ 4 ทุน เรียงลำดับความต้องการจักษุแพทย์ ดังนี้ 1.รพ.อำนาจเจริญ 2.รพ.ยโสธร 3.รพ.ศรีสะเกษ 4.รพ.วารินชำราบ

มติที่ประชุม : เห็นชอบและอนุมัติ

ประธาน Service Plan สาขาทา เขตสุขภาพที่ 9 :

- เขตฯ 9 มีพื้นที่ขนาดใหญ่ มีจำนวนประชากรมาก และมีรพ.ขนาดใหญ่ 3 แห่ง ได้แก่ รพ.มหาสารคาม นครราชสีมา มีแพทย์ 300 คน, มีจักษุแพทย์ 7 คน เป็น Retina center และมี Retina specialist 4 คน ตามกรอบ SP ยังขาด 1 คน, รพ.เทพรัตนนครราชสีมา ขาด 1 คน แต่ไม่ได้ขอทุนเพิ่ม, รพ.ปากช่องนานา มีจักษุแพทย์ 1 คน ไม่ได้ขอทุนเพิ่ม, รพ.บัวใหญ่ ระดับ M2 ไม่มีกรอบจักษุแพทย์ แต่มีจักษุแพทย์ 1 ตำแหน่ง เพราะรับย้ายมา, รพ.สุรินทร์ มีจักษุแพทย์ 4 คน ต้องการขยาย 1 คน เพื่อไปเรียน Retina จึงต้องการ 1 ทุน, รพ.ปราสาท ต้องการ 1 ทุน, รพ.บุรีรัมย์ มี Retina แต่ไม่ได้ทำผ่าตัดเนื่องจากมีการร้องเรียนเรื่องทำ Retina ต้องการ 2 ทุน แต่พิจารณาให้เพียง 1 ทุน, รพ.นางรอง ขาด 2 คน แต่ไม่ได้ขอทุนเพิ่ม, รพ.ชัยภูมิ ต้องการ 1 ทุน, รพ.ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ ไม่ได้ขอทุนเพิ่ม ทั้งนี้ขอเรียนปรึกษาที่ประชุมให้จัดสรรทุนเป็นเขตเพื่อให้เขตฯไปพิจารณาบริหารจัดการจัดสรรโรงพยาบาลต่อไป

- โรงพยาบาลที่มี Retina specialist ได้แก่ รพ.มหาสารคามนครราชสีมา 4 คน และมีการรับส่งต่อ, รพ.สุรินทร์ 1 คน และรพ.ชัยภูมิ 1 คน

- เขตฯ 9 มีทุนเขตฯและระบุชื่อสังกัดโรงพยาบาลของผู้รับทุนหลังจบการศึกษาไว้อย่างชัดเจน

- สรุปเขตสุขภาพที่ 9 มีความต้องการ 5 ทุน เรียงลำดับความต้องการจักษุแพทย์ ดังนี้ 1.รพ.สุรินทร์ 2.รพ.มหาสารคามนครราชสีมา 3.รพ.ชัยภูมิ 4.รพ.ปราสาท 5.รพ.บุรีรัมย์

ประธาน รพท. : ขอให้ระบุชื่อสังกัดโรงพยาบาลของผู้รับทุนหลังจบการศึกษาไว้ให้ชัดเจนในเบื้องต้นก่อน แต่หากมีการเปลี่ยนแปลงภายหลังมอบอำนาจให้ประธานเขตสุขภาพบริหารจัดการภายในเขตฯได้

มติที่ประชุม : เห็นชอบและอนุมัติ

ประธาน Service Plan สาขาทา เขตสุขภาพที่ 7 :

- เขตฯ 7 มีการรณรงค์ผ่าตัดต้อกระจกอย่างต่อเนื่อง โดยผ่าตัดวันละ 50 case ในวันศุกร์ วันเสาร์ และวันอาทิตย์ มีโรงพยาบาลขนาดใหญ่ ระดับ A มี 2 แห่ง คือ รพ.ขอนแก่น และรพ.ร้อยเอ็ด และระดับ S มี 2 แห่ง คือ รพ.มหาสารคาม และรพ.กาฬสินธุ์ มีประชากรรับผิดชอบจังหวัดละ 1 ล้านกว่าคน มีจักษุแพทย์รวมทั้งเขตฯ 23 คน กำลังศึกษา 5 คน และอายุ 53 ปีขึ้นไป 2 คน ดังนั้นมีจักษุแพทย์ปฏิบัติงานจริงเพียง 16 คน รับผิดชอบผ่าตัดต้อกระจก 9,000 ตา

- มี Retina specialist ครบทุกรพ. มีจักษุแพทย์ครบทุกอนุสาขา รพ.ร้อยเอ็ด มีจักษุแพทย์ไปศึกษา 4 คน ทำให้มีการะงานเพิ่มขึ้น คิดตามกรอบ SP แล้วไม่ขาดจักษุแพทย์ แต่ถ้าคิดในภาพรวมเมื่อเทียบจำนวนจักษุแพทย์กับประชากรที่รับผิดชอบอาจจะไม่เพียงพอ รวมทั้งเขตฯขอทุนเพียง 2 ทุน จัดสรรให้กับรพ.มหาสารคาม และรพ.กาฬสินธุ์ แต่หากได้รับพิจารณาเพิ่มอีก 1 ทุน จะจัดสรรให้กับ รพ.ร้อยเอ็ด รวมความต้องการทั้งหมดเป็น 3 ทุน

/สรุปเขตสุขภาพ...

- สรุปเขตสุขภาพที่ 7 มีความต้องการ 3 ทุน เรียงลำดับความต้องการจักษุแพทย์ ดังนี้ 1.มหาสารคาม 2.ร้อยเอ็ด 3.กาฬสินธุ์

มติที่ประชุม : เห็นชอบและอนุมัติ

ประธาน Service Plan สาขาทา เขตสุขภาพที่ 5 :

- เขตฯ 5 มีความต้องการจักษุแพทย์ 6 ทุน ดังนี้ 1.รพ.ราชบุรี ขาด 3 คน แต่ต้องการ 1 ทุน, รพ.บ้านโป่ง ขาด 4 คน แต่ต้องการ 1 ทุน, รพ.โพธาราม ขาด 1 คน ต้องการ 1 ทุน, รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า ขาด 4 คน ต้องการ 1 ทุน, รพ.สมุทรสาคร เกินกรอบ แต่ต้องการ 1 ทุน จึงขอให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณา, รพ.สมเด็จพระยุพราช ขาด 1 คน ต้องการ 1 ทุน

- สรุปเขตสุขภาพที่ 5 มีความต้องการ 5 ทุน เรียงลำดับความต้องการจักษุแพทย์ ดังนี้ 1.รพ.ราชบุรี 2.รพ.บ้านโป่ง 3.รพ.โพธาราม 4.รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า 5.รพ.สมเด็จพระยุพราช

ประธาน รพท. : ให้โรงพยาบาลที่เกินกรอบ SP แต่มีความต้องการทุน ขอให้สถาบันผลิตได้ร่วมพิจารณาหารือร่วมกับเขตฯ ในช่วงการประชุมแบ่งกลุ่มย่อย

มติที่ประชุม : เห็นชอบและอนุมัติ

ประธาน Service Plan สาขาทา เขตสุขภาพที่ 4 :

- ภาพรวมเขตฯ ถ้าคิดตามกรอบ SP ขาด 13 คน แต่เมื่อพิจารณาตาม FTE พบว่าเกินกรอบ ทั้งนี้ได้เรียนสอบถามผู้ตรวจเขตสุขภาพที่ 4 ทราบและเมื่อพิจารณารายโรงพยาบาล พบว่า รพ.สระบุรี ขาด 3 คน ต้องการ 1 ทุน และมีรพ.ปทุมธานี, รพ.พระนครศรีอยุธยา, รพ.สมเด็จพระนารายณ์มหาราช และรพ.อินทบุรี ต้องการแต่ละ 1 ทุน รวมเป็น 4 ทุน ขอเป็นทุนของเขต เนื่องจากเมื่อพิจารณาตาม FTE ตามบริบทของโรงพยาบาลบางแห่งไม่สามารถเติมบุคลากรได้ จึงต้องจัดสรรไปให้รพ.อื่นที่ขาดจักษุแพทย์และยังไม่เกินกรอบอัตราค่าจ้าง ทั้งนี้เขตฯขอบริหารทุนตามความเหมาะสมต่อไป

- สรุปเขตสุขภาพที่ 4 มีความต้องการ 4 ทุน เรียงลำดับความต้องการจักษุแพทย์ ดังนี้ 1.รพ.สระบุรี 1 ทุน และลำดับที่ 2-4.ขอทุนเขต 3 ทุน

มติที่ประชุม : เห็นชอบและอนุมัติ

ประธาน Service Plan สาขาทา เขตสุขภาพที่ 3 :

- มีความต้องการ 5 ทุน ดังนี้ 1.รพ.สวรรค์ประชารักษ์ ขาด 1 คน ต้องการ 1 ทุน เพื่อจะทดแทนบุคลากรที่จะขอย้าย, รพ.กำแพงเพชร ขาด 1 คน ต้องการ 1 ทุน, รพ.พิจิตร ขาด 2 คน ต้องการ 1 ทุน, รพ.อุทัยธานี ขาด 2 คน จะขอย้าย 1 คน ต้องการ 1 ทุน, รพ.ชัยนาท ขาด 2 คน ต้องการ 1 ทุน สำหรับรพ.ชุมแสง แต่เดิมเป็นรพ.ระดับ M มีเครื่องมือผ่าตัดจากเงินบริจาค ต่อมาถูกปรับระดับลดลงเป็น ระดับ F1 ทำให้ไม่มีจักษุแพทย์

- สรุปเขตสุขภาพที่ 3 มีความต้องการ 5 ทุน เรียงลำดับความต้องการจักษุแพทย์ ดังนี้ 1.รพ.สวรรค์ประชารักษ์ 2.รพ.อุทัยธานี 3.รพ.ชัยนาท 4.รพ.กำแพงเพชร 5.รพ.พิจิตร

มติที่ประชุม : เห็นชอบและอนุมัติ

ประธาน Service Plan สาขาทา เขตสุขภาพที่ 2 :

- เขตฯ 2 มีความต้องการ 4 ทุน รพ.เพชรบูรณ์ มีจักษุแพทย์ 2 คน ไปช่วยงานบริหาร 1 คน กำลังศึกษา 2 คน ต้องการ 1 ทุน, รพ.สุโขทัย ต้องการ 1 ทุน, รพ.อุดรดิตถ์ ต้องการ 1 ทุน และรพ.ศรีสวรรค์สุโขทัย มีจักษุแพทย์ 1 คน

/กำลังศึกษา...

กำลังศึกษา 2 คน และกำลังจะขอย้าย 1 คน ต้องการ 1 ทูน รวมทั้งเขตฯ 2 ต้องการ 4 ทูน

- Retina center ของเขตฯ มี 2 แห่ง โดยตั้งอยู่ที่ รพ.พุทธชินราช มี Retina specialist 2 คน และรับ refer จากทั้งในเขตฯ 2 และเขตฯ 3 และวางแผนเป็น Cornea center ด้วย และ Retina center อีกแห่งอยู่ที่ รพ.อุตรดิตถ์ มี Retina specialist 1 คน

- สรุปเขตสุขภาพที่ 2 มีความต้องการ 4 ทูน เรียงลำดับความต้องการจักษุแพทย์ ดังนี้ 1.รพ.เพชรบูรณ์ 2.รพ.อุตรดิตถ์ 3.รพ.ศรีสังวรฯ 4.รพ.สุโขทัย

มติที่ประชุม : เห็นชอบและอนุมัติ

ประธาน Service Plan สาขาทา : เนื่องจากเขตสุขภาพที่ 1, 6 และ 8 ไม่มีประธาน Service Plan สาขาทาหรือผู้แทนมาเข้าร่วมและชี้แจงข้อมูลให้ที่ประชุมทราบ จึงมอบ พญ.สายจินต์ อีสี่ประดิษฐ์ ประธานและสรุปข้อมูลให้ที่ประชุมทราบดังนี้

- สรุปเขตสุขภาพที่ 1 มีความต้องการ 4 ทูน เรียงลำดับความต้องการจักษุแพทย์ ดังนี้ 1.รพ.นครพิงค์ เชียงใหม่ 2.รพ.พะเยา 3.รพ.น่าน 4.รพ.ลำปาง

มติที่ประชุม : เห็นชอบและอนุมัติ

- สรุปเขตสุขภาพที่ 6 มีความต้องการ 5 ทูน เรียงลำดับความต้องการจักษุแพทย์ ดังนี้ 1.รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร 2.รพ.พุทธโสธร 3.รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร 4.รพ.พุทธโสธร 5.รพ.ระยอง

มติที่ประชุม : เห็นชอบและอนุมัติ

- สรุปเขตสุขภาพที่ 8 มีความต้องการ 3 ทูน เรียงลำดับความต้องการจักษุแพทย์ ดังนี้ 1.รพ.นครพนม 2.รพ.หนองคาย 3.รพ.เลย

มติที่ประชุม : เห็นชอบและอนุมัติ

ผอ.สบพข. : ขอขอบคุณประธาน Service Plan สาขาทาทุกท่าน ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการพิจารณาจัดสรรทุนจักษุแพทย์ ซึ่งมีความซับซ้อนในการพิจารณาจัดสรรทุน และเนื่องจากแต่ละเขตสุขภาพมีทรัพยากรในเขตไม่เท่ากัน ขอให้ทุกท่านพิจารณาด้วยความเป็นกลาง และ สบพข. จะยึดถือข้อมูลสรุปจากราชวิทยาลัยจักษุเพื่อนำเข้าเสนอในการประชุมคณะกรรมการจัดสรรแพทย์ประจำบ้าน และปรับเปลี่ยนข้อมูลให้น้อยที่สุด

ความคิดเห็นที่ประชุม :

- การประชุมสรุปข้อมูลความต้องการจักษุแพทย์รายจังหวัดและรายเขตในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์สำหรับหัวหน้าสถาบันที่จะพิจารณาคัดเลือก resident ในปี 2562

- ตามที่ สบพข. แจ้งในที่ประชุมครั้งที่ 2/2561 ว่ากระทรวงฯ จัดสรรโควตาให้ 90% ของศักยภาพการ Training ได้ทั้งหมด และจากข้อมูลที่น่าเสนอวันนี้คิดเป็น 70% จึงขอเสนอที่ 75-80% เพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ขอรับทุนได้รับทุนเรียนทั้งหมด

- เสนอให้กำหนดเกณฑ์การพิจารณาทุนผู้สมัครแพทย์ประจำบ้านจักษุวิทยา

- เสนอให้พิจารณาเฉพาะข้อมูลของโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเท่านั้น ยังไม่นับโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม, กระทรวงศึกษาธิการ โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ และองค์การมหาชน และคิดเฉพาะโรงพยาบาล ระดับ M1 ขึ้นไปเท่านั้น

/กรณีโรงพยาบาล...

- กรณีโรงพยาบาลระดับ M1 ที่มี Retina specialist รวมถึง Retina specialist ที่ย้ายไปปฏิบัติงานในโรงพยาบาลที่มีขนาดเล็กลง ทำให้ทำงานได้ไม่เต็มศักยภาพ หรือโรงพยาบาลที่ส่งจักษุแพทย์ศึกษาต่อ sub board retina เพื่อความก้าวหน้า ซึ่งมีแนวโน้มย้ายออกสูง จึงขอให้ทางสถาบันที่รับผิดชอบพิจารณาในประเด็นนี้ด้วย

- เขตสุขภาพที่ 7 มีจักษุแพทย์น้อย เมื่อเทียบสัดส่วนจำนวนจักษุแพทย์ต่อประชากร ขอให้ที่ประชุมพิจารณาจัดสรรทุนให้เขตฯ ตามความเหมาะสม

- ต้องการให้มีการนำหลักการวิเคราะห์อัตราากำลังบุคลากรเทียบกับภาระงานของโรงพยาบาล (FTE) มาพิจารณาด้วย เช่น ในโรงพยาบาลที่ขาดจักษุแพทย์ 2 คน และได้รับการพิจารณาจัดสรรให้ทั้ง 2 ทุน แต่ FTE สามารถเพิ่มอัตรากำลังคนในโรงพยาบาลได้แค่ 1 คนเท่านั้น (ไม่สามารถให้ได้ทั้ง 2 ทุน) ทั้งนี้ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการพิจารณาข้อมูลของแต่ละเขตสุขภาพ

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

3.แบ่งกลุ่มย่อย ประชุมจับคู่ความร่วมมือ

ประธาน รทท. : แบ่งกลุ่มย่อย ประชุมจับคู่ความร่วมมือระหว่างประธาน Service Plan สาขาทาทั้ง 12 เขตสุขภาพ และสถาบันฝึกอบรมคู่ความร่วมมือ ร่วมหารือในประเด็นดังนี้

- 1.จำนวนโศกนาฏกรรมประจำบ้านที่เขตสุขภาพเสนอ และจำนวนที่สถาบันฝึกอบรมสามารถรับในปี 2562
- 2.ความร่วมมือทางด้านวิชาการและด้านการวิจัยที่เขตสุขภาพต้องการให้สถาบันฝึกอบรมช่วยสนับสนุน
- 3.การจัดตั้ง Center; Training Center, Retina center, Cornea center ในเขตสุขภาพ ต้องการให้จัดตั้งที่ไหนบ้าง และการฝึกอบรม Fellow
- 4.ระบบการส่งต่อผู้ป่วย ทั้งเรื่องอัตราค่าใช้จ่ายกรณีเขตสุขภาพส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงเรียนแพทย์ รวมถึงการส่งต่อที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องค่าใช้จ่าย

ความคิดเห็นที่ประชุม :

- ต้องการให้ราชวิทยาลัยฯและผู้เข้าร่วมประชุมร่วมกันกำหนดลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้สมัครรับทุนแพทย์ประจำบ้าน และมีหนังสือออกจากราชวิทยาลัยฯ

- ขอให้สถาบันฝึกอบรมพิจารณาบริหารทุนจักษุแพทย์ของคู่ความร่วมมือก่อนเป็นลำดับแรก และจะเป็นผลดีต่อแพทย์ที่สมัครขอรับทุนจากเขตสุขภาพ

- ในเขตสุขภาพที่ขาดแคลนจักษุแพทย์ เสนอให้เขตฯเปิดรับสมัครจักษุแพทย์ที่จบสำเร็จแล้วและมีความพร้อมไปปฏิบัติงานในพื้นที่ สำหรับประเด็นนี้ประธานราชวิทยาลัยฯฯ ขอให้นำไปพิจารณาในวาระประชุมอื่นต่อไป เพื่อวันนี้จะได้พิจารณาเรื่องตำแหน่งทุนกับ สปพช. ก่อน

- เสนอให้มอบประธาน Service Plan สาขาศึกษาของเขตสุขภาพและประธานเขตสุขภาพมีอำนาจในการตัดสินใจพิจารณาจัดสรรทุนให้กับเขตฯ เช่น เขตสุขภาพที่ 5 รับพิจารณาโศกนาฏกรรมให้กับรพ.บ้านแพ้วด้วย เนื่องจาก รพ.บ้านแพ้วเป็นหน่วยงานรับส่งต่อของกระทรวงสาธารณสุขและเป็นสมาชิกอยู่ในคณะกรรมการ Service Plan ของเขตสุขภาพที่ 5 มาตั้งแต่ต้น เพื่อให้เกิดระบบที่มีธรรมาภิบาล และให้คำนึงถึงโรงพยาบาลที่ขาดแคลนจักษุแพทย์ก่อนเป็นลำดับแรก

- สถาบันฝึกอบรมชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า จากศักยภาพการผลิตต่อปี สถาบันฝึกอบรมสามารถบริหารทุนโศกนาฏกรรมของกระทรวงสาธารณสุข(เขตสุขภาพ)หรือคู่ความร่วมมือตามที่ตกลงกันแล้ว ซึ่งจะต้องหาข้อสรุปจำนวนทุน

/ที่แต่ละแห่ง...

ที่แต่ละแห่งสามารถรับทุนได้ ให้ชัดเจนตั้งแต่เริ่มแรก เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนจักษุแพทย์ของประเทศ และทางสถาบันขอสงวนทุนบางส่วนให้กับหน่วยงานอื่นๆ ไว้ส่วนหนึ่ง

- สถาบันมีการเก็บหลักฐานในการพิจารณาทุนเพื่อป้องกันการฟุ้งร้อง และเสนอว่าต้องมีการวางแผนในระยะยาว

- ขอให้สถาบันเปิดรับพิจารณาทุนจากเขตสุขภาพ โดยให้ให้เกียรติการตัดสินใจของประธานเขตฯ ว่าแต่ละทุนที่เขตสุขภาพส่งมาได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการของเขตฯมาแล้ว และสามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนจักษุแพทย์ของแต่ละเขตฯได้

- เขตสุขภาพเสนอให้กระจายจำนวนโควตาทุนของแต่ละเขตสุขภาพให้กับคู่ความร่วมมือตามที่ได้ตกลงกันไว้

ผอ.สบพช. : เนื่องจากระบบการจัดสรรทุนของ สบพช. อยู่ภายใต้ระเบียบของ ก.พ. ตำแหน่งของราชการเมื่อลาออกไปแล้วทุกตำแหน่งต้องคืนส่วนกลาง

4.ที่ประชุมร่วมกันสรุปจำนวนแพทย์ที่จะส่งฝึกอบรม ส่งมอบต่อให้ ผอ.สบพช.

ความคิดเห็นที่ประชุม :

- ตามตารางและข้อตกลงต่างๆ อาจจะยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการของเขตฯที่ส่งผู้สมัครเข้ามาทั้งหมด และในปีหน้าราชวิทยาลัยฯ อาจต้องพิจารณาการประชุมลักษณะนี้ให้ครอบคลุมอีกหลายต้นสังกัด ผู้มีสิทธิเปิดทุนส่งเรียน ทั้งกรุงเทพมหานคร กระทรวงกลาโหม องค์กรมหาชน และทบวงมหาวิทยาลัย ฯลฯ เพื่อให้การทำงานในลักษณะนี้พัฒนาขึ้นอีก

- เสนอให้พิจารณาว่า ทางสถาบันฝึกฯ อาจจะออกเกณฑ์ในการพิจารณาให้ทราบทั่วกันว่า ทุนลักษณะไหน มีความสำคัญจำเป็นต่อประเทศ และให้น้ำหนักในการพิจารณามากกว่า เช่น ทุนเขต จะมีน้ำหนักพิจารณา มากกว่าทุนโรงพยาบาลจังหวัด หรือทุนโรงพยาบาลอำเภอ หรือทุนที่มาตรงคู่สถาบันที่มีความร่วมมือ หรือทุนเขตที่มีลำดับความขาดแคลนสูงกว่า เป็นต้น ซึ่งต่อไปเมื่อเป็นข้อมูลเหล่านี้เป็นที่เปิดเผยโปร่งใส อาจจะทำให้กระบวนการพิจารณาผู้สมัครตั้งแต่ระดับพื้นที่นั้น เพิ่มโอกาสการสอบที่สถาบันได้มากขึ้น

- ขอให้ประธาน Service Plan สาขาตา ทุกเขตสุขภาพชี้แจงแนวทางการขอรับทุนเขตฯให้ผู้ที่จะสมัครทราบด้วย

มติที่ประชุม : เห็นชอบและอนุมัติ สรุปดังนี้

- 1.กระจายจำนวนโควตาทุนของแต่ละเขตสุขภาพให้กับคู่ความร่วมมือ (เอกสาร 3)
- 2.สรุปจำนวนทุนแพทย์ประจำบ้านปี 2562 ทั้ง 12 เขตสุขภาพ และรายชื่อโรงพยาบาลทั้งหมดที่มีความต้องการทุนจักษุแพทย์ ปี 2562 รวมทั้งหมด 50 ทุน (เอกสาร 4)

3.คุณสมบัติของผู้สมัครแพทย์ประจำบ้านจักษุวิทยา ดังนี้

- 1) ตรวจสุขภาพร่างกาย, สุขภาพจิต และสุขภาพตา รวมถึงตาบอดสี Ishiharaและ 3 มิติ (sec of arc)
- 2) ภูมิสำเนาของผู้สมัครและสถานที่خذใช้ทุนหรือเหตุผลอื่นๆ เพื่อแสดงถึง “ความคงอยู่ของผู้สมัคร”
- 3) พฤติกรรมและเจตคติ: portfolio
- 4) ความสามารถพิเศษ
- 5) เกรดไม่ต่ำเกินไป ยกเว้นกลุ่ม repeater, F วิชาจักษุวิทยา, national license และ score

/ระเบียบวาระ...

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

ประธาน รท. : แจ้งเรื่องอื่นๆ ให้ที่ประชุมทราบ

1. จักษุแพทย์ที่เขตสุขภาพต้องการและแนวทางการเสนอข้อปรับแก้หลักสูตร

ความคิดเห็นที่ประชุม : อ้างอิงจากข้อมูลไลน์กลุ่มจักษุยั่งยืนดังนี้

- สอบถามที่ประชุมว่าในเขตสุขภาพมีปัญหาการทำ Glaucoma ในพื้นที่เขตสุขภาพหรือไม่ ต้องมีการวางแผนและออกแบบหลักสูตร เพื่อให้ general ophthalmologist สามารถทำได้ และหากต้องมีการทำผ่าตัดทางราชวิทยาลัยฯ ต้องไปแก้ไขหลักสูตรให้สามารถผ่าตัดได้และการดูแลแก้ไขปัญหาล้างผ่าตัด หรือหากไม่สามารถทำได้จำเป็นต้องมี Glaucoma center หรือไม่

- สภาพปัญหาทางตาในประเทศไทยตามที่ได้มีการวิจัยสำรวจของสมาคมจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2549-2550 มีสาเหตุสำคัญของภาวะตาบอด 5 ลำดับ ได้แก่ โรคต้อกระจก, โรคจอประสาทตา, โรคต้อหิน, โรคกระจกตา และสายตาสั้นผิดปกติ จึงได้กำหนดนโยบายลื้อไปตามสาเหตุของโรค เพื่อการแก้ไขปัญหาดูสุขภาพตาของประเทศ ทั้งนี้ พบว่ามีบางเขตสุขภาพออกไปคัดกรอง Glaucoma โดยที่ยังไม่มี National Guild line ที่ชัดเจนเหมือนโรคทางตาอื่นๆ

- หากโรงพยาบาลมีความต้องการจักษุแพทย์ที่สามารถทำหัตถการสำคัญเองจะได้หรือไม่ เช่น การ ECC, DCR, Trabeculectomy, Muscle correction ง่ายๆ, Simple buckling, PKP ฯลฯ ซึ่งทำได้โดยไม่ต้องรอส่งต่อหรือสามารถทำได้เพียงต้อเนื้อ ต้อกระจก แล้วรอไปเรียนต่อยอด และเหตุที่จักษุแพทย์ทำได้น้อยมาจากสาเหตุอะไร เป็นเพราะมี case น้อย หรือมี Fellow มากขึ้น จน Resident ได้แค่ดูหรือช่วย เมื่อช่วยกันดูเป้าหมายที่อยากเห็นแล้วค่อยไปออกแบบหลักสูตรการเรียน การสอน รวมถึงการสอบที่เหมาะสมกับประเทศไทย ดีกว่าให้แต่ละภาควิชา แต่ละชมรม ต่างคนต่างจัดการ และเรื่อง Academic excellence ที่ทางโรงเรียนแพทย์พยายามผลักดันเต็มที่

- การทำ scleral buckling ในปัจจุบัน ทางชมรมพิจารณาแล้วว่า เป็นเรื่องอันตรายมากที่จะให้ general ophthalmologist ทำ เพราะมี complication สูงมาก เสี่ยงต่อการถูกฟ้องร้อง นอกจากนี้พบว่า primary surgery สำหรับ retinal detachment นั้นสำคัญมาก ควรจะทำให้ retina ติดตั้งแต่ครั้งแรก การมาแก้ภายหลังจะยากกว่า และเคสที่เหมาะสมต่อการทำ scleral buckling ในปัจจุบันลดลงมาก การทำ PPV ได้รับความนิยมและรวดเร็วกว่า จนพบว่าแม้แต่ fellow retina ก็ได้ทำ buckling น้อย

- ต้องการให้ผลักดัน Retinal center อย่างจริงจัง หากกำหนดว่าต้องมี Retinal center ครอบคลุมเขตใน 3 ปี Retinal center ที่จะลงทุน เขตละ 1 แห่งก่อน มี Retina specialist โรงพยาบาลละ 3-4 คน ให้สามารถรับส่งต่อทั้งเขตได้ ทั้งในและนอกเวลา ต้องมีห้องผ่าตัดตาเพียงพอ (2-3 ห้องขึ้นไป) กระทรวงฯ สนับสนุนเครื่องมือ โรงเรียนแพทย์สนับสนุนการรับ train ให้ 12 center เท่านั้น ให้ครบก่อน ตอนนี้มี Retina specialist แล้วกี่คน (ทั้ง 12 center) โรงเรียนแพทย์อบรมได้ปีละกี่คน ถ้าช่วยกันวางแผน ภายในไม่กี่ปีจะมี Retinal center พร้อม

- เสนอให้ประเมินรายการ skill จำเป็นเพื่อให้ทันทักษะมากกว่าความรู้ในตำรา

- สถาบันฝึกอบรมต้องการรับฟังความคิดเห็นจากทุกเขตสุขภาพ เพื่อจะได้นำมากำหนดนโยบายการ Training resident ให้เหมาะสมต่อไป

/ประธาน...

ประธาน รจท. :

- ราชวิทยาลัยจักษุฯ ได้จัดทำเกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านฯ สาขาจักษุวิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) และประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ของราชวิทยาลัยจักษุฯ <http://rcopt.org/images/uploads/หลักสูตรราชวิทยาลัยจักษุ%20๒๕๖๐%20perfect.pdf> หน้า 74 หัวข้อ Procedure skill โดยที่รพ.รามาริบัติ มี จักษุแพทย์สาย glaucoma ได้ทำ Trabeculectomy ทุกคน แต่มี case buckling น้อย Skill ที่จำเป็น ขอให้ช่วยกันพิจารณาว่าต้องการให้ทางราชวิทยาลัยเพิ่มอะไรอีกบ้าง และขอยกประเด็นนี้ประชุมหารือในการประชุมในโอกาสต่อไป

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

2.การสนับสนุนทุนจักษุแพทย์สาขา Uveitis**ประธาน รจท. :**

- จักษุแพทย์ที่ได้รับทุนมาเรียนต่อในสาขาที่ขาดแคลน เช่น สาขา Uveitis หลังรับทุนมีความตั้งใจกลับไปปฏิบัติงานในพื้นที่ แต่มักจะถูกทางสถาบันดึงตัวไว้ จึงขอให้ผู้รับทุนกลับไปช่วยเหลือเขตฯที่เป็นผู้ให้ทุนด้วย

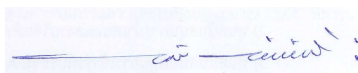
มติที่ประชุม : เห็นชอบ

ปิดประชุม เวลา 13.00 น.



(นางสาววงลักษณ์ กลิ่นกุหลาบ)

ผู้จัดรายการประชุม



(นพ.วรภัทร วงษ์สวัสดิ์)

ผู้ตรวจรายการประชุม



(รศ.นพ.อนุชิต ปุณณทลัณค์)

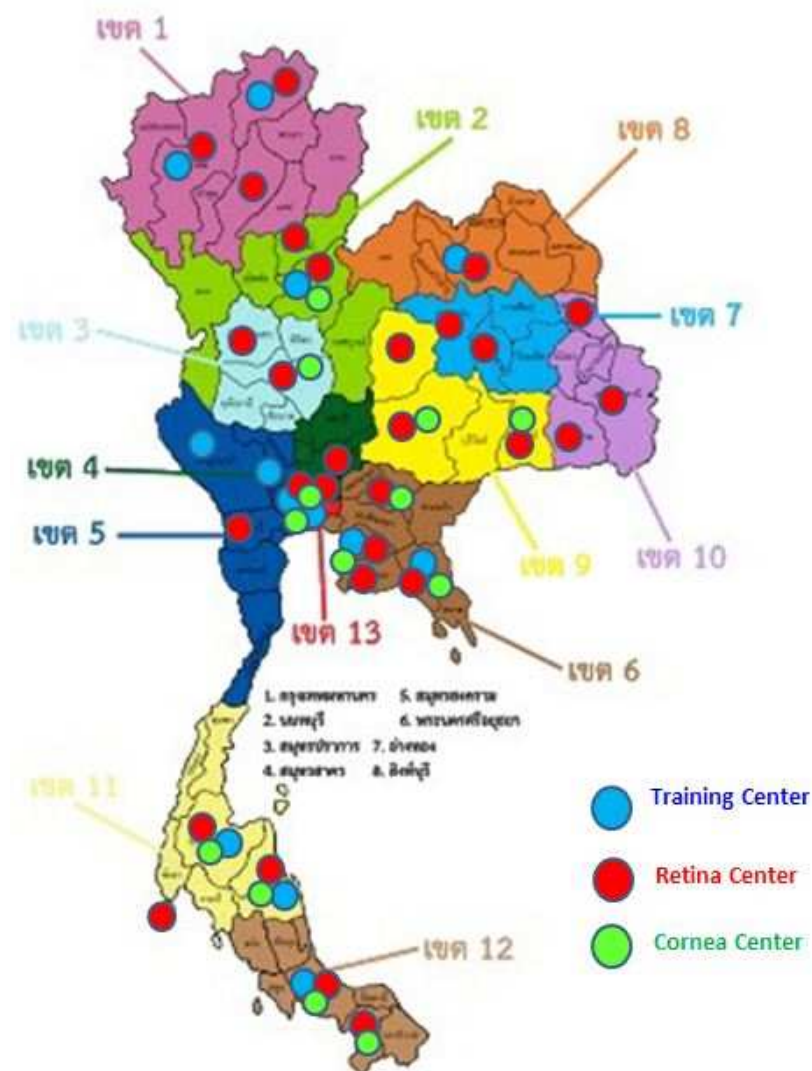
ผู้ตรวจรายการประชุม

เอกสาร 1

สรุป Center 12 เขตสุขภาพ

สรุป Center 12 เขต			
เขต	Training center	Retina center	Cornea center
1	รพ.เชียงใหม่, รพ.เชียงใหม่	รพ.เชียงใหม่, รพ.เชียงใหม่, รพ.ลำปาง	
2	รพ.พุทธชินราช	รพ.พุทธชินราช, รพ.อุดรธานี	รพ.พุทธชินราช
3		รพ.สวรรค์ประชารักษ์, รพ.กำแพงเพชร	รพ.สวรรค์ประชารักษ์
4		รพ.พระนั่งเกล้า, รพ.สระบุรี	รพ.พระนั่งเกล้า
5	รพ.นครปฐม, รพ.พหลพล, รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร, รพ.สมุทรสาคร	รพ.นครปฐม, รพ.ราชบุรี	รพ.นครปฐม
6	รพ.ชลบุรี, รพ.พระปกเกล้า	รพ.ชลบุรี, รพ.พระปกเกล้า, รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร, รพ.ระยอง	รพ.ชลบุรี, รพ.พระปกเกล้า, รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร
7		รพ.ขอนแก่น, รพ.มหาสารคาม	
8	รพ.อุดรธานี	รพ.อุดรธานี	
9		รพ.มหาสารคาม, รพ.สกลนคร, รพ.ชัยภูมิ	รพ.มหาสารคาม, รพ.สกลนคร
10		รพ.รพ.พิษณุโลก, รพ.ศรีสะเกษ(62), รพ.มุกดาหาร(63)	
11	รพ.นครศรีธรรมราช, รพ.สุราษฎร์ธานี	รพ.นครศรีธรรมราช, รพ.สุราษฎร์ธานี, รพ.ภูเก็ต	รพ.นครศรีธรรมราช, รพ.สุราษฎร์ธานี
12	รพ.หาดใหญ่	รพ.หาดใหญ่, รพ.ยะลา	รพ.หาดใหญ่, รพ.ยะลา

ที่มา : การประชุมการพัฒนาแบบจำลองเชิงพื้นที่ ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 23 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมแสงสิงแก้ว กรมการแพทย์



เอกสาร 2

ข้อมูลความต้องการจักษุแพทย์เขตสุขภาพที่ 1-12 ปี 2562

ข้อมูลความต้องการการจักษุแพทย์เขตสุขภาพที่ 1-12 ปี 2562															
เขต	โรงพยาบาล	ระดับ	จำนวน พยาบาลเวช	จำนวน จักษุแพทย์	อนุสาขา	กำลัง ศึกษา	อายุ 53 ปี	รวมจักษุ แพทย์ทั้งหมด	กรอบตาม SP	สรุป	ความต้องการ ทุนจักษุแพทย์	อนุสาขาที่ ต้องการเพิ่ม	Center		
													TC	RC	CC
เขต 1	รพ.ลำปาง*RC	Aใหญ่	16	6		1	1	6	6.8	- 2	1			1	
	รพ.น่าน	Sใหญ่	8	2		1		3	3.5	- 2	1				
	รพ.พะเยา	Sใหญ่	6	2	GI1	1		3	3.5	- 2	1				
	รพ.เชียงคำ พะเยา	M1	4	2				2	1.2		1				
	รพ.แพร่	Sใหญ่	12	4	C1	1		5	3.5						
	รพ.เชียงราย*TC,RC	Aใหญ่	15	7	R2	1		8	6.8				1	1	
	รพ.ลำพูน	Sใหญ่	8	3		2	1	4	3.5	- 1	1				
	รพ.ศรีสังวาลย์ แม่ฮ่องสอน	Sเล็ก	5	2	GI1			2	2.3	- 1	1				
	รพ.นครพิงค์ เชียงใหม่*TC	Aเล็ก	4	7	R2	1	3	5	4.6	- 1	4		1	1	
	รพ.จอมทอง เชียงใหม่	M1		3				3	1.2	1					
	รพ.ฝาง เชียงใหม่	M1	1	3	Oc1			4	1.2	2					
	รพ.สันป่าตอง เชียงใหม่	M2				2		2							
	รพ.แม่จัน เชียงราย	M2				1		1							
		รวม		79	41		12	5	48		- 6	10		2	3
เขต 2	รพ.พุทธชินราช*TC,RC,CC	Aใหญ่	7	7	R2,GI1,C1	3	3	7	6.8	- 1		Oc1,Neu,I,Uve,I	1	1	1
	รพ.พ.อุตรดิตถ์*RC	Aเล็ก	6	5	R1			5	4.6	- 1	1			1	
	รพ.ตากสินมหาราช	Sใหญ่	8	4	GI1	1	1	4	3.5	- 1					
	รพ.แม่สอด	Sใหญ่	5	2		1	1	2	3.5	- 3					
	รพ.สุโขทัย	Sใหญ่	6	2	GI1	1		3	3.5	- 2	1				
	รพ.ศรีสังวาลย์สุโขทัย	M1	5	1		2		3	1.2	1	1				
	รพ.เพชรบูรณ์	Sใหญ่	11	2		2		4	3.5	- 1	1				
	รพ.วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์	M2	4	1		1		2							
	ม.นเรศวร		1	10	R2,GI3,C2,Fed1,Oc1,Neu,I,Uve I	2		12							
	รพ.ค่ายฯ			1				1							
		รวม		53	35		13	5	43		- 8	4		1	2
เขต 3	รพ.สวรรค์ประชารักษ์*RC,CC	Aเล็ก	10	5	C1	1	1	5	4-6	- 1	1	โศกหรือมทำงาน		1	1
	รพ.กำแพงเพชร*RC	Sใหญ่	5	3	GI,R1	1		4	3-5	- 1	1			1	
	รพ.กจิตร	Sใหญ่	6	3				3	3-5	- 2	1				
	รพ.อุทัยธานี	Sใหญ่	5	3				3	3-5	- 2	1				
	รพ.ชัยนาท	Sใหญ่	3	2		1		3	3-5	- 2	1				
	รพ.ชุมแสง	F1	2												
		รวม		31	16	3	3	1	18		- 8	5	1	0	2

ข้อมูลความต้องการจักษุแพทย์เขตสุขภาพที่ 1-12 ปี 2562															
เขต	โรงพยาบาล	ระดับ	จำนวน พยาบาลเวช	จำนวน จักษุแพทย์	อนุสาขา	กำลัง ศึกษา	อายุ 53 ปีขึ้นไป	รวมจักษุแพทย์ ทั้งหมด (หัก 53)	กรอบตาม SP	สรุป	ความต้องการ ทุนจักษุแพทย์	อนุสาขาที่ ต้องการเพิ่ม	Center		
													TC	RC	CC
เขต 4	รพ.นครนายก	Sใหญ่	6	4	G12			4	3-5	- 1					
	รพ.พระนั่งเกล้า*RC,CC	Aเล็ก	14	7	G12,R1,C1	1	1	7	4-6	1		Oc1	1	1	
	รพ.เปาภิรมย์	Sใหญ่	8	3			1	2	3-5	- 3	1				
	รพ.คลองหลวง	F2	3												
	รพ.สิงห์บุรี	M2	1	1			1	0							
	รพ.พระนครศรีอยุธยา	Aเล็ก	4	5	R1		1	4	4-6	- 2	1				
	รพ.เสนา	M1	3			2		2	1-2						
	รพ.พระนารายณ์มหาราช	Sใหญ่	7	3	G1,R1	1		4	3-5	- 1	1				
	รพ.บ้านฉาง	M1	8	2			1	1	1-2	- 1					
	รพ.ชัยบาดาล	M2	3	1	G11			1							
	รพ.สิงห์บุรี	Sเล็ก	3	2		1		3	2-3						
	รพ.อินทร์บุรี	M1	2			1		1	1-2	- 1	1				
	รพ.สระบุรี*RC	Aใหญ่	10	6	Ped1,G1,R1		1	5	6-8	- 3	1			1	
	รพ.พระยาสุรเสนา	M1	7	1		1		2	1-2						
	รพ.เมวกเหล็ก	F2		1				1							
	รพ.อ่างทอง	Sใหญ่	6	3	G1,R1	2	2	3	3-5	- 2					
	รพ.วิเศษชัยชาญ	F1	1												
	รพ.โพธิ์ทอง	F2	2												
	รพ.ป่าโมก	F2	1												
		รวม		89	39		9	8	40		- 13	5		0	2
เขต 5	รพ.ประจวบคีรีขันธ์	Sเล็ก	5	2		2	1	3	2-3						
	รพ.หัวหิน	Sใหญ่	1	4	R2	1		5	3-5						
	รพ.พระจอมเกล้า	Sใหญ่	9	4	R1,G11	1		5	3-5						
	รพ.ราชบุรี*RC	Aใหญ่	12	4	R1,Oc1	1		5	6-8	- 3	1			1	
	รพ.โพธาราม	M1	6	1				1	1-2	- 1	1				
	รพ.ดำเนินสะดวก	M1	3	2			1	1	1-2	- 1					
	รพ.บ้านโป่ง	Sใหญ่	5	1				1	3-5	- 4	1				
	รพ.สมุทรสาคร*TC	Aเล็ก	11	7	C1,G12	1		8	4-6	2	1		1		
	รพ.กระทุ่มแบน	M1	3	2	Neu1			2	1-2						
	รพ.บ้านแพ้ว		6	16	C2,H4,G14,Oc1,M1,U1,Neu1		1	15							
	รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศ	Sใหญ่	2	1				1	3-5	- 4	1				
	รพ.พหลพลพยุหเสนา*TC	Sใหญ่	4	5	C1,G11		1	4	3-5	1			1		
	รพ.เมธารักษ์	M1	2	1			1	0	1-2	- 2					
	รพ.สมเด็จพระสังฆราช	M2		1	R1,C1			1							
	รพ.นครปฐม*	Aใหญ่	15	8	C5,R8,G16,Oc4,M1,Neu2,Lv1		2	6	6-8	- 2			1	1	1
	รพ.เมตตาประชารักษ์		40	24				24							
	รพ.สามพราน	M2	2	1				1							
	รพ.เจ้าพระยาอภัยภูธร*TC	Aเล็ก	7	6	G11,Oc1	1	2	5	4-6	- 1	1		1		
	รพ.เดิมบางนางบวช	F2	2	2	R1,G11			2							
	รพ.สมเด็จพระสังฆราช	M1	2	3			1	2	1-2						
รพ.อุทัยทอง	M2	1													
	รวม		138	95		7	10	92		- 15	6		4	2	1

ข้อมูลความต้องการจักษุแพทย์เขตสุขภาพที่ 1-12 ปี 2562															
เขต	โรงพยาบาล	ระดับ	จำนวน พยาบาลเวช	จำนวน จักษุแพทย์	อนุสาขา	กำลัง ศึกษา	อายุ 53 ปีขึ้นไป	รวมจักษุ แพทย์ทั้งหมด	กรอบตาม SP	สรุป	ความต้องการ ทุนจักษุแพทย์	อนุสาขาที่ ต้องการเพิ่ม	Center		
													TC	RC	CC
เขต 6	รพ.ชลบุรี*TC,RC,CC	Aใหญ่	10	6	C1,R1,Ped1	2	1	7	6-8	- 1			1	1	1
	รพ.พนัสสภิคม	M2	1	2	Gen2			2							
	รพ.บางละมุง	Sเล็ก	2	1	Gen1	1		2	2-3	- 1					
	รพ.สมุทรปราการ	Aเล็ก	9	6	Gen4,Gl1,Ne1	1		7	4-6	1					
	รพ.พุทธโสธร	Aเล็ก	11	2	Gen2	2		4	4-6	- 2	2				
	รพ.พระปกเกล้า*TC,RC,CC	Aใหญ่	7	7	Gen5,C1,Oc1	1	1	7	6-8	- 1			1	1	1
	รพ.ระยอง*RC	Aเล็ก	6	4	Gen2,C1,Gl1			4	4-6	- 2	1			1	
	รพ.แม่สอด	M1	2	1	Gen1	1		2	1-2						
	รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร* RC,CC	Aเล็ก	3	2	C1,R1	3		5	4-6	- 1	2			1	1
	รพ.สมเด็จพระเทพราชสระแก้ว	Sใหญ่	3	2	Gen2			2	3-5	- 3					
	รพ.อริยประเทศ	M1	1	1	Gen1	1		2	1-2						
	รพ.กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี	M1	4	1	Gen1	1		2	1-2						
	รพ.ตราด	Sใหญ่	6	3	Gen3	1	1	3	3-5	- 2					
	รวม		65	38		14	3	49		- 12	5		2	4	3
เขต 7	รพ.ขอนแก่น*RC	Aใหญ่	20	9	Gen1,Gl2,R1,C1,Oc1,Ped1	1		10	6-8	2				1	
	รพ.ร้อยเอ็ด	Aใหญ่	16	4	R1	4	1	7	6-8	- 1	1	R1, Gl1			
	รพ.มหาสารคาม*RC	Sใหญ่	16	5	R2,C1			5	3-5		1	Ped1		1	
	รพ.กาฬสินธุ์	Sใหญ่	17	5	Oc1,C1		1	4	3-5	- 1	1	C1,R1,Gl1			
		รวม		69	23		5	2	26		-	3		0	2
เขต 8	รพ.หนองบัวลำภู	Sใหญ่	9	4			1	3	3-5	- 2					
	รพ.อุดรธานี*TC,RC	Aใหญ่	16	11	R2,Gl2,C1,Oc1,Neu1,		2	9	6-8	1			1	1	
	รพ.สกลนคร	Aเล็ก	19	7	Gl1,Oc1,R1		1	6	4-6						
	รพ.นครพนม	Sใหญ่	12	4			1	3	3-5	- 2	1				
	รพ.หนองคาย	Sใหญ่	8	4				4	3-5	- 1	1				
	รพ.เลย	Sใหญ่	6	3	R1		1	2	3-5	- 3	1				
	รพ.บึงกาฬ	Sเล็ก	6	2	Oc1	1		3	2-3						
	รวม		76	35		1	6	30		- 7	3		1	1	0
เขต 9	รพ.มหาสารคามราชชนก*RC,CC	Aใหญ่	30	7	R3,C1,Oc1			7	6-8	- 1	1			1	1
	รพ.เทพรัตน์	M1		1				1	1-2	- 1					
	รพ.ปากช่องนานา	M1		1		1		2	1-2						
	รพ.บัวใหญ่	M2		1				1							
	รพ.สุรินทร์*RC,CC	Aใหญ่	11	4	R1,C1	2	1	5	6-8	- 3	1			1	1
	รพ.ปราสาท	M1	3	2	Ped1			2	1-2		1				
	รพ.บุรีรัมย์	Aใหญ่	11	6	R1,Gl1,Oc1	1		7	6-8	- 1	1				
	รพ.นางรอง	Sใหญ่	5	3				3	3-5	- 2					
	รพ.ชัยภูมิ*RC	Sใหญ่	11	3	R1,Gl1	1		4	3-5	- 1	1			1	
	รพ.ภูเขียวเฉลิมพระ	M1	2	2				2	1-2						
	รวม		73	30		5	1	34		- 9	5		0	3	2

เอกสาร 3

จำนวนทุนที่รับฝึกอบรมโดยประมาณระหว่างคู่ความร่วมมือโรงเรียนแพทย์กับเขตสุขภาพ ปี 2562

จำนวนทุนที่รับฝึกอบรมโดยประมาณระหว่างคู่ความร่วมมือโรงเรียนแพทย์กับเขตสุขภาพ ปี 2562													
เขต	มติประชุมได้รับ จัดสรรทุนปี62	จุฬา 7/10	ศิริราช 7/10	รามฯ 6/8	มช. 4/5	มช. 2-3/4	มอ. 3/4	ราชวิถี 4/7	พระมงกุฎ 1/5	เมตตาฯ 5/5	มธ. 3/7	วชิระ 1/2	รวมทุน
1	4	1			3								4
2	4		2-3		1								3-4
3	5			1-2					1		2		4-5
4	4	1						1	1		1		4
5	5		2-3							2			4-5
6	5	2						3					5
7	3					1				2			3
8	3	1	1-2										2-3
9	5	2		3									5
10	4					2					1	1	4
11	3		1-2				1						2-3
12	5			2			2			1			5
รวม	50	7	6-10/10	6-7	4	3	3	4	1	5	3-4	1	

ที่มา : สรุปตามมติที่ประชุมการพัฒนาารระบบจัดรูปแบบยั่งยืน ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 23 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมแสงสิงแก้ว กรมการแพทย์ และแก้ไขเพิ่มเติม 2พ.ค.61

หมายเหตุ : ตารางนี้เป็นเพียงแนวทางเพื่อประกอบการพิจารณา มิได้บังคับใช้

เอกสาร 4

สรุปความต้องการทุนจักษุแพทย์ 12 เขต ปี 2562

สรุปความต้องการทุนจักษุแพทย์ 12 เขต ปี 2562									
เขต	พยาบาล	จักษุ	กำลัง	อายุ>	รวม	ขาด	ความ	ได้รับ	เรียงตามลำดับ รพ.ที่ขอทุน(จำนวนคน)
สุขภาพ	เวชศา	แพทย์	ศึกษา	53 ปี	จักษุ		ต้องการทุน	จัดสรรทุน	
เขต 1	79	41	12	5	48	- 6	10	4	1.รพ.นครพิงค์ เชียงใหม่(1) 2.รพ.พะเยา(1) 3.รพ.น่าน(1) 4.รพ.ลำปาง(1)
เขต 2	52	24	11	5	43	- 8	4	4	1.รพ.เพชรบูรณ์(1) 2.รพ.อุดรดิตถ์(1) 3.รพ.ศรีสะเกษ(1) 4.รพ.สุโขทัย(1)
เขต 3	31	16	3	1	18	- 8	5	5	1.รพ.สวรรค์ประชารักษ์(1) 2.รพ.อุทัยธานี(1) 3.รพ.ชัยนาท(1) 4.รพ.กำแพงเพชร(1) 5.รพ.พิจิตร(1)
เขต 4	89	39	9	8	40	- 13	5	4	1.รพ.สระบุรี(1) 2-4.ทุนเขต 4(3)
เขต 5	92	55	6	9	92	- 15	6	5	1.รพ.ราชบุรี(1) 2.รพ.บ้านโป่ง(1) 3.รพ.โพธาราม(1) 4.รพ.พระพุทธเลิศหล้า(1) 5.รพ.เจ้าพระยาอภัยมราช(1)
เขต 6	65	38	14	3	49	- 12	5	5	1.รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร(1) 2.รพ.พุทธโสธร(1) 3.รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร(1) 4.รพ.พุทธโสธร(1) 5.รพ.ระยอง(1)
เขต 7	69	23	5	2	26	-	3	3	1.มหาสารคาม(1) 2.ร้อยเอ็ด(1) 3.กาฬสินธุ์(1)
เขต 8	76	35	1	6	30	- 7	3	3	1.รพ.นครพนม(1) 2.รพ.หนองคาย(1) 3.รพ.เลย(1)
เขต 9	73	30	1	1	34	- 9	5	5	1.รพ.สุรินทร์(1) 2.รพ.มหาสารคามราชสีห์(1) 3.รพ.ชัยภูมิ(1) 4.รพ.ปราสาท(1) 5.รพ.บุรีรัมย์(1)
เขต 10	37	28	5	3	30	- 8	4	4	1.รพ.อำนาจเจริญ(1) 2.รพ.ยโสธร(1) 3.รพ.ศรีสะเกษ(1) 4.รพ.วารินชำราบ(1)
เขต 11	57	41	2	8	35	- 15	3	3	1.รพ.ชุมพร(1) 2.รพ.นครคีรีธรรมราช(1) 3.รพ.กระบี่(1)
เขต 12	67	34	14	5	43	- 2	5	5	1.รพ.พัทลุง(1) 2.รพ.สงขลา(1) 3.รพ.สุโขทัย-สก(1) 4.รพ.ยะลา(1) 5.รพ.ปัตตานี(1)
รวม	787	404	83	56	488	- 103	58	50	

หมายเหตุ : บุคลากรจักษุในโรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ไม่รวมบุคลากรจากกลาโหม, กรมการแพทย์, องค์การมหาชน)

สรุปตามมติที่ประชุมการพัฒนาวิชาชีพแบบยั่งยืน ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 23 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมแสงสิงแก้ว กรมการแพทย์ และแก้ไขเพิ่มเติมวันที่ 2พ.ค.61

รายงานการประชุมจักษุยั่งยืน

ครั้งที่ 4/2561

วันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00-15.00 น.

ณ ห้องประชุมแสงสิงแก้ว อาคาร 1 กรมการแพทย์

รายชื่อผู้เข้าประชุม

1.นพ.อนุชิต	บุญญทลัณค์	ประธานราชวิทยาลัยจักษุแห่งประเทศไทย
2.นพ.ยุทธพงษ์	อัมสุวรรณ	เลขาธิการราชวิทยาลัยจักษุแห่งประเทศไทย
3.นพ.ศักดิ์ชัย	วงศ์กิตติรักษ์	ประธานวิชาการราชวิทยาลัยจักษุแห่งประเทศไทย
4.นพ.ปานเนตร	ปางพุดพิงศ์	ประธานคณะกรรมการเขตสุขภาพ สาขาตา
5.พญ.สายจินต์	อิสีประดิษฐ์	ประธานร่วมคณะกรรมการเขตสุขภาพ สาขาตา
6.นพ.วสันต์	แก้ววี	ประธานเขตสุขภาพ ที่ 1
7.พญ.มรกต	มั่งวิฑิตกุล	ประธานเขตสุขภาพ ที่ 3
8.นพ.ศุภชัย	ศุภพลฤกษ์สกุล	ประธานเขตสุขภาพ ที่ 5
9.นพ.นพดล	แข็งแรง	ประธานเขตสุขภาพ ที่ 7
10.นางอภิญญา	กันยาแสงศรี	พยาบาลวิชาชีพ เขตสุขภาพที่ 8
11.นางอนงนาต	มั่งสันติ	พยาบาลวิชาชีพ เขตสุขภาพที่ 9
12.นางกรทิพย์	มิตรวงษา	พยาบาลวิชาชีพ เขตสุขภาพที่ 10
13.นพ.ตามห์	มุกมณี	ประธานเขตสุขภาพ ที่11
14.นางอัญชสา	พูนเทพ	พยาบาลวิชาชีพ เขตสุขภาพที่ 12
15.พญ.งามแข	เรืองวรเวทย์	หัวหน้าภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
16.นพ.ปริบุญญ์	โรจนพงศ์พันธ์	หัวหน้าภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
17.นพ.ชัยรัตน์	เสาวฤทธิ์	หัวหน้ากลุ่มงานจักษุวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี
18.พท.หญิง ลดารัตน์	อำนวยชัย	โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
19.พญ.มัญชิมา	มะกรวัฒนะ	หัวหน้าภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
20.นพ.ไชยสิทธิ์	เทพชาตรี	คณะกรรมการเขตสุขภาพ
21.นพ.อนิรุทธ์	สุภวัตรจริยากุล	คณะกรรมการเขตสุขภาพ
22.นางนิตยรัตน์	วีระปรีชานนท์	งานนโยบายและยุทธศาสตร์ รพ.เมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง)
23.นางสาวณิชนน	ชุมสิงห์	งานนโยบายและยุทธศาสตร์ รพ.เมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง)
24.นางสาวพวงลักษณ์	กลั่นกุหลาบ	งานนโยบายและยุทธศาสตร์ รพ.เมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง)
25.ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ	ที่ปรึกษาสภาการพยาบาล	
26.นางศิริมา	ลีละวงศ์	รองผู้อำนวยการกองการพยาบาล
27.น.ส.กุลนันท์	อัฐนาถ	นายกสมาคมพยาบาลเวชปฏิบัติทางตาแห่งประเทศไทย
28.นางอุบลรัตน์	นันทิสวัสดิ์	ที่ปรึกษาสมาคมพยาบาลเวชปฏิบัติทางตาแห่งประเทศไทย
29.น.ส.ฐานกาญจน์	สุขวิสิษฐ์	อุปนายกคนที่ 1 สมาคมพยาบาลเวชปฏิบัติทางตาแห่งประเทศไทย
30.น.ส.จงรักษ์	มาลีเสน	อุปนายกคนที่ 2 สมาคมพยาบาลเวชปฏิบัติทางตาแห่งประเทศไทย
31.นางเอื้องพร	พิทักษ์สังข์	ประธานชมรมพยาบาลและบุคลากรทางจักษุไทย

32.ผศ.ดร.มุกดา	เดชประพนธ์	โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
33.นางสุนันทา	อรุณจักร	รพ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี
34.น.ส.เมตตา	ห้วงสุข	รพ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี
35.นางกิตติยา	คลับคล้าย	รพ.สามโคก จ.ปทุมธานี
36.นางสาววาสนา	เข็มทอง	รพ.อัมพวา สมุทรสงคราม
37.นางอิงอร	ลัมวัฒนาถาวรกุล	รพ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
38.นางวิไลวรรณ	รุ่งเรือง	รพ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
39.นางจิตติมา	ศรศุภรัตน์	กระทรวงสาธารณสุข
40.น.ส.วิไลวรรณ	ไชยวาริต	กระทรวงสาธารณสุข
41.นางศศิญา	กุลวรารักษ์พัฒน์	พยาบาลวิชาชีพ เขตสุขภาพที่1
42.ดร.ละมิตร์	ปึกขาว	พยาบาลวิชาชีพ เขตสุขภาพที่4
43.นางนิตยา	นราพิสุทธิ	พยาบาลวิชาชีพ เขตสุขภาพที่3
44.นางสุนทราวดี	เรียงพิเชฐ	สภากาชาด
45.ร.อ.หญิงนิรัชญา	บุญแสน	พยาบาล ร.พ. พระมงกุฎเกล้า
46.ผศ.จรงค์	ศุภกิจเจริญ	กรรมการหลักสูตรเวชปฏิบัติทางตา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
47.น.ส.กนกอร	พูนเปี่ยม	พยาบาลรับผิดชอบหลักสูตรเวชปฏิบัติทางตา โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง)
48.นางบุศราคัม	วิบุตร์	พยาบาลรับผิดชอบหลักสูตรเวชปฏิบัติทางตา โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง)
49.นางสมพร	เหลียมเย็นใจ	พยาบาลเวชปฏิบัติทางตา รพ.ราชวิถี
50.นพ.พิชา	ธัญพิมล	รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
51.นพ.พชรพล	ศิลปสัมฤทธิ์	รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
52.นางบุบผา	สุวรรณฉัตรกุล	ประธานหลักสูตรพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง)

วาระที่ 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ

ประธานราชวิทยาลัยจักษุแห่งประเทศไทย แจ้งต่อที่ประชุม ดังนี้

1.1 MOU ระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกับราชวิทยาลัยจักษุแพทย์และจักษุยั่งยืน

สืบเนื่องจากการประชุมการพัฒนาแบบจักษุแบบยั่งยืนได้มีการประชุมมาแล้ว 3 ครั้ง ครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งที่ 4 การประชุมที่ผ่านมาเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับจักษุแพทย์ พยาบาลจึงไม่ได้เข้าร่วมประชุม การประชุมครั้งนี้เป็นการจัดประชุมที่เกี่ยวข้องกับพยาบาลจึงขอกล่าวถึงที่มาของการพัฒนาระบบจักษุยั่งยืน ด้วยกระทรวงสาธารณสุขได้จัดทำบันทึกความร่วมมือ(MOU) กับราชวิทยาลัยทั้ง 13 แห่ง โดยกระทรวงสาธารณสุขให้ทางราชวิทยาลัยแต่ละแห่งไปคิดว่าต้องการทำอะไรร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และทางราชวิทยาลัยจักษุได้ทำการวิเคราะห์ร่วมกัน ปัญหาที่พบคือเรื่องของบุคลากร โดยจักษุแพทย์ พยาบาลเวชปฏิบัติทางตามีภาระงานหนัก บางท่านย้ายตามสามีหรือภรรยา จักษุแพทย์บางท่านย้าย

เข้าในเมืองหรือไปทำงานโรงพยาบาลเอกชน ไม่สามารถรักษาคนไว้ในพื้นที่ได้ ดังนั้นแล้วจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาระบบสาธารณสุขทางตา ทำอย่างไรให้คนอยู่ในระบบได้ โดยดูจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อการไม่คงอยู่ของคน ซึ่งพบว่ามีหลายปัจจัย ประกอบด้วยเรื่องค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม อัตราค่าจ้างคนที่ปฏิบัติงานมีน้อย ปัญหาการเงินการคลังของโรงพยาบาล ลำสุดกระทรวงสาธารณสุขก็พยายามที่จะแก้ปัญหาโดยการให้โรงพยาบาลเปิดคลินิกนอกเวลา ให้จักษุแพทย์และพยาบาลที่ทำงานในโรงพยาบาลต่างจังหวัดมีค่าตอบแทนที่เหมาะสมอยู่ได้โดยไม่ย้ายออกนอกพื้นที่บ่อย ซึ่งจะทำให้ระบบจักษุยั่งยืน

ที่ประชุม : รับทราบ

1.2 การแบ่งเขตสุขภาพ และจำนวนจักษุแพทย์ตามเขตพื้นที่

กระทรวงสาธารณสุขได้มีการแบ่งเขตสุขภาพ โดยแบ่งเป็น 12 เขต แต่ละเขตครอบคลุม 4-8 จังหวัด ประชากร 4-6 ล้านคน แต่การกระจายตัวของจักษุแพทย์และพยาบาลเวชปฏิบัติทางตายังมีน้อย เช่น เขต 3 มีจำนวนจักษุแพทย์ 16 คน พยาบาลเวชปฏิบัติทางตา 37 คน แต่บางเขตมีจำนวนจักษุแพทย์ 90 คน พยาบาลเวชปฏิบัติทางตา 138 คน

เขตสุขภาพ	พยาบาล เวชตา	จักษุ แพทย์	กำลังศึกษา	อายุ> 53 ปี	รวมจักษุ แพทย์	ขาด	ความ ต้องการทุน	ได้รับ จัดสรรทุน
เขต 1	79	41	12	5	48	- 6	10	4
เขต 2	52	24	11	5	43	- 8	4	4
เขต 3	31	16	3	1	18	- 8	5	5
เขต 4	89	39	9	8	40	- 13	5	4
เขต 5	92	55	6	9	92	- 15	6	5
เขต 6	65	38	14	3	49	- 12	5	5
เขต 7	69	23	5	2	26	-	3	3
เขต 8	76	35	1	6	30	- 7	3	3
เขต 9	73	30	1	1	34	- 9	5	5
เขต 10	37	28	5	3	30	- 8	4	4
เขต 11	57	41	2	8	35	- 15	3	3
เขต 12	67	34	14	5	43	- 2	5	5
รวม	787	404	83	56	488	- 103	58	50

จากตารางข้อมูลจักษุจะเห็นว่าบางเขตก็ยังมีขาดจักษุแพทย์ค่อนข้างเยอะ บางเขตก็ขาดน้อย ทางราชวิทยาลัยจักษุแห่งประเทศไทยและกระทรวงสาธารณสุขก็ได้หารือกับสถาบันฝึกอบรมว่าเราจะเพิ่มการ train ให้มากขึ้น ในปีที่ผ่านมาเราก็พยายามคุยหลายฝ่ายอยากเพิ่มจำนวน train ให้ได้ประมาณ 50 แต่สถาบันบางแห่งก็รับได้จำกัด เพราะมีทุนจากที่อื่นมา แต่ก็ตกลงกันว่าพยายามช่วยแพทย์ที่ได้รับทุนที่มาจากรัฐบาล

ที่ประชุม : รับทราบ

1.3 ข้อมูลพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา ตามเขตสุขภาพ

ข้อมูลพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา อาจารย์วัฒน์ย์ เย็นจิตร ได้เคยกล่าวว่าสัดส่วนพยาบาลเวชปฏิบัติทางตาที่ควรจะเป็นในเขตสุขภาพ คือ จักษุแพทย์ 1 คน ต่อ พยาบาลเวชปฏิบัติทางตา 3 คน ซึ่งถ้าดูตามสัดส่วนพยาบาลเวชปฏิบัติทางตายังขาดอีกจำนวนมาก เช่น ถ้ามี จักษุแพทย์ 500 คน ต้องมีพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา 1,500 คน สำหรับจำนวนพยาบาลเวชปฏิบัติทางตาที่มีปัจจุบัน มีดังนี้

เขต	จำนวนพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา (คน)	เขต	จำนวนพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา(คน)
1	79	7	69
2	52	8	76
3	31	9	73
4	89	10	37
5	92	11	57
6	65	12	67
รวม 787 คน			

การกระจายตัวพยาบาลเวชปฏิบัติทางตาในโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลจังหวัด ในบางโรงพยาบาล การกระจายตัวอาจมีความสัมพันธ์กับปริมาณงาน บางโรงพยาบาลก็ไม่สัมพันธ์กับปริมาณงาน เพราะบางคน train มาแล้วไม่ได้ใช้ความรู้ที่ไปเรียนมา บางคนต้องเปลี่ยนงานไปช่วยงานอื่น บางคนก็เปลี่ยนไปเป็นหัวหน้าเพื่อความก้าวหน้า จากข้อมูลปัญหาดังกล่าวจึงขอหารือกับ ประธาน service plan สาขาจักษุ 12 เขตสุขภาพ อาจารย์พยาบาลที่มาจากสถาบันการฝึกอบรมต่างๆ พยาบาลเวชปฏิบัติทางตาที่มาจากเขตสุขภาพ และผู้แทนพยาบาลเวชปฏิบัติทางตาที่มาจากโรงพยาบาลต่างๆ ว่ามีความคิดเห็นต่อการกระจายตัวของจำนวนพยาบาลในเขตสุขภาพอย่างไร ควรมีพยาบาลในเขตสุขภาพเท่าไร และ train ไปแล้วเขาจะอยู่ได้ไหม

ที่ประชุม : รับทราบ และให้ข้อคิดเห็นต่อการพัฒนาระบบจักษุยั่งยืน ดังนี้

ผู้แทนเขต 1 : ขอแสดงความยินดีที่ทางกระทรวงสาธารณสุขและราชวิทยาลัยจักษุแห่งประเทศไทย ได้เห็นความสำคัญเรื่องระบบจักษุยั่งยืน การจะยั่งยืนได้ต้องมีคน ซึ่งคนต้องมอง 3 เรื่อง ประกอบด้วย เรื่องที่ 1 ความก้าวหน้าของพยาบาลวิชาชีพเวชปฏิบัติทางตา เขาเรียนแล้วเขาจะก้าวหน้าอย่างไร

เรื่องที่ 2 การผลิต การใช้ การกระจาย ถ้าสังเกตดูจากข้อมูลจะพบว่าเขต 5 มีพยาบาลเวชปฏิบัติทางตามากที่สุด เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำควรตั้งเป้าให้มีพยาบาลเวชปฏิบัติทางตาอย่างน้อยเขตละ 100 คน จะได้ตั้งทุนได้ ทำให้การกระจายทั่วถึง ซึ่งในปัจจุบันสถาบันการผลิตประกอบด้วย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ การผลิตจะต้องมีแหล่งฝึกปฏิบัติที่สำคัญ การผลิตต้องมีทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติต้องมาหาแนวทางร่วมกันเพื่อให้ทั่วถึง ที่สำคัญคือต้องชัดเจน ว่าขาดเท่าไร ต้องการเท่าไร ต้องมี plan ที่ชัดเจน

เรื่องที่ 3 ความชัดเจนของทุน เรามี plan ที่ชัดแต่ไม่มีทุนสนับสนุน ความชัดเจนการทำงานก็จะไม่มี ไม่เกิด เป็นเรื่องลำบาก ปัจจุบันพยาบาลมีทั้งหมดประมาณ 2 แสน คน ควรตั้งเป้าว่าอย่างน้อยคนที่อยู่แผนกจักษุทุกคนต้องได้เรียน และพยาบาลในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลควรได้รับการพัฒนาทักษะเรื่องการคัดกรองเบื้องต้น

นพ.ศักดิ์ชัย วงศ์กิตติรักษ์ สรุปความคิดเห็นเขต 1 มี 3 ประเด็น

- 1 ความก้าวหน้าของพยาบาลวิชาชีพเวชปฏิบัติทางตา
2. การผลิต การใช้ การกระจาย ต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงในบริบทที่เหมาะสม

3. ความชัดเจนของทุน คือ พยาบาลที่ปฏิบัติงานในแผนกต่างๆทุกคนต้องได้เรียน และ พยาบาลในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งควรได้รับการพัฒนาทักษะเรื่องการค้ากรองเบื้องต้น

ผู้แทนเขตสุขภาพที่ 8

เขตสุขภาพที่ 8 มีการดำเนินงานเรื่องต่อกระจก โดยขับเคลื่อนผ่าน node ในเขต 8 มี node ทุกจังหวัด พยาบาลเวชปฏิบัติทางตามีบทบาทสำคัญมากใน node ถ้า node ไหนมีพยาบาลเวชปฏิบัติทางตาประจำ การทำงาน เช่น การคัดกรองต่อกระจก การคัดกรองเบาหวานเข้าจอตา ผลการดำเนินงานจะออกมาดี เขต 8 เคยขับเคลื่อนเรื่องพยาบาลเวชปฏิบัติทางตาประจำ node ในเขตแต่ไม่สำเร็จ จึงเสนอให้มีการขับเคลื่อนผ่านราชวิทยาลัยจักษุแห่งประเทศไทย ทางกระทรวงสาธารณสุข หรือผ่านทางคณะกรรมการ service plan และเรื่องการสนับสนุนทุนพยาบาลควรมีทุนสนับสนุน เนื่องจากถ้าโรงพยาบาลเป็นไปได้น้อย เพราะโรงพยาบาลมีวิกฤติทางการเงิน หรือการขอผ่านเขตเป็นเรื่องค่อนข้างยากเพราะสาขาตาจะจัดอยู่ลำดับท้ายๆ

ผู้แทนเขตสุขภาพที่ 7

เขตสุขภาพที่ 7 มีการทำงานเป็น Node เป็นโซน ที่เป็น Node ก็จะเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่ ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง พยาบาลเวชปฏิบัติทางตาเขตสุขภาพที่ 7 เราใช้ศักยภาพแบบเต็มที่ แต่มีปัญหาการกระจายตัวลงไปโรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็ก พยาบาลเวชปฏิบัติทางตาส่วนใหญ่ยังมีการกระจุกตัวอยู่ในโรงพยาบาลจังหวัด สำหรับเรื่องการขอทุนเพื่อมาเรียนจะได้้น้อยมากเพราะสาขาจักษุจะเป็นสาขาท้ายๆที่จะได้รับการสนับสนุน สำหรับสิ่งที่สนับสนุนผู้ปฏิบัติงานด้านจักษุเขตสุขภาพที่ 7 ที่ผ่านมามีการอบรมฟื้นฟู ส่งเสริม วิชาการผู้ปฏิบัติงานด้านตา จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับผู้ปฏิบัติงาน เวทีนำเสนอผลงานต่างๆ

นพ.ศักดิ์ชัย วงศ์กิตติรักษ์ : รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญโดยเฉพาะการมี MOU ระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกับราชวิทยาลัยจักษุแห่งประเทศไทย ในประเด็นการพัฒนาบุคลากร และระบบบริการ ดังนั้นแล้วสิ่งสำคัญที่ต้องทำคือ

- วิเคราะห์ ความจำเป็นว่าต้องมีเท่าไร
- บทบาทหน้าที่ ของพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา การทำงานในหน้าที่มีมาก ดังนั้นการลดภาระงานโดยทีมสนับสนุน โดยสนับสนุนกลุ่มเจ้าหน้าที่เทคนิค นักทัศนมาตร สามารถลดภาระงานของพยาบาลได้ 30%

- กระทรวงสาธารณสุขต้องให้ความสำคัญต่อยุทธศาสตร์การจัดสรรบุคลากร
- การยอมรับบทบาทพยาบาลเวชปฏิบัติทางตาไม่ชัดเจน ถึงแม้ว่าปัจจุบันจะมีการขึ้นทะเบียนพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา และสิทธิประโยชน์
- สิทธิต้องชัดเจน เช่น จบไปจะได้สิทธิอะไร เพราะบางที่จบไปแล้วไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลย ความก้าวหน้าต้องชัดเจนจบไปจะก้าวหน้าอย่างไรนอกจากอาวุโส การคงอยู่ และการกระจายตัวของพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา ขอฝากให้สภาการพยาบาลดูแลและดำเนินการเพื่อให้พยาบาลเวชปฏิบัติทางตาได้เกิดภาคภูมิใจ

คุณนุष्มา สุวรรณฉัตรกุล : - บทบาทของพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา ปัจจุบันมีหลักสูตรเวชปฏิบัติทางตา คนที่มาเรียนมีทั้งทำงาน OR ผู้ป่วยใน ซึ่งเรามีความพยายามที่จะให้เป็นหลักสูตรเฉพาะทาง

ปัจจุบันโรงพยาบาลศิริราชมีการเปิดหลักสูตรเฉพาะทางแล้ว เสนอให้สำนักงานการพยาบาลมาช่วยกันทำหลักสูตรเฉพาะทางการพยาบาลเครื่องมือพิเศษจักษุ โดยมาร่วมกำหนดบทบาทพยาบาลมีอะไร ตัวชี้วัดอะไร และเทคนิคอะไรบ้าง

- เรื่อง ชุมชน และพยาบาลที่ปฏิบัติงานในชุมชน ปัญหาที่พบ คือ คนไข้ Blinding Cataract ที่อยู่ในชุมชน ส่วนใหญ่จะไม่เข้ามารับการรักษา คนไข้ได้รับการแก้ปัญหาหรือยอมรับรักษา กรณีมีพยาบาลในพื้นที่ลงไปคัดกรอง หรือมีหน่วยเคลื่อนที่ลงไปผ่าตัดในชุมชน จากประเด็นดังกล่าวเราจึงได้มีแนวคิดในการทำหลักสูตรพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา โดยทางโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ได้ผลิตไปแล้ว 2 รุ่น จำนวน 40 คน ซึ่งปีนี้เราก็จะติดตามประเมินผล

- เขตสุขภาพที่ 5 มีจัดทำหลักสูตร Basic eye nurse ซึ่งเกิดจากแนวคิดที่ว่าทุกสาขา service plan จะมี Nurse manager, Nurse coordinator แล้วก็เกิดปัญหาพยาบาลไม่สามารถมาเรียนหลักสูตร 4 เดือน เขตสุขภาพที่ 5 จึงได้ทำหลักสูตร Basic eye nurse 10 วัน เพื่อแก้ปัญหา โดยหลักสูตรนี้เป็นการเรียนภาคทฤษฎี 5 วันและภาคปฏิบัติ 5 วัน ซึ่งได้นำร่องทำในเขต 5

นพ.ไชยสิทธิ์ เทพชาตรี : -ปัจจุบันยังมีปัญหาความครอบคลุมของพยาบาล สัดส่วนของพยาบาลเวชปฏิบัติทางตาต่อจักษุแพทย์ ควรเป็นเท่าไรที่จะเหมาะสม ซึ่งสัดส่วนที่ใช้ 1:2 อาจเป็นไปได้แต่จะคิดจากอะไรเรามาช่วยกันหาแนวทางร่วมกัน การคิด FTE (Full Time Equivalent) เช่น ตาม population base ต้องคิดตาม รพ.ที่มีจักษุแพทย์, การคิดตามภาระงาน service base

- เรื่องการผลิต หลักสูตรระยะสั้นที่ทำคือ Eye Nurse ส่วนหลักสูตร 4 เดือน มีปัญหาเรื่องทุน ทุน1 คน ใช้งบประมาณ (เฉพาะค่าลงทะเบียน) 40,000 บาท บางแห่งที่ได้ทุนไปไม่สามารถส่งไปเรียนได้เนื่องจากไม่มีค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง

กองการพยาบาล : -ความก้าวหน้าทางวิชาชีพพยาบาลที่ผ่านมาได้มีการจัดทำ Mapping โดยยึดตามสัดส่วนแพทย์แต่เกิดปัญหาแพทย์ไม่อยู่คงที่ จะยึดตามแพทย์ไม่ได้ จึงได้มีการปรับใหม่โดยยึดตาม population base ความก้าวหน้าทางวิชาชีพพยาบาล NP (Nurse Practitioner) ตา 4 เดือนปัจจุบันอยู่ใน OPD ต้องเป็นหัวหน้า และได้มีการปรับเพิ่มอยู่ในกลุ่มตรวจรักษาพิเศษคือต้องใช้เครื่องมือพิเศษ

- จากการนิเทศพยาบาลที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยังวัด VA และคัดกรองเบื้องต้นยังทำไม่ได้ กองการพยาบาลมองว่าในส่วนของพยาบาลที่ปฏิบัติงานใน รพสต. ยังไม่จำเป็นต้องเรียนหลักสูตร 4 เดือน ควรเรียนแค่หลักสูตรระยะสั้น 2-3 วัน

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา : -เรื่องหลักสูตร โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาเคยมีแนวคิดที่จะผลิต NP ตาหลักสูตร 1 ปี โดยในหลักสูตรมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะสามารถนำไปใช้งานได้จริง

- เรื่องอัตรากำลังพยาบาล เวลาที่วิเคราะห์ FTE เราจะถูกจัดอยู่ลำดับท้ายๆ แต่งาน NP ตามีค่อนข้างเยอะ เสนอให้กองการพยาบาลช่วยจัดทำและคิดภาระงานให้ เพื่อความก้าวหน้า NP ตา

ผู้แทนเขต 12 : มีปัญหาเรื่องคิดคำนวณ ภาระงานมากแต่น้อย OPD 1:100 IPD 1:30 เวลาคิดภาระงานจะได้น้อย

ผู้แทนเขต 3 : - ตำแหน่งพยาบาลเครื่องมือพิเศษ ของ รพ.สวรรค์ประชารักษ์ ความก้าวหน้าต้องแข่งขันกับกลุ่มเครื่องมือพิเศษอื่น เช่น กลุ่มส่องกล้อง Bronchoscope ไตเทียม

- เรื่อง Job description NP ตา เสนอให้กองการพยาบาลกำหนดให้ NP ตาออกทำงานชุมชนด้วยอย่างน้อย 1-2 วันต่อสัปดาห์

นพ.ศุภชัย ศุภพฤษ์สกุล : การเปิดหลักสูตร NP ตา ของแต่ละสถาบันเปิดสอนพร้อมกันหรือไม่ หรือแต่ละสถาบันต่างหาคนมาเรียนเอง บางพื้นที่รู้ข่าวก็ได้มาเรียนบางพื้นที่ไม่รู้ข่าวก็ไม่ได้เรียน เราจะเน้นใน ส่วนของ NP ตา ในโรงพยาบาลชุมชนหรือระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เราต้อง Mapping ให้ชัดว่า ต้องพัฒนาระดับไหนก่อน โอกาสการส่งเรียนของ รพท. รพศ. รพช.และ รพสต. มีแค่ไหน

นพ.อนุชิต ปุณณทลิ่งค์ : สิ่งที่เราจะเสนอกกระทรวงเราต้องชัดเจนว่าเราทำอะไร งานเชี่ยวชาญ พิเศษมีอะไรบ้าง ปัญหาการทำงานที่เกิดขึ้น ความต้องการระยะสั้น 1 ปี 2 ปี 5 ปีต้องการเท่าไร

ข้อมูลจากสภาการพยาบาล

-ปัจจุบันมีการขึ้นทะเบียนพยาบาลเวชจำนวน 130 คน

-มีสถาบันผลิต 6 สถาบัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, โรงพยาบาลรามาธิบดีร่วมกับโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง),วิทยาลัยพยาบาลนครราชสีมา, โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) ร่วมกับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช ,มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

-กำลังพัฒนาหลักสูตรต้นแบบ ยังไม่หลักสูตรกลาง

-การเปิดสอนไม่ได้เปิดพร้อมกัน ซึ่งความเป็นจริง ก็ไม่ควรเปิดพร้อมกันเพราะจะไม่มีคนเรียนเนื่องจากพื้นที่จะขาดอัตรากำลัง

ผู้แทนโรงพยาบาลศิริราช

-โรงพยาบาลศิริราชมีการเปิดหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางจักษุ ขึ้นใหม่ หลักสูตรนี้ใช้สำหรับพยาบาลที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลระดับ Tertiary care เพราะทางโรงพยาบาลศิริราช คิดว่าหลักสูตร 4 เดือน NP ตา ยังไม่ตอบโจทย์ที่จะนำมาปฏิบัติงานในโรงพยาบาลระดับTertiary care ไม่สามารถนำมาใช้งานได้จริง

นพ.ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์ : การ designโรงพยาบาล ส่วนใหญ่แต่ละโรงพยาบาลจะมีจักษุ แพทย์ 1-2 คน ซึ่งโรงพยาบาลที่มีจักษุแพทย์คือโรงพยาบาลระดับ A,S โรงพยาบาลขนาดใหญ่จะมีการแยก การทำงานชัดเจน ในส่วนของ OPD,IPD ,OR และงานชุมชน ส่วนในโรงพยาบาลขนาดเล็กจะไม่ค่อยแยกการ ทำงานมีการทำงานแบบ Multipurpose บางวันเข้าห้อง OR บางวันต้องลงชุมชน พยาบาลเวชปฏิบัติทางตา ส่วนใหญ่ต้องทำงานแบบ Multipurpose และต้องลงชุมชนด้วย การ design หลักสูตรให้ดูความต้องการของ ชุมชน เช่น หลักสูตร Basic eye nurse 10 วัน,หลักสูตรเวชปฏิบัติทางตา 4 เดือน,หลักสูตรต่อยอดหลัง เวช ตา 2 เดือน ได้แก่ Refraction Muscle Retina Oculo หลักสูตรผ่าตัดทางตา 2 เดือน,หลักสูตรเฉพาะ ทางการพยาบาลจักษุ 4 เดือน

นพ.อนุชิต ปุณณทลิ่งค์ : หลักสูตรที่มีคือ 2 หลักสูตร หลักสูตรระยะยาวคือ NP (Nurse Practitioner) ตา 4 เดือน หลักสูตรระยะสั้น 10 วัน

1.4 แบ่งกลุ่มพยาบาลและนำเสนอความต้องการของทีมพยาบาล ระยะสั้น 1 ปี 2 ปี 5 ปี

กลุ่มที่ 1 : การคิดความต้องการพยาบาลคิดแบบ population base โดยการวิเคราะห์ FTE คิดจากพยาบาล 1 คน ต่อ ประชากร 30,000 คน โดยการวิเคราะห์ของกลุ่มเขต 7 มีความต้องการ 100 คน เขต 8 มีความต้องการ 94 คน เขต 9 มีความต้องการ 40 คน เขต 10 มีความต้องการ 110 คน

-ระยะ 1 ปี ทุกโรงพยาบาลชุมชนมี NP ตา 1 คน

-ระยะ 2 ปี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งส่งพยาบาลไปเรียนหลักสูตรทางตาระยะสั้น 10 วัน โดยงบประมาณมาจากงบ Service plan

-ระยะ 3 ปี NP ตา หลักสูตร 4 เดือน ควรมีเรียน Refraction Muscle

กลุ่มที่ 2 : การคิดความต้องการพยาบาลคิดแบบ patient base โดยแบ่งโรงพยาบาลเป็น 3 กลุ่ม กลุ่ม 1 คือ โรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลศูนย์ กลุ่มที่ 2 โรงพยาบาลชุมชน กลุ่มที่ 3 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

กลุ่ม 1 โรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลศูนย์ เอาหน้างานจริงมาคิด IPD 1:10 หมายความว่า ถ้าออร์ตตามี 30 เคียง จะมี NP ตา 3 คน OPD 1:30 ซึ่งใช้ตามเกณฑ์กองการพยาบาล ส่วน OR จะไม่มี NP ตา

กลุ่มที่ 2 โรงพยาบาลชุมชนต้องมี NP ตา ที่ละ 1 คน

กลุ่มที่ 3 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ส่วนใหญ่ทำงาน screening ให้เรียนหลักสูตรระยะสั้น

ตัวอย่าง เช่น โรงพยาบาลปทุมธานี มีออร์ตตา 24 เคียง NP ตา ที่ควรมี 2.4 คนใช้ OPD 150 คน NP ตา ควรมี 5 คน รวมโรงพยาบาลปทุมธานีควรมี 7.4 ปัจจุบัน มี NP ตา 8 คน ในเขตสุขภาพที่ 4 มีโรงพยาบาลชุมชนจำนวน 7 แห่ง ควรมี NP ตา 7 คน รวมทั้งเขตสุขภาพที่ 4 ควรมี NP ตา 14.4 คน ปัจจุบันมี 12 คน สรุปว่าควรเพิ่ม NP ตา 2.4 คนจะเพียงพอ

- แผนอบรมระยะสั้น : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จัดให้มีการอบรมหลักสูตร short course 100 %

- แผนระยะกลาง : โรงพยาบาลชุมชนควรมี NP ตา แห่งละ 1 คน 100 %

- แผนระยะยาว : มี NP ตาหลักสูตร 1 ปี 50 %

ที่ประชุม: รับทราบ และให้ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็นต่อการนำเสนอความต้องการของทีมพยาบาล ดังนี้

นพ.ไชยสิทธิ์ เทพชาตรี : - ถ้าคิดแบบ population base โดยอิงประชากรเป็นหลักถ้าอำเภอหนึ่งมีประชากร 90,000 คน มี NP ตา 3 คน แต่อำเภอนั้นไม่มีจักษุแพทย์เลยจะทำงานรูปแบบใด เป็นแนวคิดที่ตอบสนองความต้องการประชาชน

-ถ้าคิดความต้องการพยาบาลคิดแบบ patient base จะคิด 2 แบบ คือ แบบที่ 1 สถานบริการที่มีการให้บริการทางตา จะมีจักษุแพทย์ มีพยาบาล โดยพยาบาลคิดอัตราส่วนต่อคนไข้ OPD 1:30 ซึ่งเกณฑ์นี้ถูกกำหนดโดยกองการพยาบาล หน้าที่หลักมี 4 ด้าน คือ ส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟู ถ้าหน่วยงานที่มีบุคลากรเยอะมี Technical ก็สามารถออกไปให้บริการส่งเสริมสุขภาพทางตาได้ แบบที่ 2 สถานบริการที่ไม่มีการให้บริการทางตา คือไม่มีจักษุแพทย์แต่มีพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา หน้าที่หลักมี 3 ด้าน คือ ส่งเสริม ป้องกัน ฟื้นฟู

-เวลานำเสนอข้อมูลต่อกระทรวงสาธารณสุขเราต้องมีความชัดเจนว่าข้อมูลเป็นอย่างไร Gap อยู่ที่ไหน เพื่อการทรวงจะได้มีข้อมูลประกอบการพิจารณา และวางแผนสนับสนุน หากไม่ชัดเจนความเป็นไปได้ที่จะได้รับการสนับสนุนบุคลากรเป็นไปได้ค่อนข้างยาก

พญ.สายจิตต์ อธิ์ประดิษฐ์ : การคิดโดยยึดตามภาระงาน หรือคิดแบบ population base เป็นสิ่งที่ดีสามารถคิดได้หลายแบบ แต่มีบางโรงพยาบาลไม่ยึดตามแนวคิดนี้ เขาคิดตามภาระงานที่รับไหว

ผู้แทนโรงพยาบาลสินธุ์ : การคิดอัตราส่วนต่อคนไข้ OPD 1:30 อาจจะไม่ครอบคลุมในการทำงานเพราะพยาบาลเวชปฏิบัติทางตาต้องอยู่เวร เช้า บ่าย ดึก โดย 1 เวร ต้องมีพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา 6 คน จึงจะสามารถจัดเวรเช้า บ่าย ดึก เพื่อจะให้พยาบาลเวชปฏิบัติทางตาเป็นหัวหน้าเวรทุกเวร การดำเนินงานในรูปแบบนี้ค่อนข้างช่วยจักษุแพทย์ได้มากขึ้น ประชาชนได้รับบริการที่ปลอดภัย

นพ.ปริญญ์ ไรจน์พงศ์พันธ์:- การคิดแบบภาระงานในอนาคต (population base) หรือการคิดแบบหน้างาน (patient base) ก็สามารถคิดได้ทั้ง 2 แบบ การคิดแบบ population base ทำไว้เพื่อขอโควตาในการขอคน ส่วนการคิดแบบหน้างาน (patient base) ทำไว้เพื่อพิจารณาจัดสรรคนได้เพราะเวลาจัดสรรคนลงทำงานก็ต้องจัดสรรตามภาระงาน เพราะต่อไป หมอตา 1 คน ต้องมี พยาบาลช่วยมากกว่า 1 คน เช่น ต้องมี 3 คน คนที่ 1 ช่วย Treatment คนที่2 ช่วยตรวจ คนที่3 ช่วยในห้องผ่าตัด

นพ.นพดล แข็งแรง : การคิดแบบ population base ถ้ามีการตรวจตาผู้สูงอายุ 100 % การตรวจตาต้องใช้จักษุแพทย์และพยาบาลค่อนข้างเยอะ เราควรมองภาพของอนาคตมองภาพที่ใหญ่ ถ้าเรามองภาพเล็กจะทำให้เกิดปัญหาในอนาคตได้

นพ.ไชยสิทธิ์ เทพชาตรี :- การคิดแบบ population base 1 : 30,000 ทั้งประเทศ จะต้องการพยาบาลเวชปฏิบัติทางตาประมาณ 2,000 คน

-การคิดแบบ patient base แบ่งการคิดเป็น 2 แบบ
แบบที่1 โรงพยาบาลที่ให้บริการแบบมีจักษุแพทย์ แบบที่2 โรงพยาบาลที่ให้บริการแบบไม่มีจักษุแพทย์

-ประเด็นหลักสูตร ที่ประชุมได้มองว่าควรมีการพัฒนาจากหลักสูตร 4 เพิ่มขึ้น 1 ปีเพื่อความก้าวหน้า ถ้าหลักสูตร 1 ปี พยาบาลควรทำได้มากกว่านี้ ค่าตอบแทนต้องเยอะขึ้น และหลักสูตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้คิดหลักสูตร 3 ปี

-ผู้แทนเขตสุขภาพที่ 1 : บริบทของภาคเหนือภูเขาเยอะ การกระจายตัวอยู่ห่าง การเดินทางค่อนข้างยาก การเข้าถึงลำบาก เห็นด้วยที่จะมีการผลิต NP ตา โดยกระจายไปในแต่ละที่ ในช่วงปีแรกอาจจะมี Node ค่อยๆเติม NP ตา เพิ่มขึ้นในแต่ละปี ในส่วนของ โรงพยาบาลชุมชนควรเป็นหลักสูตร 4 เดือน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหลักสูตร 10 วัน

-นพ.ไชยสิทธิ์ เทพชาตรี : เสนอให้มีการคิดแบบภาพรวม โดยภาพรวม NP ตาควรมีเท่าไร 1 เขตควรมี NP ตาเท่าไร เสนอผ่านกระทรวงสาธารณสุข ผ่านคณะกรรมการ service plan ผ่านเขต ในโรงพยาบาลที่มีการรักษาทางตาให้ใช้ patient base ในโรงพยาบาลที่ไม่มีการรักษาทางตาให้ใช้ population base โดยให้พื้นที่คำนวณความต้องการเสนอขึ้นมา จากนั้นทำภาพรวมเชิงนโยบายเสนอกระทรวง

นพ.ศักดิ์ชัย วงศ์กิตติรักษ์ : ภายหลังจากได้ข้อมูลจากการสำรวจความต้องการของเขตสุขภาพว่าปัจจุบันมีพยาบาลเท่าไร ต้องผลิตเท่าไรจากนั้นค่อยมาเกลี่ยลงในแต่ละสถาบันผลิตเพื่อปิด gab NP ตา และในส่วนของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทำโครงการ Eye nurse ให้ครอบคลุมเพิ่มความรู้ให้พยาบาลที่ปฏิบัติงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในการดูแลผู้ป่วยจักษุ

คุณบุษราคัม วิรูปุตร์ : กิจกรรมงานพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา มีงานค่อนข้างเยอะ ทีมพยาบาลเวชปฏิบัติทางตาได้พูดคุยกันเรื่องทำ FTE และสมรรถนะในแต่ละระดับ เสนอให้กองการพยาบาลเป็นตัวกลางในการเรียกประชุมทีมเพื่อจัดทำ FTE และสมรรถนะในแต่ละระดับ

นพ.อนุชิต ปุณฺณทลิ่งค์: -การทำภาระงานควรมีการรวมกลุ่มกันทำ จะสามารถเขียนภาระงานได้ดี

-ค่าใช้จ่ายในการเรียนแต่ละหลักสูตรขอให้คำนวณค่าอื่นๆที่นอกเหนือจากค่าลงทะเบียน เช่น เบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ต่อคน ควรใช้จำนวนเท่าไร เพื่อเสนอของบ
คุณบุบผา สุวรรณฉัตรกุล : การจัดหลักสูตร 10 วันให้กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไม่น่ากังวล ขอให้มีงบประมาณ ซึ่งค่าใช้จ่ายต่อเขตประมาณ 500,000 บาท 12 เขต ประมาณ 6,000,000 บาท

นพ.อนุชิต ปุณฺณทลิ่งค์: .มอบทีมเลขาจัดทำหนังสือขอข้อมูลความต้องการจัดทำแผนกำลังคนด้านพยาบาลเพื่อเสนอกระทรวงสาธารณสุข จาก 12 เขตสุขภาพโดยทำแบบฟอร์มขอทั้ง 2 รูปแบบ คือ แบบ population base และ แบบ patient base โดยขอข้อมูลพยาบาล และ นักเทคนิคเจ้าหน้าที่ชำนาญการด้านเครื่องตรวจพิเศษทางตา

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมจักษุยั่งยืน ครั้งที่ 3/2561 (23 เมษายน 2561)

-รับรอง-

วาระที่ 3 แจ้งเพื่อทราบ

3.1 แจ้งความคืบหน้าจักษุยั่งยืน ทีมสถาบันและประธานเขตเข้าร่วมวางแผนการทำงานส่งต่อผู้ป่วยตามตัวชี้วัด กระทรวง

- การสมัครแพทย์ประจำบ้าน มีแพทย์ย้ายที่สมัครให้ตรงตามคู่ความร่วมมือ
- ถ้าแพทย์ไม่ได้รับการคัดเลือก จะต้องทำอย่างไร

3.2 การวิจัย ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ ระหว่างพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา จักษุแพทย์ ศูนย์จอตา ศูนย์ต้อหิน และสถาบันการศึกษาคู่ความร่วมมือ

3.3 การทำงานร่วมกันระหว่างองค์กรวิชาชีพ/สมาคม/ชมรม

3.4 การจัดตั้งสถาบันสมทบ

ที่ประชุม : รับทราบ

ปิดประชุม เวลา 15.00 น.

ณิชนน ชุมสิงห์ ผู้จัดรายงานการประชุม



รายงานการประชุมการพัฒนาาระบบบัญชีแบบยั่งยืน ครั้งที่ 1/2562

วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2562 เวลา 13.00-16.30 น.

ณ ห้องประชุมอุทัย สุดสุข ชั้น 5 อาคาร 7 กองบริหารการสาธารณสุข

ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข

ผู้มาประชุม

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. นพ.อนุชิต ปุณณทลัณค์ | ประธานราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย |
| 2. นพ.ยุทธพงษ์ อิ่มสุวรรณ | เลขาธิการราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย |
| 3. นพ.ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์ | ประธานวิชาการราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย |
| 4. พญ.อัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล | ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการ สาขาตา |
| 5. นพ.อนิรุทธิ์ สุวัตรจริยากุล | กรรมการพัฒนาระบบบริการ สาขาตา |
| 6. นพ.ไชยสิทธิ์ เทพชาตรี | กรรมการพัฒนาระบบบริการ สาขาตา |
| 7. นพ.อนุกุล ไทยถนอม | กรรมการพัฒนาระบบบริการ สาขาตา |
| 8. นพ.วรภัทร วงษ์สวัสดิ์ | กรรมการพัฒนาระบบบริการ สาขาตา |
| 9. นพ.ชวศักดิ์ กนกกันตพงษ์ | ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท |
| 10. พญ.สุมิตรา ตระการศิลป์ | ผู้แทนประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการ สาขาตา เขตสุขภาพที่ 1 |
| 11. พญ.มรกต มั่งวิฑิตกุล | ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการ สาขาตา เขตสุขภาพที่ 3 |
| 12. นพ.สมพงษ์ ภาสอจ | ผู้แทนประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการ สาขาตา เขตสุขภาพที่ 4 |
| 13. นพ.ศุภชัย ศุภพฤกษ์สกุล | ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการ สาขาตา เขตสุขภาพที่ 5 |
| 14. นพ.ไพศาล สหพัฒนา | ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการ สาขาตา เขตสุขภาพที่ 6 |
| 15. นพ.นพดล แข็งแรง | ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการ สาขาตา เขตสุขภาพที่ 7 |
| 16. นพ.สุวัฒน์ คุสกุล | ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการ สาขาตา เขตสุขภาพที่ 8 |
| 17. นพ.ประวิณ ดันตประภา | ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการ สาขาตา เขตสุขภาพที่ 9 |
| 18. นพ.โสภณ นิลกำแหง | ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการ สาขาตา เขตสุขภาพที่ 10 |
| 19. นพ.ดามพ์ มุกมณี | รองประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการ สาขาตา เขตสุขภาพที่ 11 |
| 20. นพ.พรประสิทธิ์ จันทระ | ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการ สาขาตา เขตสุขภาพที่ 12 |
| 21. พญ.วิลาวัลย์ พวงศรีเจริญ | หัวหน้าภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
| 22. นพ.ชัยรัตน์ เสาวฤทธิ์ | หัวหน้ากลุ่มงานจักษุวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี |
| 23. นพ.แมนสิงห์ รัตนสุคนธ์ | หัวหน้าภาควิชาจักษุวิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ |
| 24. นพ.พัฒน์ ธีญญิตติกุล | ผู้แทนหัวหน้าภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล |

/25. พญ.กิตติยา...

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 25. พญ.กิตติยา มหามงคล | หัวหน้ากลุ่มงานจักษุ โรงพยาบาลนครปฐม เขตสุขภาพที่ 5 |
| 26. นพ.ธีระเทพ ตันตยาคม | ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย |
| 27. นพ.พิชา ธัญพิมล | ผู้ช่วยเลขาธิการวิชาการราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย |
| 28. ศ.เกียรติคุณ ดร. วิจิตร ศรีสุพรรณ | ประธานคณะกรรมการพัฒนาพยาบาลจักษุอย่างยั่งยืน
กรรมการสภาการพยาบาล |
| 29. นางรัตนาพันธ์ ไพบูลย์ | นายกสมาคมพยาบาลเวชปฏิบัติทางตาแห่งประเทศไทย |
| 30. นางบุผา สุวรรณฉัตรกุล | คณะกรรมการพัฒนาพยาบาลจักษุอย่างยั่งยืน
โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง) |
| 31. ดร.ละมิตร์ ปีกขาว | ฝ่ายวิชาการสมาคมพยาบาลเวชปฏิบัติทางตาแห่งประเทศไทย |
| 32. นางศศิญา กุลวรพงศ์พัฒน์ | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เขตสุขภาพที่ 1 |
| 33. นางศิริลิน ศิริโรจนันต์ | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เขตสุขภาพที่ 1 |
| 34. นางรวีวรรณ ชื้อสตัยงกุล | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เขตสุขภาพที่ 7 |
| 35. นางนิธยร์ดี วีระปริษานนท์ | กลุ่มงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) |
| 36. นางสาวพวงลักษณ์ กลิ่นกุหลาบ | กลุ่มงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) |

เริ่มประชุม เวลา 13.00 น.

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ไม่มี

วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ไม่มี

วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 ความร่วมมือระหว่างราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยกับกระทรวงสาธารณสุข

ประธาน รท. : ได้สรุปการดำเนินงานตาม MOU ระหว่างราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ กับกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้

- ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยได้ทำบันทึกความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขเรื่องการผลิตและพัฒนาบุคลากรทางจักษุและพัฒนาเพิ่มจำนวนสถาบันสมทบเพื่อร่วมผลิตจักษุแพทย์ และได้ปฏิบัติตามขั้นตอน คือ ได้วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานและความขาดแคลนทรัพยากรบุคคลทางจักษุวิทยา วางแผนกับสถาบันที่เกี่ยวข้องในการผลิตจักษุแพทย์ วางยุทธศาสตร์กำหนดตำแหน่งจักษุแพทย์ในแต่ละเขตสุขภาพ และยุทธศาสตร์การกำหนดตำแหน่งวิชาชีพเพื่อสนับสนุนจักษุแพทย์ เพื่อให้จักษุแพทย์คงอยู่ในระบบได้อย่างถาวร โดยเริ่มดำเนินการปี 2561 เป็นปีแรก

- จากการวางแผนยังขาดจักษุแพทย์อยู่ 100 กว่าท่าน และขาดพยาบาลเวชปฏิบัติทางตาก็จำนวนมาก กระทรวงสาธารณสุขจึงได้จัดสรรทุนจักษุแพทย์ปี 2562 ให้จำนวน 50 ทุน และจะดำเนินการตามแผนที่ได้ทำข้อตกลงความร่วมมือเป็นระยะเวลา 2-3 ปี เพื่อผลิตจักษุแพทย์ให้เพียงพอ

/ผลการดำเนินงาน...

- ผลการดำเนินงานตามข้อตกลงความร่วมมือในการรับทุนแพทย์ประจำบ้านสาขาจักษุวิทยาปี 2562 จาก เขตสุขภาพ พบว่า จักษุแพทย์ที่มีต้นสังกัดจากกระทรวงสาธารณสุขได้รับทุนไม่เป็นไปตามแผนที่คาดการณ์ไว้ โดย จักษุแพทย์ที่ได้รับทุนเป็นจักษุแพทย์ที่มีต้นสังกัดเพิ่มขึ้นจริง แต่รับต้นสังกัดจากกระทรวงสาธารณสุข 12 เขตสุขภาพ ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จากการจัดสรร 50 ทุน มีผู้สมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาจักษุวิทยาจากต้นสังกัด กระทรวงสาธารณสุขทั้ง 12 เขตสุขภาพได้รับทุนปี 2562 จำนวน 41 ทุน

มติที่ประชุม : รับทราบ

วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

4.1 แพทย์ประจำบ้าน

ที่ประชุมร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ประเด็นปัญหา/อุปสรรคจากการดำเนินงานตาม MOU ของสถาบัน ฝึกอบรม, เขตสุขภาพ และเสนอแนวทางแก้ไขดังนี้

ปัญหาอุปสรรค

1. รอบแรกไม่มีจักษุแพทย์จากเขตสุขภาพไปสมัครกับสถาบันคู่ความร่วมมือ สถาบันฝึกอบรมเกรงว่าจะไม่มีจักษุแพทย์มาเรียนจึงรับผู้สมัครจากต้นสังกัดอื่นหรือผู้สมัครอิสระไว้ก่อน

2. สถาบันฝึกอบรมรับทุนจักษุแพทย์ข้ามเขตตั้งแต่รอบแรก

3. สาเหตุหนึ่งที่จักษุแพทย์ไม่สมัครกับคู่ความร่วมมือเนื่องจากไม่ใช่สถาบันเก่าที่จบมา

4. ผู้สมัครรับทุนจากเขตสุขภาพไปสมัครกับสถาบันฝึกอบรมตามคู่ความร่วมมือแต่ไม่ได้รับการคัดเลือก

ข้อเสนอ แนวทางแก้ไขปัญหา

1. สถาบันฝึกอบรมควรพิจารณาผู้สมัครจากเขตสุขภาพที่ตรงคู่ความร่วมมือก่อน

2. สถาบันฝึกอบรมในพื้นที่ที่เป็นคู่ความร่วมมือควรคำนึงถึงการผลิตจักษุแพทย์เพื่อกลับไปปฏิบัติงานในพื้นที่

3. เขตสุขภาพและต้นสังกัดควรคัดเลือกผู้สมัครตามความเหมาะสม และผู้สมัครต้องเตรียมตัวเองให้มีความพร้อม

4. ให้มีการคัดเลือกผู้สมัครตั้งแต่ระดับต้นสังกัดและเขตสุขภาพก่อนที่จะสมัครกับสถาบันฝึกอบรมคู่ความร่วมมือ เพื่อให้มีการคัดเลือกผู้สมัครสองครั้ง

5. ให้เกิดความเป็นเอกภาพของผู้พิจารณาผู้สมัครตั้งแต่ระดับเขตสุขภาพจนถึงสถาบันฝึกอบรมคู่ความร่วมมือ/โรงเรียนแพทย์

6. ให้มีผู้แทนสถาบันฝึกอบรมคู่ความร่วมมือลงมาร่วมคัดเลือกผู้สมัครกับเขตสุขภาพ

7. ให้สถาบันฝึกอบรมคู่ความร่วมมือสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานจากต้นสังกัดของผู้สมัครมากกว่า 1 คน เพื่อให้ได้ข้อมูลข้อคิดเห็นที่แตกต่างกัน

8. เพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้ทุกสถาบันฝึกอบรมคู่ความร่วมมือมีความเข้าใจหลักการตามบันทึกความร่วมมือระหว่างราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยกับกระทรวงสาธารณสุขมากยิ่งขึ้น

9. ให้มีข้อสอบกลางภาษาอังกฤษ

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ

ประธาน Service Plan สาขาตา :

1. ชื่นชม MOU ความร่วมมือการคัดเลือกทุนแพทย์ประจำบ้านสาขาจักษุวิทยาของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยกับกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งปี 2562 มีแพทย์ประจำบ้านจากเขตสุขภาพได้รับทุนจากสถาบันฝึกอบรมตามความร่วมมือร้อยละ 80 และเห็นควรขยายผลการดำเนินงานไปยังแพทย์ประจำบ้านสาขาอื่น
2. เห็นชอบจำนวนทุนที่รับฝึกอบรมโดยประมาณการ 50 ทุน และคงเดิมข้อตกลงคู่ความร่วมมือโรงเรียนแพทย์กับเขตสุขภาพ
3. ขอให้ประธาน Service Plan สาขาจักษุทุกเขตสุขภาพพิจารณาผู้สมัครโดยใช้เกณฑ์คุณสมบัติผู้สมัครแพทย์ประจำบ้านจักษุวิทยาตามที่ได้มีการตกลงกันไว้ในที่ประชุมและประชาสัมพันธ์ให้ผู้สมัครรับทราบ
4. โควตาเขตสุขภาพที่ไม่ระบุจังหวัด จะไม่ให้เป็นภาพเขต ต่อไปจะระบุเป็นจังหวัด ยกเว้นทุนแพทย์ประจำบ้านบางสาขาเช่น ศัลยแพทย์ ศัลยแพทย์ประสาทวิทยา ที่พิจารณาให้เป็นภาพเขตสุขภาพ
5. เห็นชอบให้สถาบันฝึกอบรมลงไปร่วมคัดเลือกทุนแพทย์ประจำบ้านกับเขตสุขภาพ, รพ.ต้นสังกัดผู้สมัคร

ผอ.สบพ. :

1. ชื่นชม MOU ต้นแบบความร่วมมือการคัดเลือกทุนแพทย์ประจำบ้านสาขาจักษุวิทยาของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยกับกระทรวงสาธารณสุข
2. ทุนปี 2563 สามารถใช้ตัวเลขประมาณการ 50 ทุน ได้เลย และขอให้ทุกเขตสุขภาพสำรวจความต้องการทุนแพทย์ประจำบ้านสาขาจักษุวิทยา
3. ขอให้ส่งแผนการจัดสรรทุนระหว่างคู่ความร่วมมือระหว่างสถาบันฝึกอบรมกับเขตสุขภาพ ปี 2563 ให้แล้วเสร็จและส่งข้อมูลกลับ สบพ. ภายในเดือนพฤษภาคม 2562 เพื่อส่งตัวเลขกลับไปให้เขตสุขภาพต่อไป ซึ่งปี 2562 สบพ. มีการปรับเปลี่ยนข้อมูลเล็กน้อยและจัดสรรอาจจะไม่ตรงกับโรงพยาบาลที่แจ้งขอทุนไว้ เนื่องจากติดปัญหาเรื่องกรอบอัตรากำลังบุคลากร ทั้งนี้การตัดสินใจทุนทุกตำแหน่งในเขตสุขภาพอยู่ที่คณะกรรมการ CHRO
4. ขอให้ทุกเขตสุขภาพจัดลำดับความต้องการทุนจักษุแพทย์
5. กระทรวงสาธารณสุขจะให้ทุนเฉพาะข้าราชการที่อยู่ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และมีเงื่อนไขคุณสมบัติระยะเวลาที่ปฏิบัติงานก่อนพิจารณาให้ทุน

มติที่ประชุม :

1. เห็นชอบร่วมกันในหลักการจัดสรรทุนให้ตรงความต้องการให้คงไว้ซึ่งหลักการเดิม
2. ขอให้ทุกเขตสุขภาพสำรวจความต้องการทุนแพทย์ประจำบ้านสาขาจักษุวิทยาและสำรวจข้อมูลผู้สมัครตามคู่ความร่วมมือแต่ยังไม่ได้รับการคัดเลือกและส่งข้อมูลกลับราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนประกอบการประชุมครั้งถัดไป

4.2 แนวทางการบริหารของพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา

4.2.1 การจัดทำหลักสูตรต้นแบบทางจักษุระดับต่าง ๆ

ประธาน รจท. : มอบหมายเลขาธิการ รจท. นำเสนอข้อมูล

/เลขาธิการ...

เลขาธิการ รพท. : จากการประชุมร่วมกันของสภาการพยาบาล สถาบันผลิตพยาบาลจักษุ ชมรมต่าง ๆ ได้ข้อสรุปหลักสูตรการพยาบาลจักษุ 3 รูปแบบดังนี้

	1. การพยาบาลจักษุเบื้องต้น (หลักสูตรระยะสั้น 5 วัน สำหรับ รพ.สต.)	2. การพยาบาลจักษุชุมชน (Eye nurse) (หลักสูตรระยะสั้น 15 วัน สำหรับ รพช.)	3. การพยาบาลเฉพาะทาง (สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา*)
วัตถุประสงค์	เพื่อให้พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตาบอด มีความรู้ และทักษะในการคัดกรองและการพยาบาลเบื้องต้นโรคตา	เพื่อให้พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน มีความรู้ และทักษะในการจัดการเบื้องต้น โรคตาที่พบบ่อย	เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความสามารถในการประเมินปัญหาและภาวะสุขภาพทางตา คัดกรองโรคตาและปัญหาสายตา ให้การช่วยเหลือกรณีฉุกเฉินและวิกฤต และให้การรักษายาโรคตาเบื้องต้น การทำหัตถการที่กำหนด การตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องมือพิเศษ การตัดสินใจส่งต่อ และการฟื้นฟูสมรรถภาพการเห็น โดยให้การพยาบาลอย่างเป็นองค์รวม ผสมผสาน ทั้งในชุมชน และสถานบริการทั้งระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ
วัตถุประสงค์เฉพาะ	เพื่อให้พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สามารถ 1) สามารถประเมิน คัดกรอง ความผิดปกติเบื้องต้นทางจักษุได้ 2) สามารถให้การพยาบาลเบื้องต้นผู้ป่วยที่ได้รับอุบัติเหตุและฉุกเฉินทางจักษุได้ 3) สามารถส่งต่อผู้ป่วยได้อย่างปลอดภัยเพื่อรับการรักษาต่อเนื่องได้	เพื่อให้พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน 1) สามารถประเมิน คัดกรอง ความผิดปกติทางจักษุ และวินิจฉัยเบื้องต้นได้ 2) สามารถประเมิน คัดกรอง ความผิดปกติจากภาวะแทรกซ้อนเบาหวานขึ้นจอตาได้ 3) สามารถให้การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับอุบัติเหตุและฉุกเฉินทางจักษุได้ 4) สามารถส่งต่อผู้ป่วยได้อย่างปลอดภัยเพื่อรับการรักษาต่อเนื่อง 5) สามารถบริหารจัดการโครงการส่งเสริมสุขภาพตาในชุมชน 6) ประสานความร่วมมือกับเครือข่ายเพื่อการรักษา ส่งต่อ การส่งเสริมสุขภาพ และการจัดการสุขภาพชุมชนด้านจักษุ	เพื่อให้ผู้ผ่านการอบรมมีความรู้ และสามารถปฏิบัติบทบาทของพยาบาลเวชปฏิบัติทางตาได้ดังนี้ 1) อธิบายนโยบาย แผนพัฒนาด้านสาธารณสุข ยุทธศาสตร์แห่งชาติด้านสุขภาพทางตา กฎหมายและจริยธรรม แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 2) อธิบายบทบาทพยาบาลในการให้บริการสุขภาพทางตา ระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ 3) ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน รักษา และการฟื้นฟูสุขภาพทางตาได้ 4) ให้การรักษาโรคตาเบื้องต้น การทำหัตถการ การบริหารยา ตามที่สภาการพยาบาลกำหนดได้ 5) ให้การจัดการกรณีฉุกเฉินทางตา และตัดสินใจส่งต่อผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม 6) ให้การดูแลผู้ป่วยโรคตาที่มีปัญหาสุขภาพตาซับซ้อนและรุนแรงได้ต่อเนื่อง 7) ให้ความรู้ คำแนะนำ และให้คำปรึกษาแก่ทีมสุขภาพ ผู้ใช้บริการ ครอบครัว และชุมชนได้ 8) ใช้ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ การจัดการข้อมูลทางคลินิกเพื่อพัฒนาคุณภาพการพยาบาลทางจักษุ และงานวิจัย *ให้ทุกสถาบันผลิต ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้มีรูปแบบทิศทางเดียวกันเพื่อให้ตรงตามคุณสมบัติของพยาบาลวิชาชีพทางตา ที่สภาวิชาชีพการพยาบาลกำหนด

	1. การพยาบาลจักษุเบื้องต้น (หลักสูตรระยะสั้น 5 วัน สำหรับ รพ.สต.)	2. การพยาบาลจักษุชุมชน (Eye nurse) (หลักสูตรระยะสั้น 15 วัน สำหรับ รพช.)	3. การพยาบาลเฉพาะทาง (สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา)
วิเคราะห์ข้อมูลความต้องการ		- ประชากร 12 เขตสุขภาพรวม 66,188,503 คน - โรงพยาบาลชุมชนทั้งหมด 767 แห่ง - พยาบาล Eye nurse ที่ต้องมี 767 คน - พยาบาล Eye nurse ที่มีอยู่เดิม 98 คน - ต้องการพยาบาล Eye nurse ทั้งหมด 717 คน	- ประชากร 12 เขตสุขภาพรวม 66,188,503 คน - พยาบาลเวชฯ ที่ต้องมี 2,206 คน - พยาบาลเวชฯ ที่มีอยู่เดิม 921 คน - ต้องการพยาบาลเวชฯ ทั้งหมด 1,147 คน - ขึ้นทะเบียนแล้ว 130 คน - มี 6 สถาบันผลิต ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, วิทยาลัยพยาบาลนครราชสีมา, รพ.รามาธิบดีร่วมกับ รพ.เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง), รพ.เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) ร่วมกับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ - สภาการพยาบาลกำลังพัฒนาหลักสูตรกลาง เพื่อเป็นต้นแบบให้สถาบันผลิตนำไปดำเนินการ

ความคิดเห็นที่ประชุม :

	1. การพยาบาลจักษุเบื้องต้น (หลักสูตรระยะสั้น 5 วัน สำหรับ รพ.สต.)	2. การพยาบาลจักษุชุมชน (Eye nurse) (หลักสูตรระยะสั้น 15 วัน สำหรับ รพช.)	3. การพยาบาลเฉพาะทาง (สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา)
ประธานวิชาการ รจท.	- ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยเห็นว่าหลักสูตร พยาบาลจักษุ 5 วัน หรือ 15 วัน เป็นหลักสูตรเร่งรัด ช่วยเหลือพื้นที่ได้ กำลังประสานสถาบันฝึกอบรม/คณะ แพทย์ต่าง ๆ ตามภูมิภาคในพื้นที่เป็นแหล่งฝึกอบรม	- เสนอให้กระทรวงสาธารณสุขวางแผนการส่งพยาบาล ชุมชนศึกษาต่อหลักสูตรการพยาบาลจักษุชุมชน (Eye nurse) (หลักสูตรระยะสั้น 15 วัน สำหรับ รพช.) เน้น ด้านการคัดกรองสุขภาพตาและนโยบายจักษุ	- สถาบันเปิดสอนหลักสูตรพยาบาลเวชตา แต่มีผู้มาสมัครเรียนไม่เต็ม หลักสูตร เนื่องจากพื้นที่ไม่สามารถส่งพยาบาลมาเรียนพร้อมกันได้
คณะทำงานพัฒนา พยาบาลจักษุอย่าง ยั่งยืน		- มี Model พัฒนาที่เขตสุขภาพที่ 5 ดำเนินการมา 3 ปี แล้ว เดือนกรกฎาคม 2562 จะนำไปขยายผลที่เขต สุขภาพที่ 9 ในปี 2562 (ใช้งบประมาณจาก รพ.เมตตา ประชารักษ์)	- พยาบาลต้องการมาเรียน แต่ไม่มีทุน - รพ.ศิริราชเปิดหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทางจักษุ เพื่อให้เหมาะสมกับ พยาบาลที่ปฏิบัติงานใน รพ. ระดับ Tertiary care และสามารถ นำมาใช้งานได้จริง - หลักสูตรพยาบาลเวชปฏิบัติทางตาสามารถไปปฏิบัติงานแทนผู้ที่ เกษียณอายุราชการหรือผู้ที่ได้เลื่อนตำแหน่งเป็นหัวหน้างาน
ประธาน Service Plan สาขาตา	- รพ.สต. ขนาดเล็กไม่มีกรอบพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติงาน ดังนั้นให้กำหนดเป้าหมายที่ รพ.สต.ขนาดกลาง-ขนาดใหญ่ โดยจัดอบรมในจังหวัด 5 วัน ตามความเหมาะสมกับบริบท ของพื้นที่	- ให้เขตสุขภาพเป็นผู้จัดและบริหารจัดการงบประมาณ ต้องจัดทำต้นทุนต่อหลักสูตรเสนอผู้บริหารตัดสินใจ	- สำนักงบประมาณสนับสนุนพัฒนาบุคลากร หมวดยอดเงินอุดหนุน ให้กระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพละ 4 ล้านบาท เขตสุขภาพ สามารถทำแผนส่งพยาบาลเรียน เสนอผ่านผู้ตรวจราชการ ซึ่ง ครอบคลุมค่าลงทะเบียน ค่าที่พัก และค่าเดินทาง
	สรุป 1. สามารถวางแผนฝึกอบรมได้ทั้ง 3 หลักสูตร แต่ขอให้จัดตามบริบทของพื้นที่และงบประมาณ และหากสามารถทำแผนต้นทุนต่อหลักสูตรเสนอผู้บริหารตัดสินใจ จะได้อนุมัติได้ตั้งแต่ต้นปี 2563 2. รับประสานกับอธิบดีกรมการแพทย์เรื่องของงบประมาณสนับสนุนหลักสูตรการพยาบาลจักษุชุมชน (Eye nurse) ทั้ง 10 เขตสุขภาพ (ยกเว้นเขตสุขภาพที่ 5, 9) แผนระยะ 3 ปี		
เขตสุขภาพ	- เสนอให้มีหลักสูตรกลาง เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้ง ประเทศ เนื่องจาก รพ.สต.บางแห่งไม่มีพยาบาลแตมี นักวิชาการสาธารณสุข ให้จังหวัดหรือส่วนท้องถิ่นเป็น ผู้บริหารจัดการจัดหลักสูตรฝึกอบรมกระบวนการคัดกรอง การวัด VA และการบันทึกข้อมูลในโปรแกรม vision2020	- เสนอให้จัดตามภูมิภาค ตามโรงเรียนแพทย์และเน้น การฝึกปฏิบัติ - ใช้งบประมาณฝึกอบรม 350,000 บาทต่อเขตสุขภาพ ได้ประมาณ 60 คน (สนับสนุนค่าอาหาร,ค่าเดินทาง, ค่าที่พัก และค่าเดินทางวิทยากร ส่วนค่าเบี้ยเลี้ยง, ค่าลงทะเบียนเบิกจากต้นสังกัดของผู้เข้าอบรม)	- งบประมาณ 4 ล้านบาท ที่จัดสรรให้แต่ละเขตสุขภาพนั้น ขอแจ้งว่า 1 ล้านบาท เขตสุขภาพได้จัดสรรให้ รพช. คงเหลือเพียง 3 ล้านบาท - เขตสุขภาพที่ 10 เสนอหลักการว่า รพ.ที่มีจักษุแพทย์พิจารณา พยาบาลเวชฯ ตามสัดส่วนของจักษุแพทย์ต่อพยาบาลเวชฯ และรพ.ที่ ไม่มีจักษุแพทย์พิจารณาตามจำนวนประชากรในพื้นที่รับผิดชอบ และ ทุก รพ.ควรจะมีพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้ดำเนินการดังนี้

หลักสูตรการพยาบาลต่อยอด

- ยังไม่ได้หารือข้อสรุปในการประชุมครั้งนี้

หลักสูตรพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา 4 เดือน

- ให้เขตสุขภาพใช้งบประมาณหมวดงบเงินอุดหนุนจากสถาบันบรมราชชนก วางแผนส่งพยาบาลศึกษาต่อหลักสูตรการพยาบาลจักษุชุมชน (Eye nurse) 15 วัน

- ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย, ประธาน Service Plan สาขาตา และคณะทำงานพัฒนาพยาบาลจักษุอย่างยั่งยืน ร่วมกันจัดทำแผนบริหารจัดการตามจำนวนความต้องการ 717 คน ศักยภาพการผลิต งบประมาณ และระยะเวลาการผลิตพยาบาลจักษุชุมชนให้เพียงพอ เพื่อนำไปเสนออธิบดีกรมการแพทย์

หลักสูตรการพยาบาลจักษุเบื้องต้น 5 วัน

- ให้จังหวัดดำเนินการจัดฝึกอบรมกลุ่มเป้าหมาย รพ.สต.ขนาดกลาง-ขนาดใหญ่ โดยใช้หลักสูตรกลางที่สภาการพยาบาลจัดทำขึ้น

4.3 การประสานความร่วมมืออาจารย์โรงเรียนแพทย์ในโครงการดวงตาสดใส เทิดไท้ 84 พรรษามหาราชา

ประธาน รจท. :

- ผลการดำเนินงานตามโครงการต่ำกว่าเป้าหมายที่วางไว้
- ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยจะทำหนังสือให้แต่ละสถาบันฝึกอบรม/โรงเรียนแพทย์สำรวจจำนวนผู้ที่มีต้องการเปลี่ยนกระจกตาตกค้างที่ยังมีชีวิตอยู่ เพื่อส่งข้อมูลให้กระทรวงสาธารณสุขต่อไป
- งบจากกองทุนสนับสนุนการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาในโรงเรียนแพทย์ขาดทุน

ประธาน Service Plan สาขาตา :

- โครงการดวงตาสดใส เทิดไท้ 84 พรรษามหาราชา เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2560 ได้กำหนดเป้าหมายผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา 5 ปี 8,400 ดวงตา จากข้อมูลตั้งแต่เริ่มโครงการมีผู้ต้องการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาตกค้างอยู่ 12,000 ดวงตา ซึ่งข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน ปี 2560-2561 ผ่าตัดได้ 2,400 ดวงตา
- มอบ นพ.อนุกุล ไทยถนอมฯ ขอข้อมูลผู้ที่ต้องการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาตกค้างที่ยังมีชีวิตอยู่จากสภาการแพทย์เพื่อนำมาตรวจสอบกับข้อมูลของศูนย์เทคโนโลยีฯ ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่เข้าคิวและยังไม่ได้รับการผ่าตัด

- มอบประธาน Service Plan สาขาตา สำรวจข้อมูลทั้ง 12 เขตสุขภาพด้วย

ประธาน รจท. : วาระต่อไปจะเชิญชมรมกระจกตา ศูนย์ดวงตาสภาการแพทย์ เข้าร่วมหารือเรื่องนี้

มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบ

วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

5.1 ร่าง Action Plan แนวทางกระทรวงสาธารณสุขและราชวิทยาลัยฯ ปี 2561-2562

ประธาน รทท. : ราชวิทยาลัยจักษุฯ และกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำบันทึกความร่วมมือ (MOU) เพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาตา โดยมียุทธศาสตร์การดำเนินงานที่สำคัญ 6 ประการ คือ

1. การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานและความขาดแคลนของทรัพยากรบุคคลทางจักษุวิทยา Database and Gap (Demand side) Analysis ร่วมกันทำการวิเคราะห์ความต้องการจักษุแพทย์และเจ้าหน้าที่ในสาขาที่เกี่ยวข้องของประเทศ เพื่อวางแผนการผลิตและปิดช่องว่างของความขาดแคลนบุคลากรด้านจักษุแพทย์ทุกปี บนฐานของ Service Base ของโรงพยาบาลในแต่ละระดับ โดยวิเคราะห์ภาระงานร่วมกับจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาจริง นอกเหนือจากอัตราส่วนประชาชนในพื้นที่ต่อจักษุแพทย์

2. การวิเคราะห์และวางแผนว่าด้วยสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการผลิตจักษุแพทย์ Ophthalmology Resources (Supply side) analysis and Plan วางแผนในการจัดทำศักยภาพการผลิต โดยการสนับสนุนให้มีโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขช่วยเป็นสถาบันวิชาเลือก/ร่วมผลิตและสมทบ เพื่อให้จักษุแพทย์ได้มีโอกาสสร้างความผูกพันกับเขตสุขภาพของตน โดยถูกต้องตามเกณฑ์การฝึกอบรมของอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบของแพทยสภา และศักยภาพการผลิตวิชาชีพสนับสนุนอื่น ๆ เช่น พยาบาลเวชปฏิบัติทางตา

3. ยุทธศาสตร์การกำหนดตำแหน่งจักษุแพทย์ในพื้นที่เขตบริการสาธารณสุข Area Ophthalmology Support Strategy สนับสนุนโควตาการศึกษาของนักเรียนทุนกระทรวงสาธารณสุข ขอความร่วมมือทั้งสองฝ่าย คือ ขอความร่วมมือสถาบันให้พิจารณาผู้มีทุนเป็นพิเศษ และขอความร่วมมือกระทรวงสาธารณสุขในการพิจารณาให้ทุนในพื้นที่ที่จำเป็นและสนับสนุนผู้รับทุน ให้เป็นผู้ที่อยู่ในพื้นที่และมีคุณสมบัติสอดคล้องตามเกณฑ์ของสถาบัน และการบริหารจัดการการกระจายของจักษุแพทย์และจักษุแพทย์อนุสาขา

4. ยุทธศาสตร์การกำหนดตำแหน่งวิชาชีพสนับสนุนการบริการจักษุในพื้นที่เขตบริการสาธารณสุข Area Allied Health in Ophthalmology Support Strategy สนับสนุน นักทัศนมาตร พยาบาลเวชปฏิบัติทางตา เจ้าหน้าที่เทคนิคทางตา ไปในพื้นที่ห่างไกล กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับราชวิทยาลัยสนับสนุนให้รางวัลจักษุแพทย์ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ห่างไกลและสุ่มเสี่ยง

5. พัฒนานโยบายการบริการด้านจักษุ Policy Development in Ophthalmology Service ร่วมกันกำหนดนโยบายด้านการสาธารณสุขของประเทศให้ชัดเจนในด้านจักษุวิทยา เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ปรับบริบทของการทำงาน และวางแผนการดำเนินงานเพื่อรองรับนโยบายดังกล่าว

6. พัฒนายุทธศาสตร์การธำรงจักษุแพทย์ไว้ในระบบบริการ Ophthalmologist Retaining Strategy ทั้งราชวิทยาลัยและกระทรวงจัดทำเกณฑ์และกลไกให้บุคลากรทำงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่องได้ เช่น ราชวิทยาลัยให้จักษุแพทย์ทั่วไปต้องกลับไปทำงานเพื่อเข้าใจความต้องการของพื้นที่ก่อนเลือกเรียนอนุสาขา และกระทรวงมีกลไกสนับสนุนอื่น ๆ เช่น เครื่องมือที่เหมาะสม ทีมงานที่เหมาะสม เป็นต้น

/การดำเนินงาน...

- การดำเนินงานที่สำคัญในช่วง ปี 2561-2562 ได้แก่ วิเคราะห์ความต้องการจักษุแพทย์ กำหนดทุนจักษุแพทย์กระทรวงสาธารณสุขปีการศึกษา 2562, 2563 จำนวน 50 ทุน กำหนดสถาบันฝึกอบรมคู่ความร่วมมือ
 - วิเคราะห์ความต้องการพยาบาลเวชปฏิบัติทางตาและวางแผนผลิตเพื่อรองรับความต้องการของ 12 เขตสุขภาพ
 - จัดหลักสูตรสำหรับพยาบาลทางจักษุ ได้แก่ การพยาบาลจักษุเบื้องต้น สำหรับ รพ.สต., การพยาบาลจักษุชุมชน (Eye nurse) สำหรับ รพช. และการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนพยาบาลทางจักษุในเขตสุขภาพ
 - สถาบันหลักยังคงเพิ่มไม่ได้ มีสถาบันที่ต้องการเป็นสถาบันฝึกอบรมแต่ยังไม่ผ่านการประเมิน
- กระทรวงกลาโหม ได้แก่ รพ.ภูมิพล และ รพ.พระมงกุฎเกล้า
กระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ รพ.จันทบุรี และ รพ.ชลบุรี

มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบ

5.2 Excellence center

ประธานวิชาการ รจท. :

- การเปิดศูนย์ฝึกอบรม(Excellence center) ของกระทรวงสาธารณสุข คณะกรรมการอำนวยการราชวิทยาลัยฯ พิจารณาแล้วว่าต้องมี 5 หน่วยย่อยหลัก ได้แก่ Retina Glaucoma Cornea Oculoplastic และ Pediatric
- ถ้าแต่ละเขตสุขภาพมี Excellence center ในพื้นที่ จะช่วยเรื่องการ refer ออกได้

มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบ

ปิดประชุม เวลา 16.30 น.



(นางสาวพวงลักษณ์ กลั่นกุหลาบ)

ผู้จัดรายงานการประชุม



(นางนิตยร์ดี วีระปรีชานนท์)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม



(นพ.วรภัทร วงษ์สวัสดิ์)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม



(รศ.นพ.อนุชิต ปญญทลึงค์)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม



รายงานการประชุมการพัฒนาาระบบบัญชีแบบยั่งยืน ครั้งที่ 2/2562
วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 09.00-14.30 น.
ณ ห้องประชุมอุทัย สุดสุข ชั้น 5 อาคาร 7 กองบริหารการสาธารณสุข
ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข

ผู้มาประชุม

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. นพ.อนุชิต ปุณณทลัณค์ | ประธานราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย |
| 2. นพ.ยุทธพงษ์ อิมสุวรรณ | เลขาธิการราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย |
| 3. นพ.ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์ | ประธานวิชาการราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย |
| 4. พญ.วณิชา ชื่นกองแก้ว | ประธานคณะกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ |
| 5. นพ.อนิรุทธิ์ สุภวัตรจริยากุล | คณะทำงานบัญชียั่งยืน |
| 6. นพ.ไชยสิทธิ์ เทพชาตรี | คณะทำงานบัญชียั่งยืน |
| 7. นพ.ชวศักดิ์ กนกกันตพงษ์ | ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท |
| 8. พญ.จิตติมา อินทพิบูลย์ | ผู้แทนประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการ สาขาตา เขตสุขภาพที่ 2 |
| 9. พญ.มรกต มั่งวิฑิตกุล | ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการ สาขาตา เขตสุขภาพที่ 3 |
| 10. นพ.สมพงษ์ ภาสอจ | ผู้แทนประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการ สาขาตา เขตสุขภาพที่ 4 |
| 11. พญ.กิตติยา มหามงคล | ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการ สาขาตา เขตสุขภาพที่ 5 |
| 12. นพ.ไพศาล สหพัฒนา | ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการ สาขาตา เขตสุขภาพที่ 6 |
| 13. นพ.นพดล แข็งแรง | ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการ สาขาตา เขตสุขภาพที่ 7 |
| 14. นพ.สุวัฒน์ คูสกุล | ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการ สาขาตา เขตสุขภาพที่ 8 |
| 15. นพ.โสภณ นิลกำแหง | ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการ สาขาตา เขตสุขภาพที่ 10 |
| 16. พญ.บัวขวัญ ชื่นกุลกิจนิวัฒน์ | ผู้แทนประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการ สาขาตา เขตสุขภาพที่ 11 |
| 17. นพ.พรประสิทธิ์ จันทระ | ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการ สาขาตา เขตสุขภาพที่ 12 |
| 18. พญ.งามแข เรืองวรเวทย์ | หัวหน้าภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล |
| 19. พญ.อนิตา มนัสสาร | ผู้แทนหัวหน้าภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
| 20. นพ.ไพศาล ร่วมวิบูลย์สุข | ผู้แทนหัวหน้ากลุ่มงานจักษุวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี |
| 21. พญ.ดวงดาว ทศณรงค์ | หัวหน้ากลุ่มงานจักษุวิทยา โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) |
| 22. พญ.กรวิภา เหมะรัต | ผู้แทนหัวหน้าภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล |
| 23. นพ.ณัฐวุฒิ วนะคำ | ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล |
| 24. นางนิตยร์ดี วีระปรีชาพันธ์ | กลุ่มงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) |
| 25. นางสาววนิดา ศรีม่วง | เขตสุขภาพที่ 2 |

เริ่มประชุม เวลา 09.00 น.

วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

ประธานที่ประชุม (รศ.นพ. อนุชิต ปุณณทลิ่งค์) สรุปความคืบหน้าเรื่องทุนฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาจักษุวิทยา ปีการศึกษา 2562 และข้อมูลการประชุมครั้งที่ 1/2562 ดังนี้

1.1 ทุนฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาจักษุวิทยา ปีการศึกษา 2562

- จำนวนทุนที่กระทรวงสาธารณสุขจัดสรรทั้งหมด 50 ทุน
- จำนวนสมัครรับทุน 45 ทุน
- สถาบันรับฝึกอบรม 42 ทุน

1.2 ปัญหาที่สำคัญ

- สถาบันฝึกอบรมบางแห่งไม่มีคนไปสมัครรอบแรก จึงรับ Free Train ตั้งแต่แต่รอบแรก
 - สถาบันฝึกอบรมบางแห่ง สัญญารับสมัครฝึกอบรมที่จบจากสถาบันตัวเอง ทำให้ MOU มีปัญหา ผู้สมัครเข้าใจว่าไม่จำเป็นต้องเป็นคู่ความร่วมมือ
 - ปัญหาสถาบันฝึกอบรม 1) อยากช่วยรับฝึกอบรมให้กระทรวงสาธารณสุขแต่ขณะเดียวกันก็ต้องการ คนมาเป็นอาจารย์ (Staff) 2) สามารถรับผู้สมัครนอก MOU ได้หรือไม่
- ประธาน ชี้แจงและขอความร่วมมือสถาบันฝึกอบรม ดังนี้
- การรับผู้สมัครนอกเขต MOU : ไม่ใช่กฎข้อบังคับตายตัว แต่จะทำให้ระบบเกิดความวุ่นวาย ขอความร่วมมือสถาบันฝึกอบรมช่วยปิด Gap ให้กระทรวงฯ ก่อนคาดว่าจะใช้เวลา 2-3 ปีจะเข้าที่
 - หากรอบแรกทุนต้นสังกัดกระทรวงสาธารณสุขยังไม่ครบ ให้ชะลอก่อนอย่าเพิ่งรับ Free Train เพื่อให้ โอกาสผู้สมัครที่มีทุนจากกระทรวงสาธารณสุข และไม่ควรงด/ ชักชวนผู้สมัครจากจากกระทรวงสาธารณสุขมาเป็นอาจารย์ เพราะในภูมิภาคยังขาดจักษุแพทย์

1.3 ข้อเสนอที่ประชุม

- ให้มีการสลับคู่ความร่วมมือทุก 2 ปี เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการถ่ายทอดทักษะ ความรู้จากอาจารย์ที่หลากหลาย

1.4 การดำเนินงานอื่นๆ ตามแผนปฏิบัติการบันทึกความร่วมมือ (MOU) ระหว่างราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยกับกระทรวงสาธารณสุข

- ภาควิชาจักษุวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมกับราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยจัดอบรม วิชาการบริหารจัดการคลินิกแว่นตาอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งในการตอบสนองยุทธศาสตร์การดำรงจักษุแพทย์ไว้ในระบบบริการ (Ophthalmologist Retaining Strategy)

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2562

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2562

วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

ไม่มี

วาระที่ 4 เรื่องพิจารณา

4.1 การจัดสรรทุนแพทย์ประจำบ้านสาขาจักษุวิทยา ประจำปีการศึกษา 2563

ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (สพช.)

(นพ.ชวศักดิ์ กนกกัณทพงษ์) ชี้แจงการกำหนดโควตาแพทย์ประจำบ้านสาขาจักษุวิทยา ตามตาราง 1

ตารางที่ 1 การจัดสรรโควตาแพทย์ประจำบ้านสาขาจักษุวิทยา ปีการศึกษา 2563

เขต	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
โควตา	4	6	3	5	6	2	1	6	7	5	4	1
เขต	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gap max	9	12	7	11	13	4	(3)	12	13	11	9	2
เขต	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gap min	(11)	(1)	(3)	(10)	(13)	(20)	(13)	(6)	(1)	(5)	(10)	(17)

สูตรการคิดมาจาก

- กรอบ Service plan
- Gap max , Gap Minimum

ประเด็นปัญหา

- เขตสุขภาพที่ 7 มีจักษุแพทย์เกิน Gap max 3 คน แต่หากเปรียบเทียบจำนวนจักษุแพทย์กับเขตสุขภาพอื่นที่รับผิดชอบประชากรจำนวนใกล้เคียงกัน พบว่ามีจักษุแพทย์น้อยกว่าเขตสุขภาพอื่น ภาพรวมจำนวนจักษุแพทย์ในเขตอาจเกิน แต่เมื่อพิจารณาโรงพยาบาลจะขาด ประธานเขตสุขภาพที่ 7 มีข้อสงสัยวิธีคำนวณและขอให้ที่ประชุมทบทวนวิธีคำนวณ
- วิธีคำนวณใช้กรอบ กรอบ Service plan ที่กองบริหารการสาธารณสุขรวบรวมข้อมูลไว้ ตั้งแต่ปี 2555 และตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการ CHRO (Chief of Human Resource Officer) แต่ละเขตสุขภาพ สูตรการคิดใช้หลักการเดียวกันทุกสาขา ไม่สามารถเปลี่ยนสูตรวิธีคิดได้ เพราะจะกระทบต่อสาขาอื่น

ข้อเสนอที่ประชุมในการแก้ไขปัญหา

- เสนอเหตุผลความจำเป็นในการขอโควตา (แม้ว่าโควตาภาพรวมเขตจะเกิน แต่ในระดับโรงพยาบาลจะขาด ในบางโรงพยาบาล)
- ปรับกระบวนการขอโควตาในเขตเอง

สิ่งที่ต้องดำเนินการส่งให้ สปพช.

- การกำหนดทุนแพทย์ประจำบ้าน : ระบุทุนโรงพยาบาล / ทุนเขตสุขภาพ กำหนดสถาบันฝึกอบรมคู่ความร่วมมือกับเขตสุขภาพ

- แผนการจัดสรรทุน : หลังจากการประชุมจักษุยั่งยืนจัดทำโควตาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาจักษุวิทยา ส่ง สปพช. สปพช. จะนำไป Integrate กับแผนของของ CHRO เขตสุขภาพ อำนาจการจัดสรรโควตาอยู่ที่ CHRO เขตสุขภาพ เมื่อ CHRO รับรองแผนการจัดสรรโควตา สปพช.จะแจ้งจักษุยั่งยืนรับทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

4.2 การจัดสรรโควตาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาจักษุวิทยา ปีการศึกษา 2563 และสถาบันฝึกอบรมคู่ความร่วมมือกับเขตสุขภาพ

ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณา ปรับเปลี่ยนทุนให้สอดคล้องกับโควตาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาจักษุวิทยา ที่สปพช. จัดสรร และระบุแหล่งทุน สถาบันฝึกอบรมคู่ความร่วมมือ ตามตาราง 2

ซึ่งยังขาดข้อมูลเขตสุขภาพที่ 9

มติที่ประชุม เห็นชอบ และมอบนางนิตยร์ดี วีระปรีชานนท์ ติดตามข้อมูลจากเขตสุขภาพที่ 9 และจัดทำข้อมูลให้สมบูรณ์ส่งราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย

4.3 กระบวนการคัดเลือกผู้สมัคร

ที่ประชุมเสนอ

- ให้สถาบันฝึกอบรม ระบุคุณสมบัติผู้สมัคร แจ้งให้เขตสุขภาพทราบ
- ให้เขตสุขภาพเปิดกว้างให้สถาบันฝึกอบรมร่วมในกระบวนการคัดเลือกผู้สมัคร
- จัดให้มีการพิจารณากลั่นกรองผู้สมัครที่ส่วนกลาง จัดโดยราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย โดยผู้แทนเขตสุขภาพและผู้แทนสถาบันฝึกอบรม เพื่อให้ได้ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติ คุณภาพ ตรงตามความต้องการของสถาบันฝึกอบรมและเขตสุขภาพ แก้ปัญหาการฝากผู้สมัคร การสมัครข้าม MOU เพิ่มโอกาสได้รับการคัดเลือก และผู้สมัครที่ไม่ผ่านการคัดเลือกมีโอกาสไปสมัครสาขาอื่น

มติที่ประชุม เห็นชอบ

ปิดประชุม เวลา 15.00 น.

นัดประชุมกลั่นกรองผู้สมัครฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาจักษุวิทยา วันที่ 19 มิถุนายน 2562 ณ ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย

นางนิตยร์ดี วีระปรีชานนท์

สรุปรายงานการประชุม

รศ. นพ. อนุชิต ปุณณทลิ่งค์

ตรวจรายงานการประชุม



รายงานการประชุมจกษุยังยืน ครั้งที่ 1/2563
วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 – 12.00 น.
ณ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ผู้มาประชุม

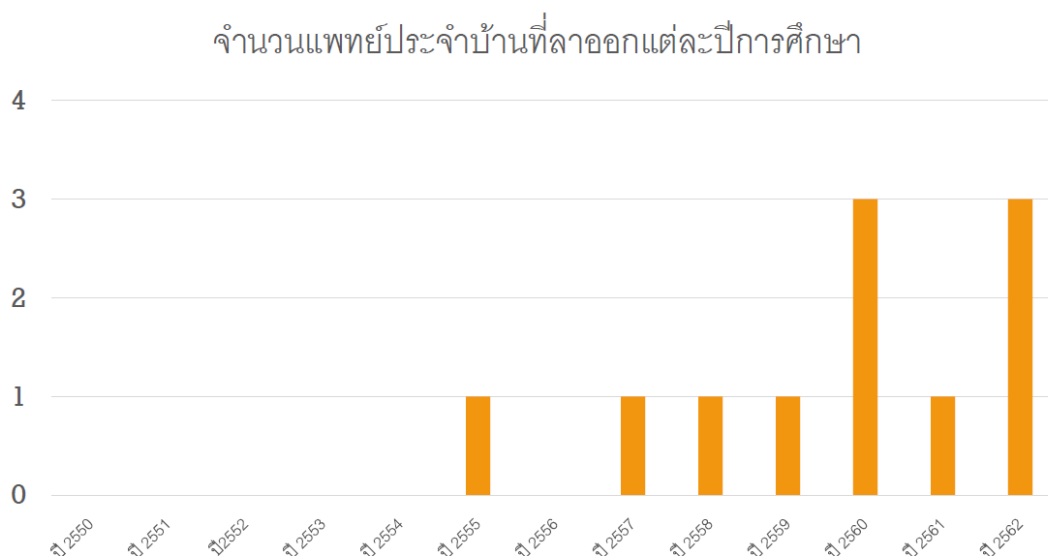
1	นพ.อนุชิต ปุณฺณทลิ่งค์	ประธานราชวิทยาลัย
2	นพ.ยุทธพงษ์ อิมสุวรรณ	เลขาธิการราชวิทยาลัย
3	นพ.ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์	ประธานวิชาการ
4	พญ.อัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล	ประธานคณะกรรมการเขตสุขภาพ สาขาตา
5	นพ.วสันต์ แก้ววี	เขตสุขภาพ ที่ 1
6	นพ.สมชาย แก้วเขียว	เขตสุขภาพ ที่ 2
7	พญ.มรกต มั่งวิฑิตกุล	เขตสุขภาพ ที่ 3
8	นพ.สมพงษ์ ภาสอาจ	เขตสุขภาพที่ 4
9	พญ.กิตติยา มหามงคล	เขตสุขภาพ ที่ 5
10	พญ.สุภาพรณ ฉัตรทินกร	เขตสุขภาพ ที่ 6
11	นพ.นพดล แข็งแรง	เขตสุขภาพที่ 7
12	นพ.สุวัฒน์ คูสกุล	เขตสุขภาพที่ 8
13	นพ.วิฑูรย์ เรืองสุขศรีวงศ์	เขตสุขภาพที่ 9
14	นพ.โสภณ นิลกำแหง	เขตสุขภาพที่ 10
15	นพ.ปณิธาน ส้อมโนธรรม	เขตสุขภาพที่ 11
16	พญ.อนิตา มนัสสากร	ภาควิชาจักษุวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
17	นพ.ไพศาล ร่วมวิบูลย์สุข	กลุ่มงานจักษุวิทยา รพ.ราชวิถี
18	นพ.นิพนธ์ เอื้ออารีย์	ภาควิชาจักษุวิทยา ม.สงขลานครินทร์
19	พญ.ดวงดาว ทศนรงค์	รพ.เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)
20	พญ.มัณิมา มะกรวัฒนะ	ภาควิชาจักษุวิทยา ม.ธรรมศาสตร์
21	นพ.ไชยสิทธิ์ เทพชาตรี	คณะทำงานจกษุยังยืน
22	นพ.ชวศักดิ์ กนกกันตพงษ์	ผู้อำนวยการ สปพช.
23	นพ.บุญส่ง วณิชเขารุ่งเรือง	รพ.ราชวิถี
24	นพ.วรภัทร วงษ์สวัสดิ์	รพ.เมตตาประชารักษ์
25	นางนิตยร์ดี วีระปรีชานนท์	กลุ่มยุทธศาสตร์ รพ.เมตตาประชารักษ์

เริ่มประชุมเวลา 09.15 น

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

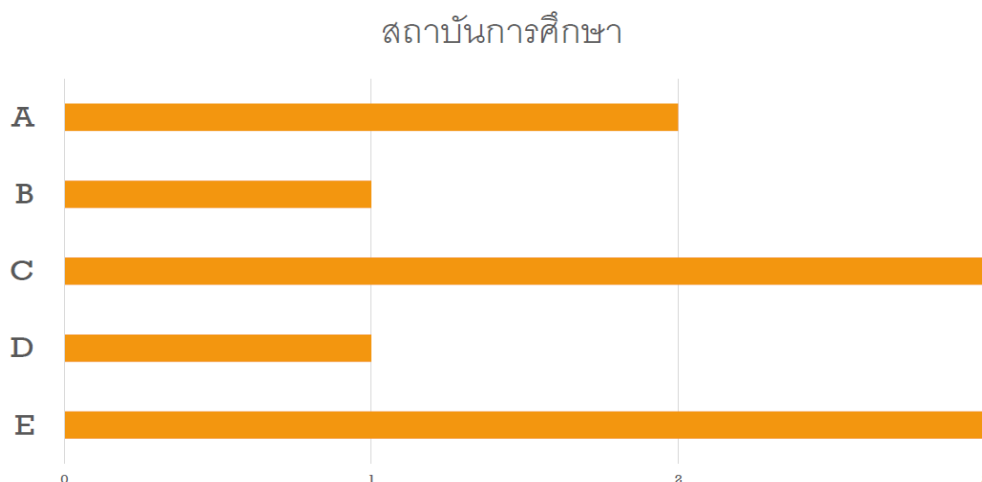
1.1 เรื่องสถานการณ์การลาออกของแพทย์ประจำบ้านสาขาจักษุวิทยา โดยนายแพทย์ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์ ประธานการประชุม (นายแพทย์อนุชิต ปุญญทลิ่งค์) เชิญ นายแพทย์ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์ นำเสนอผลการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการลาออกจากการเรียนแพทย์ประจำบ้านสาขาจักษุวิทยา รายละเอียดการศึกษา มีประเด็นต่างๆ ดังนี้

1) จำนวนแพทย์ประจำบ้านที่ลาออกแต่ละปี



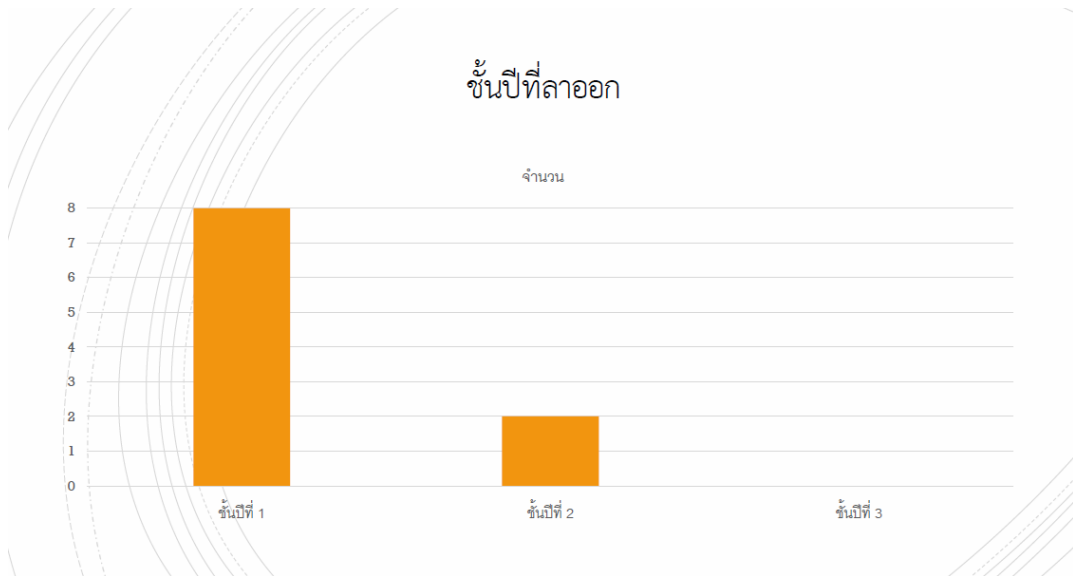
เก็บข้อมูลตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 พบว่า 6 ปีแรก (2550 – 2556) มีแพทย์ประจำบ้านลาออกเพียง 1 คน ปีการศึกษา 2557 ถึง 2562 มีแพทย์ประจำบ้าน ลาออกเพิ่มขึ้น 10 เท่า (10 คน) ความชุกในการลาออกเพิ่มขึ้นในช่วงปีหลังๆ ปีการศึกษา 2560, 2562 ลาออก 3 คน

2) สถาบันที่ลาออก



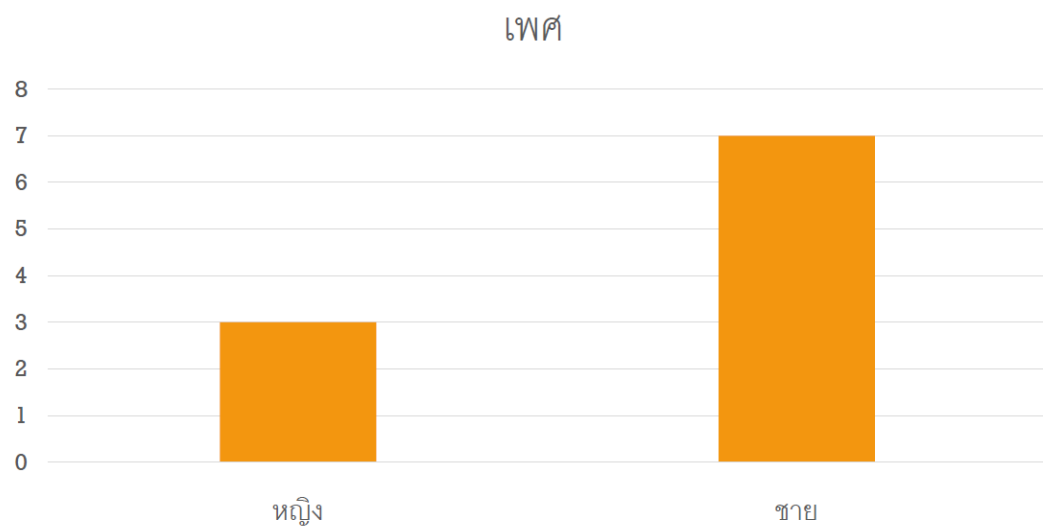
ปีการศึกษา 2557 – 2562 จำนวนแพทย์ประจำบ้านที่ลาออกทั้งหมด 10 คน มีสถาบันที่แพทย์ประจำบ้าน ลาออก 3 คน 2 สถาบัน ลาออก 2 คน 1สถาบัน ลาออก 1คน 2 สถาบัน (ขอสงวนนามสถาบัน)

3) ชั้นปีที่ลาออก



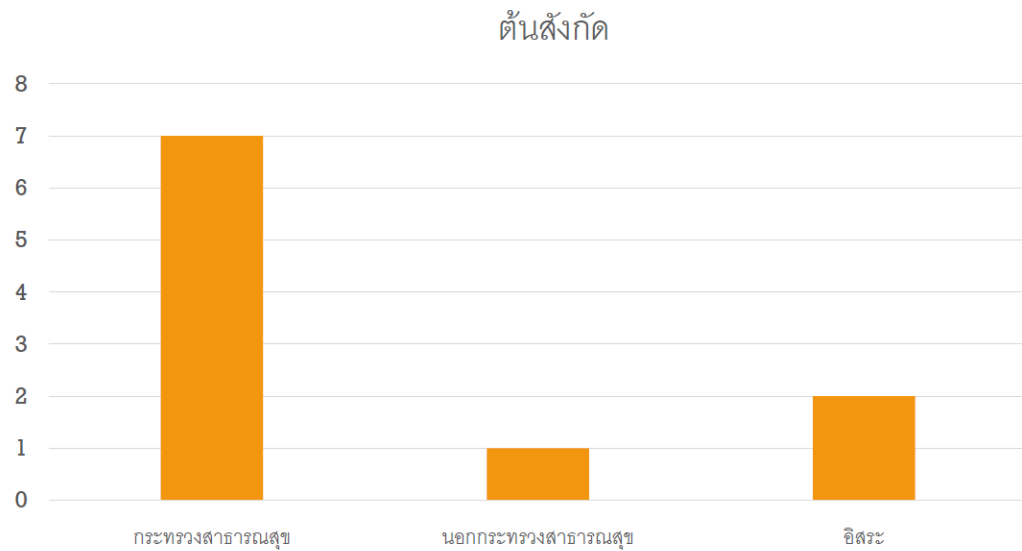
พบว่า ชั้นปีที่ 1 ลาออกจำนวน 8 คน ชั้นปีที่ 2 ลาออก จำนวน 2 คน

4) เพศ



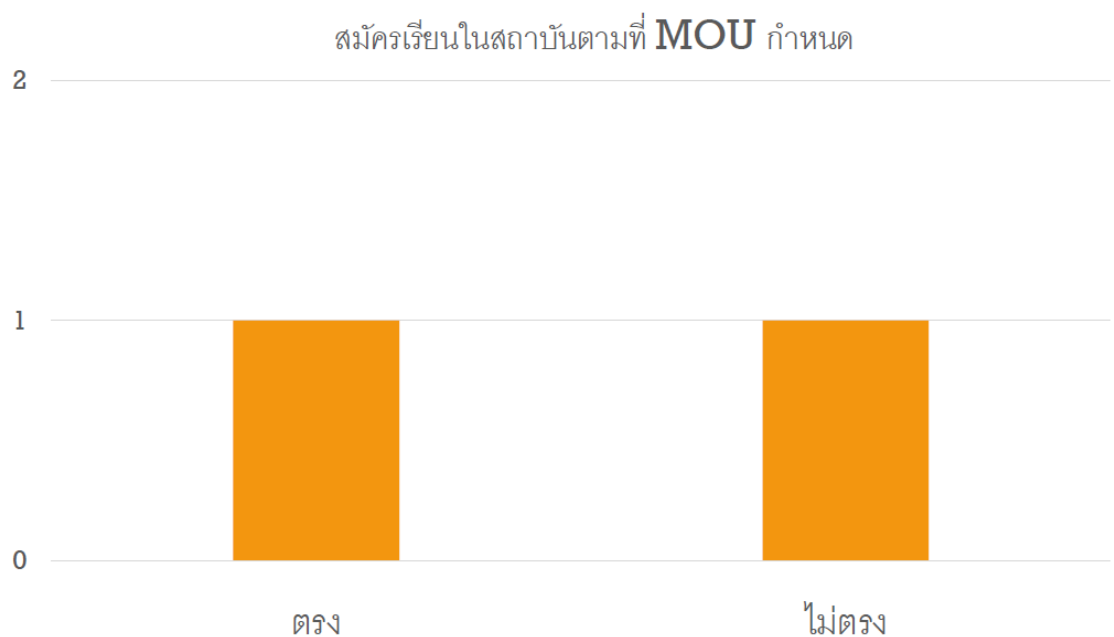
พบว่าเพศชายลาออกมากกว่าเพศหญิง สัดส่วน 7: 3 (เพศชายอดทนในการเรียนน้อยกว่าเพศหญิง)

5) ต้นสังกัด



พบว่าแพทย์ประจำบ้านที่สังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลาออก 7 คน
นอกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (มหาวิทยาลัย) 1 คน อิสระ 2 คน

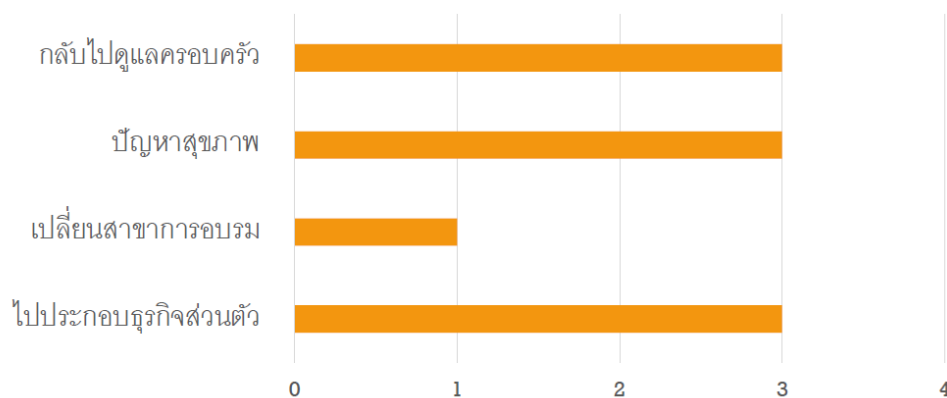
6) สมัครเรียนตามสถาบันที่ MOU กำหนด



พบว่า แพทย์ประจำบ้านที่ลาออกเรียนในสถาบันที่ตรงกับ MOU 1 คน ไม่ตรงกับสถาบันที่ MOU
1 คน

7) เหตุผลในการลาออกที่แจ้งต่อราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย

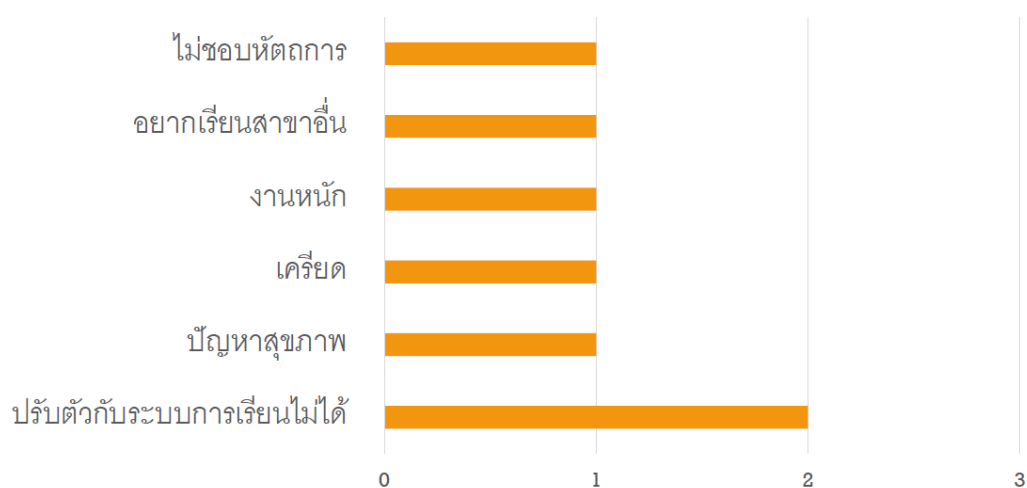
เหตุผลในการลาออกที่แจ้งต่อราชวิทยาลัยจักษุ



พบว่า กลับไปดูแลครอบครัว 3 คน มีปัญหาทางสุขภาพ 3 คน ไปประกอบธุรกิจ 3 คน เปลี่ยนสาขา 1 คน

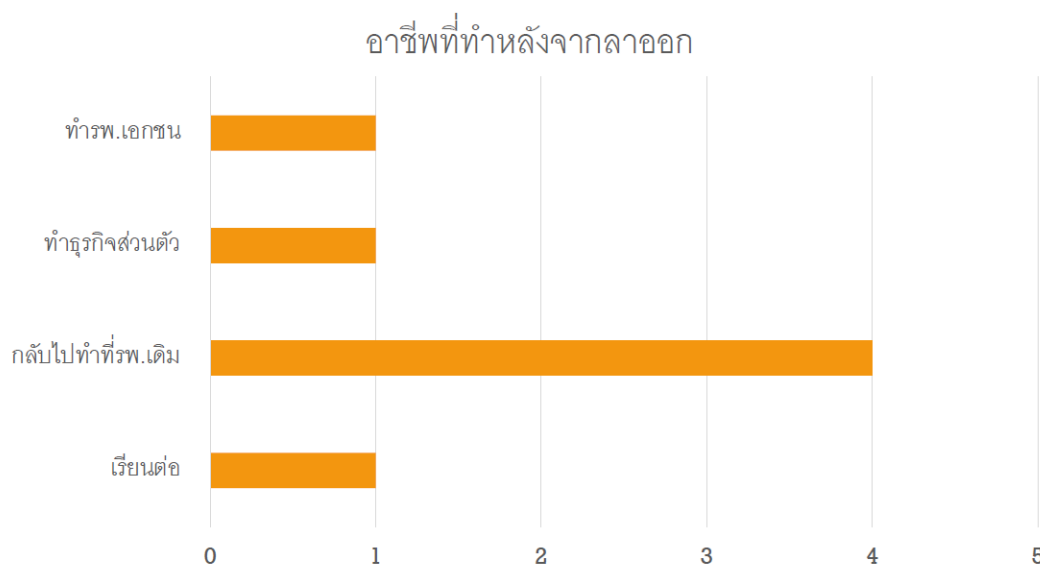
8) เหตุผลในการลาออกที่แท้จริง(โดยการโทรศัพท์ติดตามสัมภาษณ์ 7 คน จากทั้งหมด 10 คน)

เหตุผลในการลาออกที่แท้จริง



พบว่า ไม่ชอบหัตถการ อยากเรียนสาขาอื่น งานหนัก เครียด ปัญหาสุขภาพ (เหตุผลละ 1 คน) ปรับตัวกับระบบการเรียนไม่ได้ 2 คน

9) อาชีพที่ทำหลังจากลาออก



พบว่า ส่วนใหญ่กลับต้นสังกัดทำงานที่โรงพยาบาลเดิม ทำโรงพยาบาลเอกชน 1 คน ทำธุรกิจส่วนตัว 1 คน เรียนต่อ 1 คน

จากปัจจัย สาเหตุการลาออกของแพทย์ประจำบ้าน ที่ประชุมมีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้

1. ในกระบวนการสัมภาษณ์แพทย์ประจำบ้าน ควรแจ้งเรื่องการเรียนการสอนว่าต้องมีการทำหัตถการ และการผ่าตัด
2. ขอให้สถาบันฝึกอบรม ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่เขตสุขภาพ หากพบว่าผู้เรียนมีแนวโน้มเรียนไม่ไหว
3. ให้มีการคัดกรองผู้เรียนก่อน โดยให้มีการ Elective ณ สถาบันฝึกอบรม , โรงพยาบาลศูนย์ในเขตสุขภาพ ซึ่งสามารถรับรู้ สัมผัสผู้เรียนได้มากกว่าการคัดกรองโดยสัมภาษณ์แค่วันเดียว หลังการคัดกรอง สถาบันฝึกอบรมฯ ส่งข้อมูลเกี่ยวกับผู้เรียนให้พื้นที่ (เขตสุขภาพ , รพ.) เพื่อคัดเลือก และสอบสัมภาษณ์ ตามขั้นตอน
4. ในกระบวนการเรียนการสอน ทุกเขตสุขภาพควรมีโรงพยาบาลแหล่งฝึกเขตละ 2 โรงพยาบาล เพื่อให้แพทย์ประจำบ้านไป Elective ประโยชน์ ในมุมมองของเขตสุขภาพคือ ช่วยให้แพทย์ประจำบ้านรู้บริบทในการทำงาน รู้ระบบจักษุของกระทรวงสาธารณสุข สร้างเครือข่าย สร้างสัมพันธภาพเพื่อการทำงานและการส่งต่อ ในมุมมองสถาบันฝึกอบรมฯ จะช่วยให้แพทย์ประจำบ้านมีโอกาสทำหัตถการในสถานะที่เป็นจริงที่เขาจะจบออกไปทำงาน ลดปัญหาเรื่อง Case ทำหัตถการ และเขตสุขภาพได้มีส่วนร่วมในการเรียนการสอนแพทย์ประจำบ้าน
5. สถาบันฝึกอบรมฯ ควรสนับสนุนโรงพยาบาลที่รับแพทย์ประจำบ้านไป Elective เนื่องจากบางที่มีข้อจำกัดวัสดุอุปกรณ์ (แพทย์ประจำบ้านใช้วัสดุเปลือง)
6. การพัฒนาสถาบันฝึกอบรมของเขตสุขภาพ ควรเริ่มพัฒนาจากเป็นแหล่งฝึก (elective) ก่อน และพัฒนางานวิจัยร่วมกับสถาบันฝึกอบรมฯ เมื่อมีความเข้มแข็งสามารถฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านฯ ได้ จะฝึกอบรมตามแบบ บริบทการใช้งาน และความต้องการของกระทรวงสาธารณสุข ก็สามารทำได้ แต่ต้องผ่านตามเกณฑ์แพทยสภา

ที่ประชุม รับทราบ

1.2 เรื่องการจัดสรรจำนวนแพทย์ประจำบ้าน โดยผู้อำนวยการสำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (นายแพทย์ชวศักดิ์ กนกกันตพงษ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (สบพช.) แจ้งการจัดสรรทุนแพทย์ประจำบ้านสาขาจักษุ ประจำปีการศึกษา 2564 โดยคณะกรรมการจัดสรรทุนแพทย์ประจำบ้านของกระทรวงสาธารณสุข สรุปลำดับทุน 26 ตำแหน่ง โดยใช้โปรแกรมในการคำนวณ ไม่ได้สำรวจใหม่ และนำเสนอข้อมูลจักษุแพทย์ (ข้อมูล ณ มีนาคม 2563) ตามตาราง

ตารางที่ 1 จำนวนจักษุแพทย์ (อายุน้อยกว่า 53 ปี) แยกตามเขต hroph

เขต	เขต	เขต	เขต	เขต	เขต	เขต	เขต	เขต	เขต	เขต	เขต	รวม
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
39	28	14	42	55	53	26	28	27	31	34	32	409

ตารางที่ 2 จำนวนจักษุแพทย์ที่มีอยู่ในท่อ

เขต	เขต	เขต	เขต	เขต	เขต	เขต	เขต	เขต	เขต	เขต	เขต	รวม
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
18	14	15	14	20	21	8	17	16	18	21	18	200

ตารางที่ 3 จำนวนจักษุแพทย์ที่มีและที่อยู่ในท่อ

เขต	เขต	เขต	เขต	เขต	เขต	เขต	เขต	เขต	เขต	เขต	เขต	รวม
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
57	42	29	56	75	74	34	45	43	49	55	50	609

ตารางที่ 4 กรอบ min

เขต	เขต	เขต	เขต	เขต	เขต	เขต	เขต	เขต	เขต	เขต	เขต	รวม
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
33	23	16	32	42	41	20	29	28	26	31	28	349

ตารางที่ 5 GAP min

เขต	เขต	เขต	เขต	เขต	เขต	เขต	เขต	เขต	เขต	เขต	เขต	รวม
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
(24)	(19)	(13)	(24)	(33)	(33)	(14)	(16)	(15)	(23)	(24)	(22)	(260)

ตารางที่ 6 กรอบ max

เขต	เขต	เขต	เขต	เขต	เขต	เขต	เขต	เขต	เขต	เขต	เขต	รวม
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
53	36	26	53	68	65	30	47	42	42	50	47	559

ตารางที่ 7 GAP max

เขต	เขต	เขต	เขต	เขต	เขต	เขต	เขต	เขต	เขต	เขต	เขต	รวม
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
(4)	(6)	(3)	(3)	(7)	(9)	(4)	2	(1)	(7)	(5)	(3)	(50)

จากตารางที่ 1 ถึง 7 พบว่า จักขุแพทย์ที่อายุน้อยกว่า 53 ปี ในกระทรวงสาธารณสุข มีจำนวน 409 คน จักขุแพทย์ระหว่างการฝึกอบรม (ในท่อ) จำนวน 200 คน รวมจักขุแพทย์ทั้งสิ้น 609 คน อัตรากำลังจักขุแพทย์ตามสูตรการคำนวณคณะกรรมการจัดสรรทุนแพทย์ประจำบ้านกระทรวงสาธารณสุข กรอบ min เท่ากับ 349 คน กรอบ max เท่ากับ 559 คน พบว่าจำนวนจักขุแพทย์ที่มีอยู่ทั้งหมดเกินทั้ง กรอบ min และ กรอบ max โดยเกิน กรอบ max 50 คน

ที่ประชุม รับทราบ และแสดงความเห็นว่าจำนวนจักขุแพทย์ในท่อไม่ถูกต้อง จึงเสนอว่าควรมีทุนแพทย์ประจำบ้านสาขาจักขุ จำนวนทุน 45 ทุน ในปีการศึกษา 2564 พร้อมการจัดคู่ความร่วมมือระหว่างสถาบันฝึกอบรมกับเขตสุขภาพ (วาระ 3.1)

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
ไม่มี

วาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา

3.1 การจัดคู่ความร่วมมือระหว่างสถาบันฝึกอบรมกับเขตสุขภาพ

ประธาน ให้ผู้แทนเขตสุขภาพเสนอความต้องการทุนแพทย์ประจำบ้านสาขาจักขุ ปีการศึกษา 2564ตามสภาพความเป็นจริงเพื่อส่งมอบต่อให้ สปพช.และให้ผู้แทนสถาบันฝึกอบรมฯ แต่ละสถาบัน พิจารณาว่าจะสามารถรับฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาจักขุ ให้แก่เขตสุขภาพได้กี่คน

ผอ. สปพช. เสนอให้ปรับสัดส่วน จำนวนทุนที่เขตสุขภาพเสนอเทียบกับจำนวนทุนที่ได้จากการ คำนวณ (26 ตำแหน่ง) เพื่อให้เหมาะสมยิ่งขึ้น และแสดงความเห็นว่าการคำนวณอัตรากำลังจักขุแพทย์ ตามกรอบ Service plan พบข้อเสียบางประการ คือ กำหนดอัตรากำลังตามขนาดโรงพยาบาล ทำให้เกิดข้อได้เปรียบ – เสียเปรียบ และไม่สอดคล้องกับภาระงานจริง เขตสุขภาพที่มีโรงพยาบาลขนาดใหญ่จำนวนมากจะได้เปรียบ เขตสุขภาพที่มีโรงพยาบาลขนาดเล็กใหญ่น้อยจะเสียเปรียบ

ที่ประชุมได้เสนอให้กำหนดจำนวนทุนทั้งหมด 45 ทุน เพื่อรองรับกรณีต่างๆ เช่น จักขุแพทย์ลาออก หรือไปเป็นผู้บริหาร

สรุปจำนวนทุนแต่ละเขตสุขภาพและการจัดคู่มือระหว่างสถาบันฝึกอบรมกับเขตสุขภาพ ตามตารางที่ 8

ตารางที่ 8 ความต้องการทุนแพทย์ประจำบ้านสาขาจักษุ ปีการศึกษา 2564 และการจัดคู่มือระหว่างสถาบันฝึกอบรมกับเขตสุขภาพ

จำนวนทุนที่รับฝึกอบรมโดยประมาณระหว่างคู่มือโรงเรียนแพทย์กับเขตสุขภาพ ปี 2564

เขต	โควตาสรุปจากที่ประชุม	โควตา เดิมจากสภพ	จุฬา 6/10	ศิริราช 5/10	รามา 6/8	มช. 4/5	มข. 4/4	มอ. 4/6	ราชวิถี 4/7	พระมงกุฎ 1/5	เมตตา 3/7	มร. 6/9	วชิร 2/4	รวมทุน 45	สถาบันอบรม
1	3	2	1			2									เชียงใหม่ 2 , จุฬา 1
2	3	2		1		2									เชียงใหม่ 2 , ศิริราช 1
3	3	2		1	1							1			รามา 1, ธรรมศาสตร์ 1, ศิริราช 1
4	4	2	1							1		2			ธรรมศาสตร์ 2, จุฬา 1, พระมงกุฎ 1
5	3	2	1	1					1						ศิริราช 1, จุฬา 1, ราชวิถี 1
6	3	2	1		1				1						จุฬา 1, ราชวิถี 1, รามา 1
7	3	2		1			1				1				ขอนแก่น 1, เมตตา 1, ศิริราช 1
8	4	3	1				1		1				1		จุฬา 1, ขอนแก่น 1, ราชวิถี 1, วชิร 1
9	6	4	1		3		1						1		รามา 3, จุฬา 1, ขอนแก่น 1, วชิร 1
10	6	2		1	1		1		1			2			ขอนแก่น 1, ธรรมศาสตร์ 2, ศิริราช 1, รามา 1, ราชวิถี 1
11	4	2						2			2				สงขลา 2, เมตตา 2
12	3	1						2				1			สงขลา 2, ธรรมศาสตร์ 1
รวม	45	26	6	5	6	4	4	4	4	1	3	6	2		

ที่ประชุม รับทราบและแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้

1. เขตสุขภาพที่ 2 : ประเด็นการขอทุนฯ ให้โรงพยาบาลอุ้มผางจังหวัดตาก จำนวน 2 ทุน ควรขอเป็นทุนจังหวัดตาก และให้เป็นเรื่องการบริหารจัดการภายในโดยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก
2. ให้คงขั้นตอนการกลั่นกรองผู้สมัครเรียนแพทย์ประจำบ้านฯ เหมือนปีที่ผ่านมา (2563)
3. ในขั้นตอนการกลั่นกรองผู้สมัครเรียนแพทย์ประจำบ้านฯ แต่ละเขตสุขภาพควรส่งผู้สมัครมาสัมภาษณ์ให้มากกว่าโควตาที่ได้รับ เพื่อให้สถาบันฝึกอบรมมีตัวเลือก และลดปัญหาการ lock spec
4. ในกระบวนการเรียนการสอน ทุกเขตสุขภาพควรมีโรงพยาบาลแหล่งฝึกเขตละ 2 โรงพยาบาล เพื่อให้แพทย์ประจำบ้านไป Elective ประโยชน์ ในมุมมองของเขตสุขภาพคือ ช่วยให้แพทย์ประจำบ้านรู้บริบทในการทำงาน รู้ระบบจักษุของกระทรวงสาธารณสุข สร้างเครือข่าย สร้างสัมพันธภาพเพื่อการทำงานและการส่งต่อ ในมุมมองสถาบันฝึกอบรมฯ จะช่วยให้แพทย์ประจำบ้านมีโอกาสทำหัตถการในสภาวะที่เป็นจริงที่เขาจะจบออกไปทำงาน ลดปัญหาเรื่อง Case ทำหัตถการ และเขตสุขภาพได้มีส่วนร่วมในการเรียนการสอนแพทย์ประจำบ้าน
5. สถาบันฝึกอบรมฯ ควรสนับสนุนโรงพยาบาลที่รับแพทย์ประจำบ้านไป Elective เนื่องจากบางที่มีข้อจำกัดวัสดุอุปกรณ์ (แพทย์ประจำบ้านใช้วัสดุเปลือง)
6. การพัฒนาสถาบันฝึกอบรมของเขตสุขภาพ ควรเริ่มพัฒนาจากเป็นแหล่งฝึก (elective) ก่อน และพัฒนางานวิจัยร่วมกับสถาบันฝึกอบรมฯ เมื่อมีความเข้มแข็งสามารถฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านฯ ได้ จะฝึกอบรมตามแบบ บริบทการใช้งาน และความต้องการของกระทรวงสาธารณสุข ก็สามารถทำได้ แต่ต้องผ่านตามเกณฑ์แพทย์สภา

วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ

4.1 เรื่องประชุมวิชาการสัจจร โดยประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาจักษุ (แพทย์หญิงอัจฉรา อภิญาสกุล)

ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาจักษุ แจ้งว่าได้ทำแผนประชุมวิชาการสัจจรไว้ แต่ไม่แน่ใจว่าจะสามารถดำเนินตามแผนได้หรือไม่ เนื่องจากสถานการณ์ Covid 19 วัตถุประสงค์การจัดประชุมวิชาการสัจจรเพื่อสื่อสาร ถ่ายทอด ให้จักษุแพทย์ในพื้นที่ที่ราบเกี่ยวกับการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาจักษุ ด้านนโยบายและงานต่างๆที่กำลังดำเนินการ เพื่อลดช่องว่างความไม่เข้าใจ ระหว่าง ผู้ปฏิบัติกับเรื่องเชิงนโยบาย

สถานที่จัดประชุม : โรงพยาบาลในเขตสุขภาพ เน้นจังหวัดที่มีสนามบิน เดินทางสะดวก

วิทยากร : จักษุแพทย์ในพื้นที่และอาจารย์จากสถาบันฝึกอบรมฯ คู่ความร่วมมือ

กลุ่มเป้าหมาย : จักษุแพทย์ , แพทย์ประจำบ้านฯ พยาบาลเวชปฏิบัติทางตา

รูปแบบ : ใช้วิชาการนำ แต่มี Part service plan ในส่วนวิชาการเป็นการ Update วิชาการ เน้น Practical clinical ที่ต้องนำไปใช้ในการปฏิบัติงานประจำ , pigfall ไม่ใช่วิชาการขั้นสูง ส่วน Service plan จะพูดเกี่ยวกับงานทางจักษุที่คณะกรรมการฯ ดำเนินการ , การแก้ไขปัญหา blinding cataract

ระยะเวลา : 1 วัน

ค่าใช้จ่าย : ขอลงสนับสนุนจากภาคเอกชน สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายของวิทยากรนอกพื้นที่ (ค่าเดินทาง ที่พัก ค่าสมนาคุณวิทยากร) ส่วนค่าใช้จ่ายของจักษุแพทย์ในพื้นที่ (ค่าสมนาคุณวิทยากร) เบิกจากต้นสังกัด

สรุปการจัดประชุมวิชาการสัจจร ตามตารางที่ 9

ตารางที่ 9 สถานที่และวิทยากร ประชุมวิชาการสัจจร ใน 12 เขตสุขภาพ

เขตสุขภาพ	สถานที่	วิทยากร
1	จังหวัดเชียงใหม่	มช. , วชิระ
2	จังหวัดพิษณุโลก	มช.
3	จังหวัดนครสวรรค์	มธ. , รามา , เมตตาฯ
4	จังหวัดอยุธยา	มธ. , พระมงกุฎ
5	จังหวัดสมุทรสาคร	ศิริราช, จุฬา , เมตตาฯ
6	จังหวัดชลบุรี	จุฬา , ราชวิถี
7	จังหวัดขอนแก่น	} มช. , เมตตาฯ
8		
9	จังหวัดบุรีรัมย์	} รามา
10	จังหวัดอุบล	
11	จังหวัดสงขลา (หาดใหญ่)	} มอ.
12		

ที่ประชุม รับทราบ

4.2 การตรวจผู้ป่วยจักขุ มีประวัติเสี่ยงติดต่อ Covid 19

มติที่ประชุม ให้แต่ละที่กำหนดแนวทางของตนเอง เพิ่มความระมัดระวังในผู้ป่วยตาแดง

4.3 เรื่องจากนายแพทย์วรภัทร วงษ์สวัสดิ์

4.3.1 เรื่องแพทย์ประจำบ้านสาขาจักขุ

นายแพทย์วรภัทร วงษ์สวัสดิ์ สรุปลำดับขั้นตอนสู่การเป็นแพทย์ประจำบ้านสาขาจักขุ 6 ขั้นตอน 2 ระยะ เริ่มตั้งระยะก่อนจบ ขณะเป็นนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 Rotate ตา ทำอย่างไรให้น้องประทับใจจักขุ จบแล้วไปใช้ทุนพื้นที่ สมครเรียน , เรียน , สอบ Board จบเป็นจักขุแพทย์ , พัฒนาฟื้นฟูความรู้ (เก็บหน่วยกิต : CME) พบว่าช่วงที่จบแล้วไปใช้ทุนในพื้นที่ น้องไม่ค่อยทราบข้อมูลในพื้นที่ว่า ที่ใดขาดจักขุแพทย์ จักขุจะลาออกหรือเกษียณเมื่อใด จะพัฒนาจักขุไปทางไหน ทำให้คาดคะเนยาก ตัดสินใจยากกว่าควรจะไปใช้ทุนที่ไหน ที่ไหนมีทุนเรียนจักขุ เขตสุขภาพควรมีแผนที่ชัดเจน

ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาจักขุ รับไปดำเนินการในภาพรวมของ service plan ถือเป็นเรื่องการพัฒนาบุคลากร และเห็นว่ากระทรวงสาธารณสุขควรมีเวที สื่อสาร ถ่ายทอดให้แพทย์ใช้ทุนทราบเกี่ยวกับการเป็นแพทย์เฉพาะทางสาขาต่างๆ

4.3.2 เรื่องทีมโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) ขอพ่วงไปกับกิจกรรมประชุมวิชาการสัญจร 12 เขตสุขภาพ

สืบเนื่องจากโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) มีกิจกรรมทางจักขุหลายเรื่อง ได้แก่ การขับเคลื่อนศูนย์จอตา (Retina center) ศูนย์ Tele Ophthalmology (โครงการ Telehealth ตามความร่วมมือระหว่าง กสทช. กับกระทรวงสาธารณสุข) ซึ่งมีแผนเยี่ยมติดตามศูนย์ดังกล่าว จึงขอพ่วงไปพร้อมกับการประชุมวิชาการสัญจร 12 เขตสุขภาพ ในจังหวัดที่ตรงกับ ศูนย์จอตา (Retina center) ศูนย์ Tele Ophthalmology โดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง

ที่ประชุม รับทราบ

4.4 เรื่อง Covid 19 โดยประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาจักขุ

ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาจักขุ แจ้งเรื่องข้อเสนอของกระทรวงสาธารณสุขต่อคณะกรรมการ Covid แห่งชาติ ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ Covid 19 โดยเสนอ 3 เรื่อง คือ

1) งดคนเข้า

- ไม่ให้เครื่องบินจากประเทศที่ถูกประกาศเป็นโรคติดต่อร้ายแรง เข้าจอดในประเทศไทย , งด visa on arrival
- คนที่มาจากประเทศที่ถูกประกาศว่ามีการระบาดต่อเนื่อง ทั้งคนไทยและต่างชาติ ต้องถูกกักตัว 14 วัน คนไทยที่มีไข้ แยกไป admit คนต่างชาติที่มีไข้ ส่วนใหญ่ส่งกลับประเทศ ไม่ให้เข้าประเทศไทย

2) งดคนออก

- งดจัดทัวร์ ไปประเทศที่มีการระบาด Covid 19

3) หลีกเลี่ยงพื้นที่ชุมชน

- ห้ามชุมนุมที่มีคนเกิน 100 คน ถ้าเกิน 50 คนแต่ไม่ถึง 100 คนต้องชี้แจงและขออนุมัติผู้บริหารองค์กร

การเตรียมความพร้อมของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อรับสถานการณ์ Covid 19

- เรื่องการควบคุมโรค ตาม พรบ.โรคติดต่อร้ายแรง ปี 2558 ให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเป็นเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจตามกฎหมายในการกักตัว
- รพ.ทุกแห่งของกระทรวงสาธารณสุข ทำแผนเฟส 3 รองรับไว้แล้ว
- ห้อง lab ให้ 1 เขต มีอย่างน้อย 1 รพ.ที่สามารถเป็น center ตรวจ ถ้า positive ไม่จำเป็นต้อง recheck เพื่อให้เร็วขึ้น
- เตรียมเครื่อง respiratory
- เตรียม cohort ward สำหรับ case positive
- เตรียมยา favipiravir กำลังขออนุญาตนำเข้าจากญี่ปุ่น จีน
- เตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันการติดเชื้อ : PPE , surgical mask , N95 ที่เป็นปัญหายังมีไม่เพียงพอคือ PPE และ N95 ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ

ที่ประชุม รับทราบ

ปิดประชุม เวลา 12.00 น.